



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN BULAN FEBRUARI
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
2024**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang
Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874
Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com

DAFTAR ISI

Daftar Isi..... i

Bab I Pendahuluan 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Tujuan 1

Bab II Gambaran Umum Rumah Sakit Prima Husada Malang 2

 A. Visi 2

 B. Misi 2

 C. Motto 2

 D. 7 Nilai Budi Utama 2

 E. Struktur Organisasi 3

Bab III Laporan Kinerja Pelayanan 5

 A. Profil Pelayanan 5

 a. Kunjungan Pasien Rawat Inap 5

 b. Kunjungan Pasien Rawat Jalan..... 5

 c. Review Hasil Kunjungan dengan PDSA 6

 d. Profil Tempat Tidur Profil Tempat Tidur..... 6

 B. Profil Pelayanan Antrian Online 7

 a. Menampilkan Dashboard Layanan Antrian Online bulan Terakhir 7

 b. Analisa 8

 C. Indikator Kerja 9

 a. BOR, LOS, BTO dan TOI 2024 9

 b. Evaluasi Hasil BOR, LOS, BTO dan TOI 10

 c. Klaim Pending 10

 a) Analisis..... 10

 b) Tindak Lanjut..... 10

 D. Data Mutu/Keselamatan Pasien 10

 E. Permasalahan Rumah Sakit 40

 F. Profil SDM 44

 a. Komposisi dan Distribusi SDM 44

 b. Update STR/SIP 46

 G. Kemajuan Piutang..... 47

 a. Data Piutang yang Belum Terbayar 47

 b. Analisa Progres Penyelesaian Piutang..... 47

 c. Update IKS..... 48

 H. Program Nasional 60

 a. PONEK 60

 b. TB Dots..... 71

 c. HIV..... 79

 d. Stunting & Wasting..... 87

 e. KBRS 94

Bab IV Data Utilitas Unit..... 97

 A. Pelayanan Medis..... 97

 a. Tabel Data Kamar Operasi..... 97

 b. Tabel Data Instalasi Rawat Jalan 98

c. Tabel Data Instalasi Rawat Inap.....	101
d. Tabel Data Instalasi Gawat Darurat (IGD).....	102
B. Penunjang Medis	103
a. Tabel Data Laboratorium.....	103
b. Tabel Data Radiologi.....	104
c. Tabel Data Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS)	105
d. Tabel Data Laundry.....	107
e. Tabel Data CSSD.....	107
f. Tabel Data Instalasi Gizi	108
Bab V Kesimpulan dan Saran.....	111
Bab VI Penutup.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan rumah sakit dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja rumah sakit dalam hal ini Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban Rumah Sakit Prima Husada Malang untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi Rumah Sakit Prima Husada Malang dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja juga sebagai alat ukur keberhasilan Rumah Sakit dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama yang dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan dan sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan dibidang kesehatan berkelanjutan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, penunjang dan tindakan medik.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Bulan Februari Tahun 2024 adalah untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan pelayanan antar unit untuk meningkatkan kinerja rumah sakit

BAB II
GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

A. VISI

Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilahan seluruh lapisan masyarakat

B. MISI

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan dengan Aman, Tepat, Cepat dan Akurat
2. Mengutamakan Kepuasan dan Keselamatan Pasien
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan yang Berkelanjutan

C. MOTTO

Sahabat Menuju Sehat

D. 7 NILAI BUDI UTAMA

1. Jujur
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

E. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan struktur Organisasi Rumah Sakit Prima Husada Malang sebagai berikut :

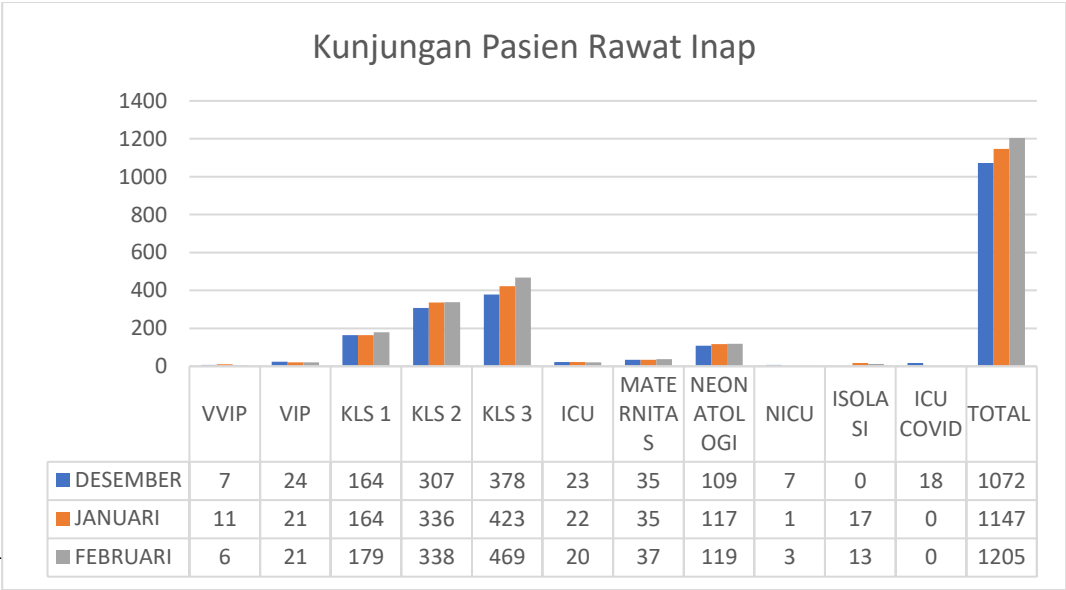
NO	JABATAN	NAMA	NO SK JABATAN	TANGGAL JABATAN
1	PLT Direktur RS Prima Husada	dr. Nur Mazidah	01.204/DPM/I-KEP/DIR/I/2024	1 Februari 2024
3	Satuan Pemeriksaan Internal (SPI)	dr. Arief Heru Wicaksono, Sp.A	1451/I-KEP/DIR/X/2020	1 November 2020
		Dwi Novianti, Amd.AK, S.Kes	397/I-KEP/DIR/V/2021	28 Mei 2021
4	PLT Kepala Bidang Pelayanan Medis	dr. Wiryantari Akhdani Pratiwi ur Mazidah	002.4/DPM/I-KEP/DIR/II/2024	2 Agustus 2023
5	PLT Kepala Bidang Penunjang Medis	Putri Indah Purnamasari, Amd. Keb	1153/I-KEP/DIR/XI/2023	13 Februari 2024
6	Kepala Bidang Keperawatan	Ns. Very Susanto, S.Kep	974.1/I-KEP/DIR/X/2023	4 Oktober 2023
7	Kepala Bidang Umum dan Keuangan	dr. Endy Wira Pradana, MMRS		
7	Kepala Instalasi Rawat Inap	dr. Yoga Waranugraha, Sp.JP (K)	033/I-KEP/DIR/I/2024	11 Januari 2024
	1) Kepala Ruang Rawat Inap 2C	Indah Maulhayati, S.Kep.Ns	006.4/I-KEP/DIR/I/2023	2 Januari 2023
	2) MKepala Ruang Rawat Inap 6A, 7A, 8A	Murwani Suryaning Sapartinah, S. Kep., Ns	1154/I-KEP/DIR/XI/2023	13 November 2023
	3) Kepala Ruang Rawat Inap 3C	Khusnul Khotimah, S.Kep.,Ns	428.58/I-KEP/DIR/VI/2021	22 Juni 2021
	4) Kepala Ruang Rawat Inap 3A, 4A	Wiwit Indah Yanti, S.Kep.,Ns	1190.21/I-KEP/DIR/VIII/2020	15 Agustus 2020
	5) Kepala Ruang Rawat Inap 5C	Amilatul Kholifah	659/I-KEP/DIR/VII/2023	1 Juli 2023
	6) Kepala Ruang Rawat Inap Maternitas	Siti Zaimah, AMd.Keb	1196.7/I-KEP/DIR/VII/2022	26 Juli 2022
	7) Kepala Ruang Neonatologi	Dhora Putri Meryda, S.Kep.Ns	2272.4/I-KEP/DIR/XII/2022	26 Desember 2022
8	Kepala Instalasi Kamar Operasi	dr. Arief Heru Wicaksono, Sp.A	004.16/I-KEP/DIR/I/2019	2 Januari 2019
	1) Kepala Ruang IKO	Siti Durotul Ibadih., S. Kep.,Ns	039.22/I-KEP/DIR/I/2018	2 Januari 2018
9	Kepala Intensive Care Unit	dr. Arief Heru Wicaksono, Sp.A	004.14/I-KEP/DIR/2019	2 Januari 2019
	1) Kepala Ruang ICU	Risma Indra Setiyani, S.Kep.,Ns	651/I-KEP/DIR/V/2022	26 Mei 2022
10	PLT Kepala Instalasi Gawat Darurat	dr. Reza Muchlas Fauziansyah	161.1/I-KEP/DIR/III/2024	7 Februari 2024
	1) Kepala Ruang IGD	Afni Nur Ainy, S.Kep.Ns	2272.3/I-KEP/DIR/XII/2022	26 Desember 2022
11	Kepala Instalasi Rawat Jalan	dr. Dwi Nurwulan Pravitasari, Sp. KK	004.4.2/I-KEP/DIR/I/2019	2 Januari 2019
	1) Kepala Ruang Rawat Jalan	Puput Sekar Nari Ratih, AMd.Keb	2272.1/I-KEP/DIR/XII/2022	26 Desember 2022
12	Kepala Instalasi Farmasi	Apt. Pipin Purwa Ningrum, S.Farm	777.1/I-KEP/DIR/VIII/2023	08 Agustus 2023
13	Kepala Instalasi Rekam Medik	Rina Tri Wahyuni, AMd.RMIK	2272.6/I-KEP/DIR/XII/2022	26 Desember 2022
14	Kepala Instalasi Laboratorium	dr. Ari Putriani, Sp. PK	004.25/I-KEP/DIR/I/2019	2 Januari 2019
	1) Kepala Unit Laboratorium	Yoga Eka Ramadhani Ariwa, AMd.AK	1345.4/I-KEP/DIR/VIII/2022	26 Agustus 2022

15	Kepala Instalasi Radiologi	dr. Agung Setyawan, Sp.Rad	401/I-KEP/DIR/VI/2019	17 Juli 2020
	1) Kepala Unit Radiologi	Ayu Bintang Tinara, Amd. Rad	004.28/I-KEP/DIR/I/2019	2 Januari 2019
16	Kepala Unit Sterilisasi (CSSD) dan Laundry	Ahmad Taufan Fauzi, Amd. Kep	120/I-KEP/DIR/I/2024	30 Januari 2024
17	Kepala Instalasi Gizi	-	-	-
	1) Kepala Unit Gizi	Veni Lestari Puri Purnami., Amd. Gz	004.30/I-KEP/DIR/I/2019	2 Januari 2019
18	Kepala bidang Umum	dr. Endy Wira Pradana, MMRS		
	1) Kesekretariatan	Mahesa Yudistiranti,S.AP	1255.3/I-KEP/DIR/XII/2023	01 Desember 2023
	2) Kepala Unit SDM & Diklat			
	3) Kepala Unit Keuangan dan Akuntansi	Novi Ratnasari, S.E	103.1/I-KEP/DIR/II/2021	26 Februari 2021
	4) Kepala Unit SIMRS & IT	Ramadhian Anshari, S.Kom	153.14/I-KEP/DIR/III/2021	26 Maret 2021
	5) PLT Kepala Instalasi Prasarana dan Sarana Rumah Sakit	Muhammad Arifin	240/I-KEP/DIR/II/2024	-
	6) Kepala Unit Security & Parkir	M. Rizal., S.E	004.40/I-KEP/DIR/I/2019	2 Januari 2019
	7) Kepala Unit Umum Cleaning Service	Erik Ardinata	155/E-KEP/DIR/II/2024	30 Januari 2024
	8) Kepala Unit Asuransi Center	Nur Rizkiah Amalia	1560/I-KEP/DIR/X/2022	5 Oktober 2022
20	Ketua Komite Medis	dr. Arief Heru Wicaksono, Sp.A	1185/I-KEP/DIR/VII/2022	25 Juli 2022
21	Ketua Komite Keperawatan	Artika Wulandari, S.Kep., Ns	839/I-KEP/DIR/VIII/2023	14 Agustus 2023
22	Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain	Veni Lestari Puri Purnami, AMd.Gz	116/I-KEP/DIR/II/2023	6 Februari 2023
23	Ketua Komite PPI	dr. Aida Musyarofah, Sp.OG	-	-
	1) IPCN	Sherly Rosita, S.Kep.,Ns	068.2/I-KEP/DIR/II/2020	3 Februari 2020
24	Ketua Komite Etik Rumah Sakit	dr. Ari Putriani, Sp.PK	001.4/I-KEP/DIR/I/2022	4 Agustus 2022
25	Ketua Komite Farmasi & Terapi	dr. Sadi Hariono, MMRS	175.3/I-KEP/DIR/II/2022	1 Februari 2022-
26	Ketua Tim P2K3RS	-	-	-
27	Ketua Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba	dr. Dicky Faturrachman, Sp.A.,M.Biomed	001.5/I-KEP/DIR/I/2022	1 Januari 2022

BAB III
LAPORAN KINERJA PELAYANAN

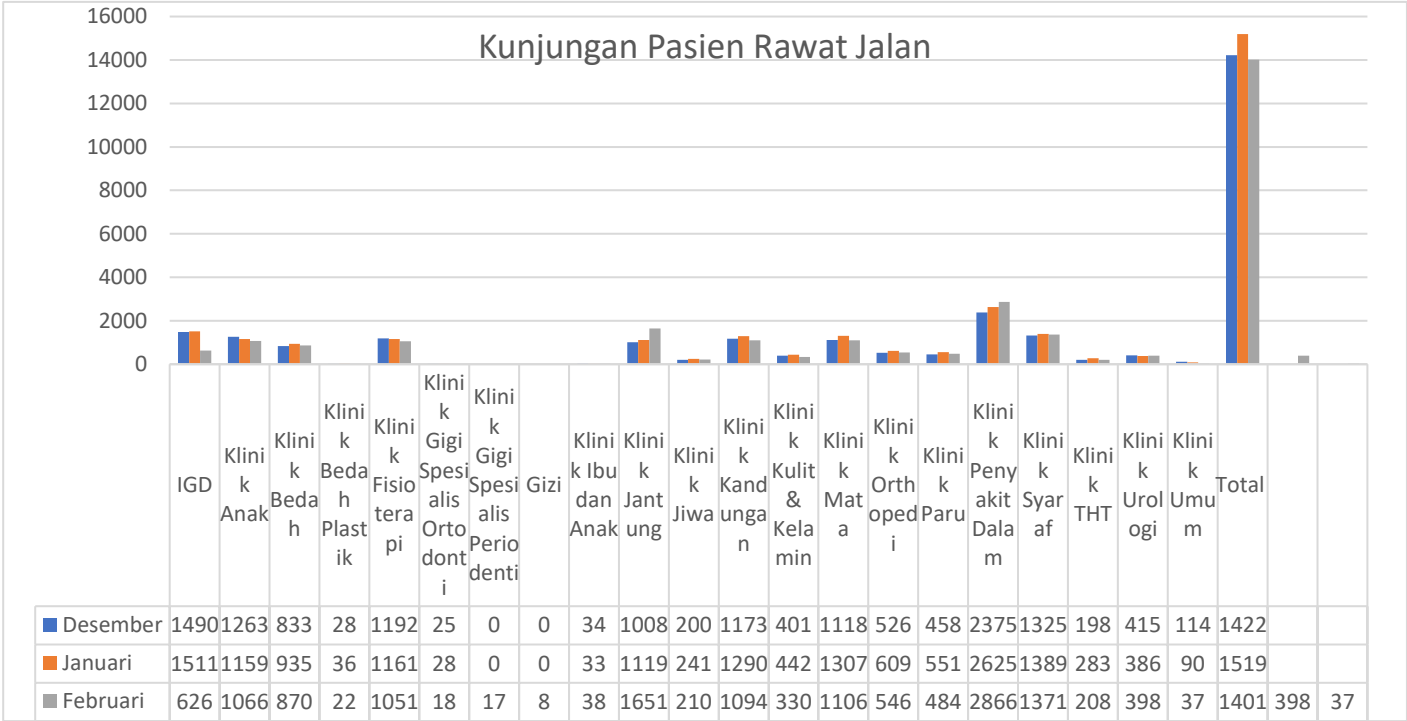
A. Profil Pelayanan

a. Kunjungan Pasien Rawat Inap



Berdasarkan pada grafik diatas, kunjungan pasien rawat inap di RS Prima Husada Malang mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya. Dimana pasien rawat inap pada bulan Januari di angka 1147 dan mengalami kenaikan di bulan Februari di angka 1205. Kunjungan pasien rawat inap di bulan Februari mengalami kenaikan sebesar 5% dari bulan sebelumnya.

b. Kunjungan Pasien Rawat Jalan



Berdasarkan grafik kunjungan diatas pasien rawat jalan yang berkunjung ke RS Prima Husada Malang mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kunjungan pasien rawat jalan pada bulan Januari sebesar 15.195 kunjungan, bulan Februari sebesar 14.018 Dimana kunjungan pasien rawat jalan pada bulan Februari mengalami penurunan sebesar 7,7% dari jumlah kunjungan bulan sebelumnya. Kunjungan pasien di Poli Penyakit Dalam masih menduduki kunjungan paling banyak dari seluruh poli yang ada di RS Prima Husada Malang.

c. Review Hasil Kunjungan dengan PDSA

Plan	1. Mempertahan tren peningkatan pasien rawat inap 2. Meningkatkan kunjungan Poli dengan menambah slot jadwal dokter spesialis 3. Menambah dokter spesialis agar slot terpenuhi 4. Melakukan penertiban dan evaluasi jadwal praktek dokter di Poli 5. Menjaring lebih banyak pasien lewat promosi dan marketing melalui media online 6. Mengaplikasikan daftar kehadiran dokter praktek di Poli dalam SIMRS yang terintegrasi dengan ERM 7. Mempercepat alur penerimaan rujukan luar
Do	1. Mengurangi jumlah rujukan ke luar dengan meningkatkan komunikasi pada DPJP 2. Publikasi info rekrutmen dokter spesialis via WA dan IG 3. Meningkatkan kinerja humas dan marketing ke perusahaan, FKTP dan BPM untuk meningkatkan jumlah pasien 4. Koordinasi dengan DPJP untuk penambahan jadwal dokter praktek 5. Mengevaluasi keterlambatan DPJP 6. Membuat SOP alur rujukan luar
Study	1. Keterlambatan dan ketidakhadiran dokter di RS akan mempengaruhi kinerja pelayanan di RS 2. Pelayanan yang kurang baik akan memunculkan complain dari pasien 3. Masih ada DPJP masih merujuk pasien dengan alasan proporsi
Action	1. Berkomunikasi dengan DPJP untuk tidak merujuk pro ventilator karena RSPHM memiliki ventilator

d. Profil Tempat Tidur

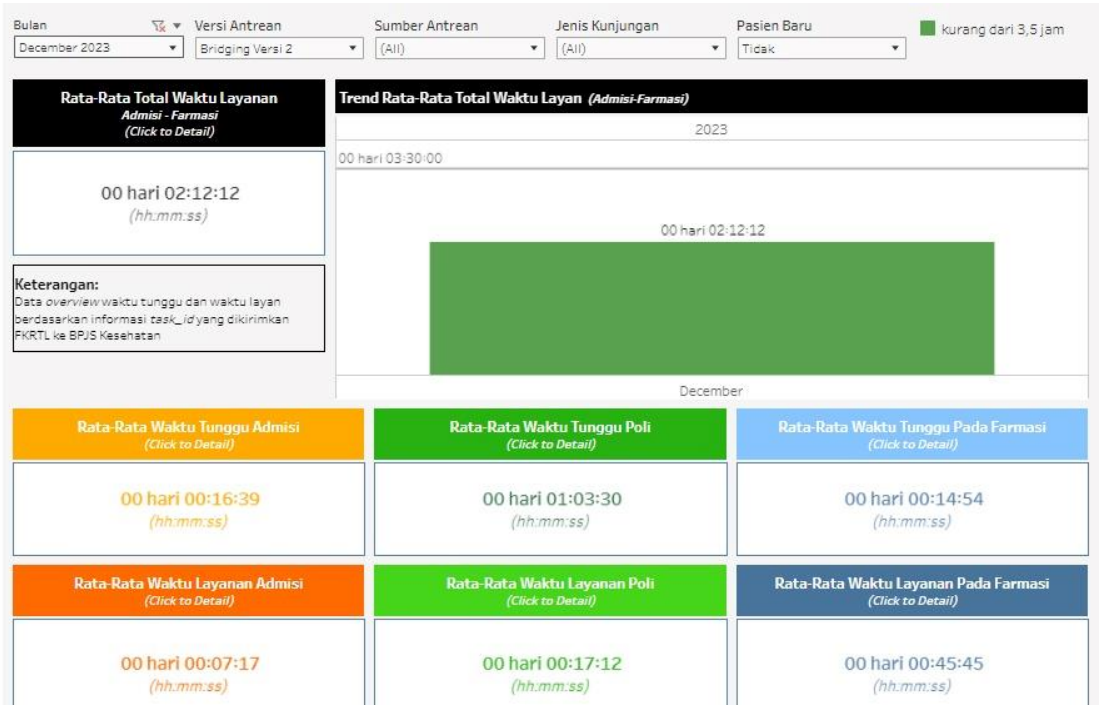
NO	JENIS KELAS	JUMLAH	PROSENTASE
1	Kelas VVIP	3	2%
2	Kelas VIP	3	2%
3	Kelas 1	17	12%
4	Kelas 2	38	28%
5	Kelas 3	49	35%
6	Perawatan Intensive		
	ICU Dengan Ventilator	8	6%
7	HCU	2	1%
8	NICU	6	4%
9	Isolasi		
	Isolasi Tekanan Negatif	9	10%
	Isolasi <i>Immunocompromise</i>	5	
TOTAL		140	100%

Nb : SK No 701/KEP/DIR/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Tempat Tidur untuk Pelayanan Asuhan Pasien

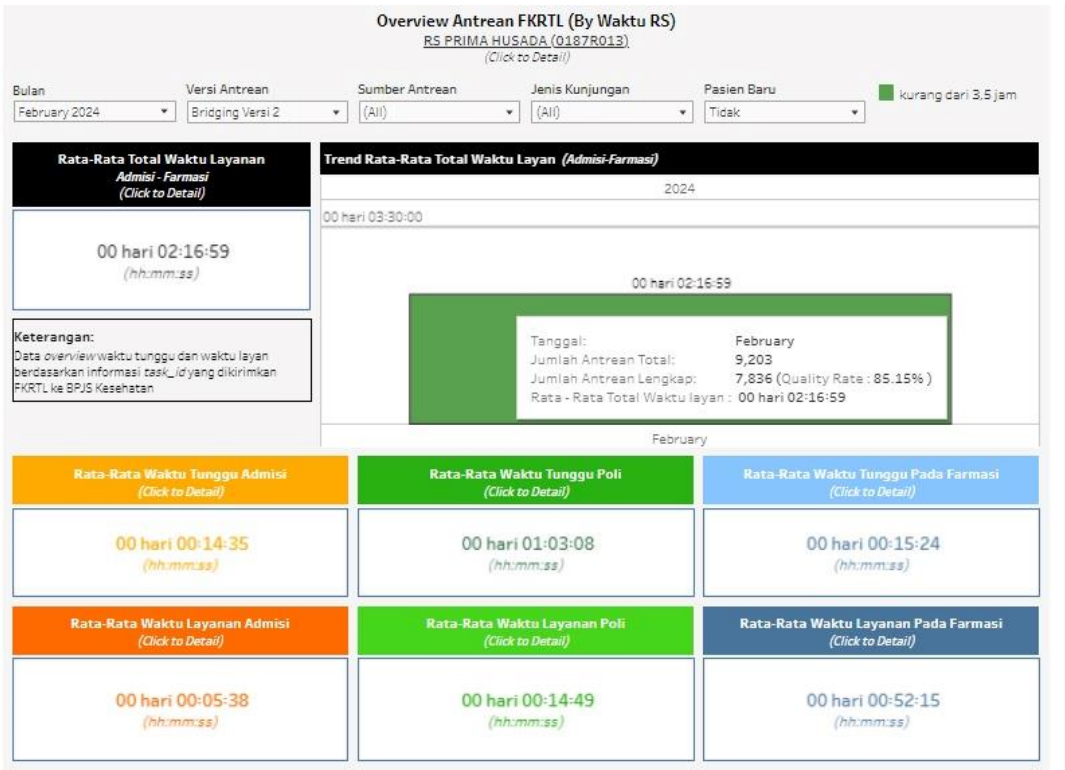
B. Profil Pelayanan Antrian Online

1. Menampilkan Dashboard Layanan Antrian Online

Desember 2023



Februari 2024



Feedback dari BPJS untuk bulan Desember 2023

No	Kode Faskes	Nama FKRTL	Jumlah SEP RJTL Terbit	Pemanfaatan Antrean Online			
				Bridging	Mobile JKN	All Sumber	% (>=80)
			a	b	c	d (b+c)	e (d/a)
1	0212R014	RS BHIRAWA BHAKTI	1.722	1.669	22	1.691	98%
2	1324R037	RS MARSUDI WALUYO	2.697	2.169	451	2.620	97%
3	0212R028	RSUD Kota Malang	1.571	1.258	267	1.525	97%
4	0187R013	RS PRIMA HUSADA	8.525	5.280	2.985	8.265	97%
5	0212R012	RSU PERMATA BUNDA	944	803	112	915	97%
6	0212R009	RS ISLAM MALANG UNISMA	3.816	3.636	42	3.678	96%
7	0212R022	RSIA MUHAMMADIYAH MALANG	369	334	14	348	94%
8	0187R019	RS SUMBER SENTOSA	679	604	36	640	94%

NO	JENIS	OKT '23	NOV '23	DES '23	JAN '24	FEB '24
1	Jumlah SEP RJTL Terbit	9.006	8.425	8.525	Data belum dikirim BPJS	Data belum dikirim BPJS
2	Bridging	4.884	5.269	5.280	Data belum dikirim BPJS	Data belum dikirim BPJS
3	Mobile JKN A	342	2.691	2.985	Data belum dikirim BPJS	Data belum dikirim BPJS
4	All Sumber	5.226	7.960	8.265	Data belum dikirim BPJS	Data belum dikirim BPJS
5	%	58%	94%	97%	Data belum dikirim BPJS	Data belum dikirim BPJS

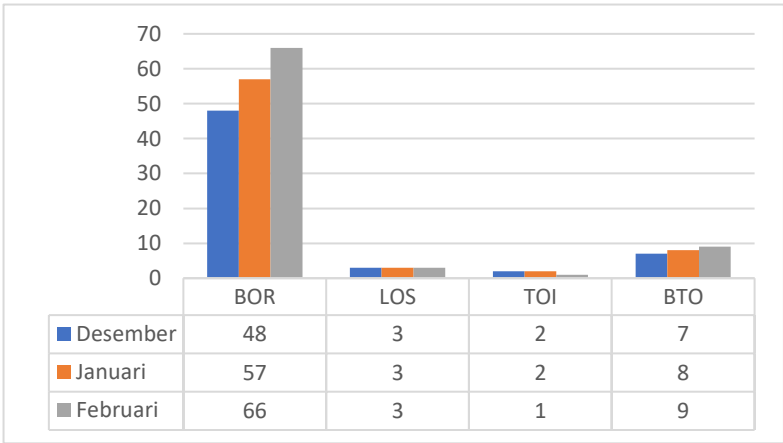
Analisis

-

Plan	Menganalisa perbaikan data quality rate
Do	Kordinasi dengan programmer terkait hasil bulan Desember sebagai pelaporan hasil perbaikan
Study	Data bulan Oktober sebagai acuan dari data yang sudah diperbaiki mulai diperbaiki.
Action	1) Memanfaatkan aplikasi https://dataviz.bpjs-kesehatan.go.id/ untuk monitoring 2) Monitoring evaluasi <i>feedback</i> bulan Desember 3) Supervisi kabit

C. Indikator Kinerja

a. BOR, LOS, BTO dan TOI



b. Evaluasi Hasil BOR, LOS, BTO dan TOI

Tingkat hunian meningkat dibanding 2 bulan sebelumnya. Dibandingkan dengan bulan sebelumnya, BOR RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan sebesar 16%. ALOS di RS Prima Husada Malang tetaap dalam 3 (tiga) bulan terakhir yaitu di angka 3, BTO meningkat sebanyak 9 kali dari bulan sebelumnya dan TOI menurun sebesar menjadi 1 hari.

Analisa :

Terdapat tren kenaikan jumlah pasien dan BOR sudah mencapai standar (60-85%). LOS masih tetap, TOI sudah sesuai standar.

c. Klaim Pending

a) Analisis

NO	MASALAH	DAMPAK	TINDAK LANJUT
1.	Kode tindakan eksisi debridement dan kode tindakan Biopsy lymphadinitis	Klaim Pending	Menjawab konfirmasi pending
2.	Indikasi rawat inap tindakan verruca vulgaris	Klaim Pending	Menjawab konfirmasi pending
3.	Kesesuaian kode tindakan denagn laporan operasi	Klaim Pending	Menjawab konfirmasi pending
4.	Fragmentasi kunjungan pasien rawat jalan	Klaim Pending	Menjawab konfirmasi pending

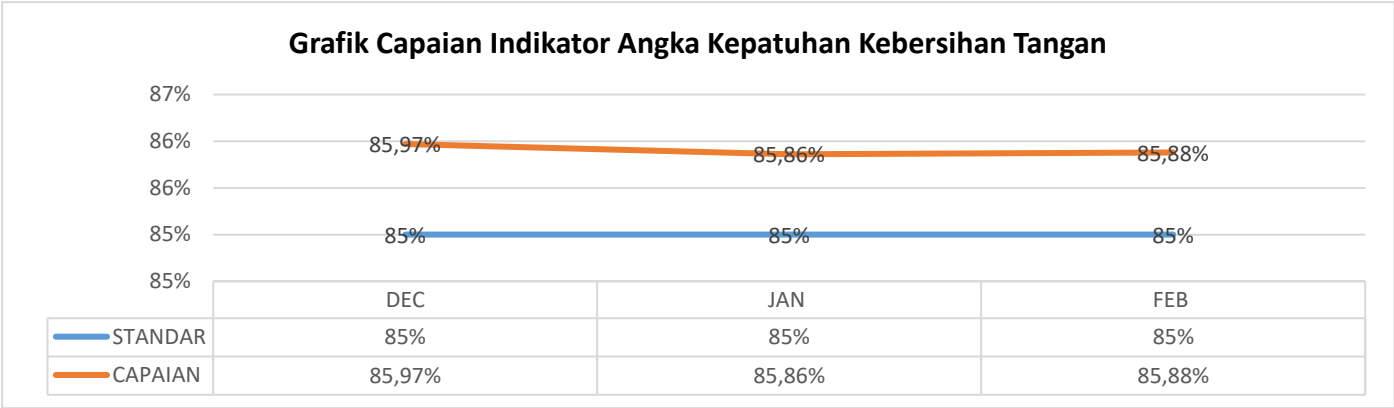
D. Data Mutu / Keselamatan Pasien

a. Indikator Mutu Nasional

NO	JUDUL	STAND	DES '23	JAN '24	FEB '24
INDIKATOR MUTU NASIONAL					
1	Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	85,97%	85,86%	85,88%
2	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	92,77%	93,04%	93,15%
3	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	99,84%	99,9%	81,2%
4	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi	≥ 80%	100%	100%	100%
5	Waktu Tunggu Rawat Jalan	≥ 80%	91,73%	95,2%	91,7%
6	Penundaan Operasi Elektif	≤ 5%	1,8%	0%	0%
7	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	73,47%	76,19%	79,08%
8	Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium	100%	98,88%	98,69%	98,8%
9	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	≥ 80%	100%	100%	100%
10	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	90,56%	63,8%	71,62%
11	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	95,44%	98,47%	97,47%
12	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	≥ 80%	100%	100%	93,15%
13	Kepuasan Pasien	≥ 76,61	99,19%	100%	91,89%

1. Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan

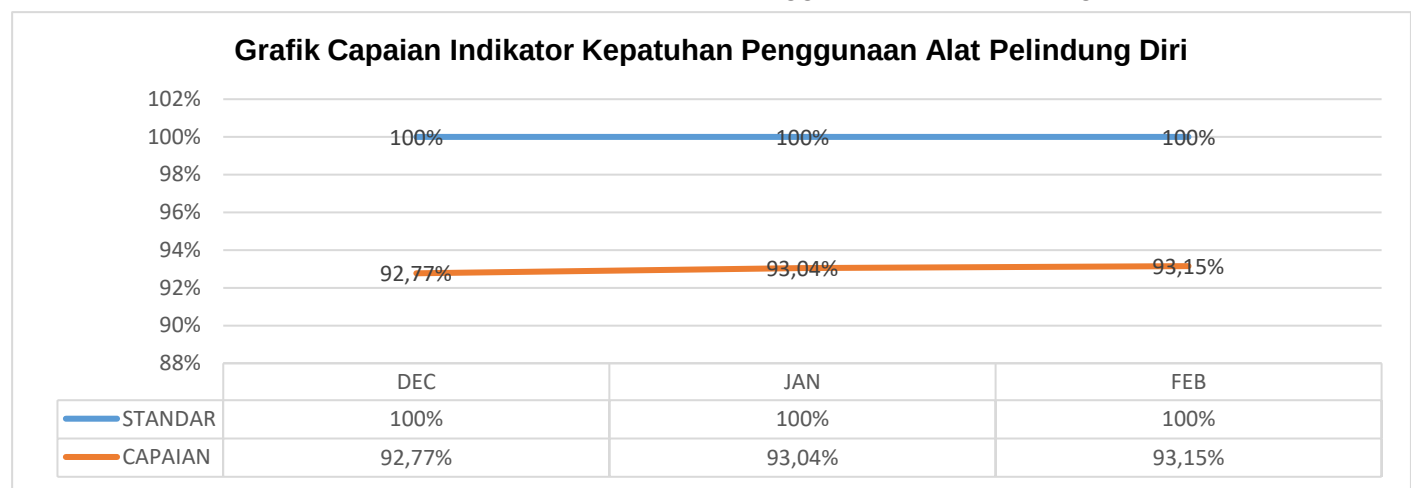
Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan kebersihan tangan semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan ± 5% setiap bulannya.				
DO	- Mendata ulang jumlah kebutuhan tatakan dan botol handrub unit. - Mengajak Karu untuk ikut mengecek kebutuhan fasilitas kebersihan tangan unitnya. - Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan kebersihan tangan. - Melakukan supervisi terkait fasilitas kebersihan tangan. - Melakukan sosialisasi kebersihan tangan antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya.				
STUDY	Prosentase kepatuhan kebersihan tangan keseluruhan sudah mencapai standart minimal pada bulan ini yaitu sebesar 85,88%. Banyak ditemukan temuan petugas tidak melakukan kebersihan tangan sebelum melakukan tindakan karena terbiasa beranggapan tangannya sudah bersih dan perlu diingatkan dulu (pada saat di audit baru patuh). Selain itu, dari hasil supervise fasilitas kebersihan tangan masih ditemukan bed pasien atau troli tindakan yang tidak dilengkapi dengan handrub. Dari segi petugas, ada yang lebih memilih untuk Memakai sarung tangan (handscoon) dibandingkan dengan cuci tangan seperti pada profesi dokter.				
ACTION/R TL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELA KSAN A	WAKTU
- Meningkatkan kebersihan tangan.	- Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	- Tercapainya kepatuhan kebersihan unit masing-masing diatas 85%.	- Resosialisasi 5 moment dan 6 langkah cuci tangan. - Melakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. - Memberikan reward-pembelajaran. - Melakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. - Mengingatkan perawat atau nakes lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien.	-Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	- Satu bulan

2. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

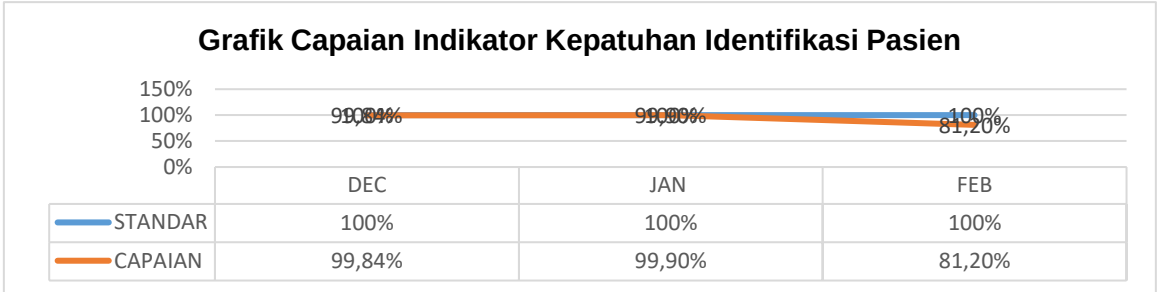
Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan penggunaan APD semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan ± 5% setiap bulannya.				
DO	- Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. - Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. - Menegur dan melakukan sosialisasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. - Menegur kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. - Sudah dikeluarkan edaran terkait penggunaan jas dokter.				
STUDY	Prosentase kepatuhan penggunaan APD keseluruhan belum mencapai standart, pada bulan ini yaitu sebesar 93,15% meningkat sedikit dari bulan sebelumnya. Dari hasil monitoring dan supervise, penggunaan APD oleh petugas nakes non dokter sudah cukup baik, namun masih ditemukan 1 petugas yang masih berlebihan memakai APD, seperti halnya pada salah satu dokter yang lebih memilih memakai handscoon saat visite karena beranggapan safety untuk dirinya. Peningkatan APD juga ada pada unit CS Dimana petugas sudah tertib memakai sarung tangan kerja, tidak memakai handscoon saat membersihkan ruangan.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD.	- Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit.	- Tercapainya kepatuhan APD unit minimal meningkat 2% pada bulan berikutnya.	- Melakukan sosialisasi antar staf tentang penggunaan APD. - Menegur staf yang salah dalam penggunaan APD dan memberikan metode pembelajaran dengan mendata ketidak patuhan teman-teman di unitnya. - Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting. - Berkolaborasi dengan perawat untuk tidak memberikan handscoon jika CS meminta handscoon. Selain itu kolaborasi dengan Karu CS untuk menyediakan stok sarung tangan sesuai nama petugas dan 1 stok tiap ruangan untuk menanggulangi sarung tangan yang cepat rusak. - Menjadikan kebiasaan pemakaian APD sesuai dengan jenis transmisi penyakit dan tindakan yang akan dilakukan.	- Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	- Satu bulan

3. Kepatuhan Identifikasi Pasien

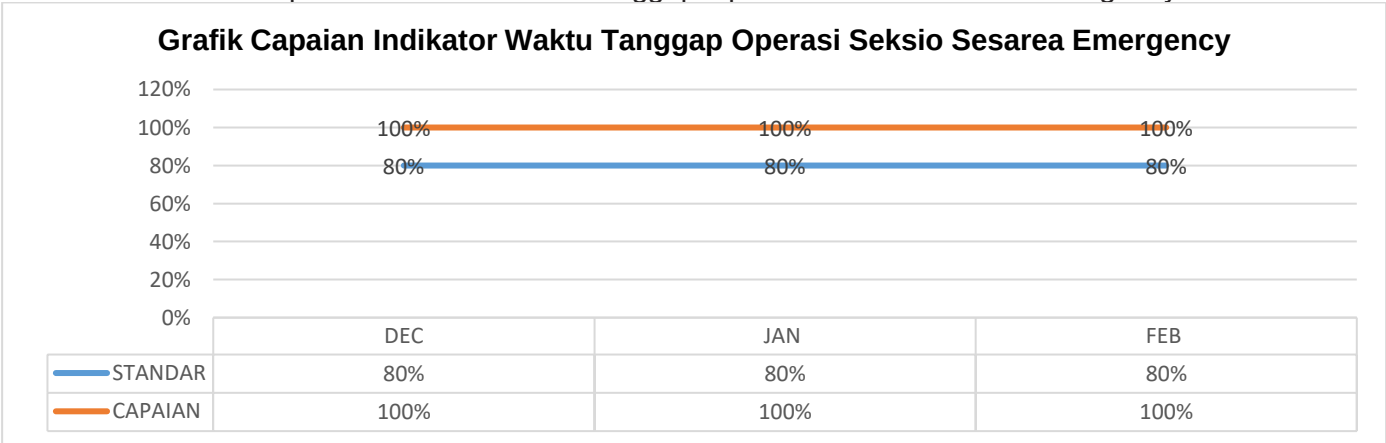
Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka keatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).				
DO	- Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan - Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait identifikasi pasien - Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang masih belum mencapai standart. Bahkan dapat diketahui, capaian menurun dari bulan sebelumnya. Dari hasil supervisi didapatkan masih ditemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien dengan tepat ketika akan melakukan tindakan.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien	- Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien	- Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	- Meningkatkan supervisi pada petugas unit - Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien denga tepat	- Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	- Satu bulan

4. Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency

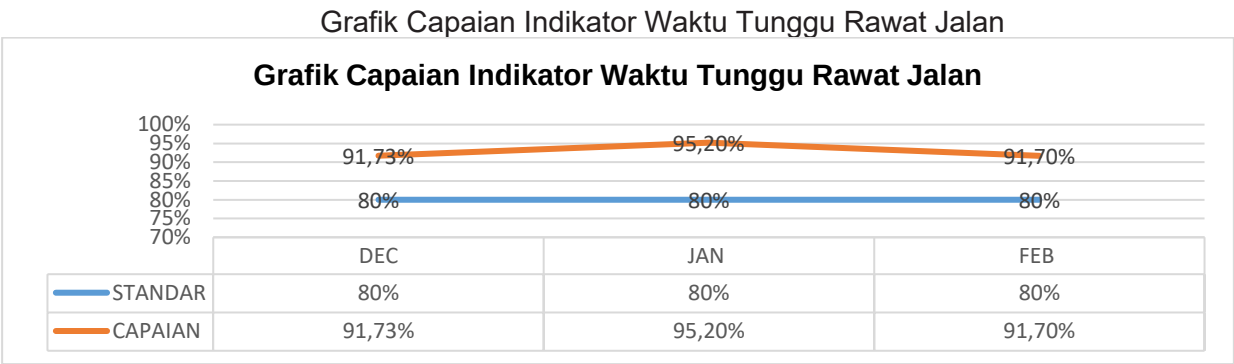
Grafik Capaian Indikator Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency



Analisis

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa persentase waktu tanggap operasi seksio sesarea emergency pada bulan November dan Desember tahun 2023 sudah mencapai standart. Pada bulan Januari tahun 2024 juga capaian indikator waktu tanggap operasi seksio sesarea Emergency telah mencapai standart. Tim IGD dan IKO melakukan koordinasi dan tindakan secara tepat dan cepat sehingga operasi bisa dilaksanakan.

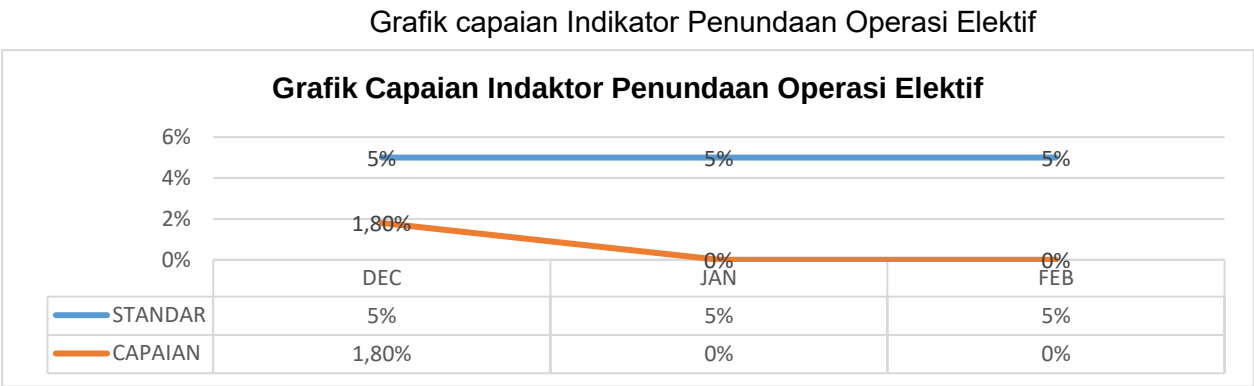
5. Waktu Tunggu Rawat Jalan



Analisis

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa waktu tunggu rawat jalan pada bulan Desember tahun 2023 telah mencapai standart. Pada bulan Januari tahun 2024 capaian indikator waktu tunggu rawat jalan semakin meningkat dan telah mencapai standart. Pada bulan Februari tahun 2024 capaian masih mencapai standart, meskipun capaian menurun menjadi 91,7%.

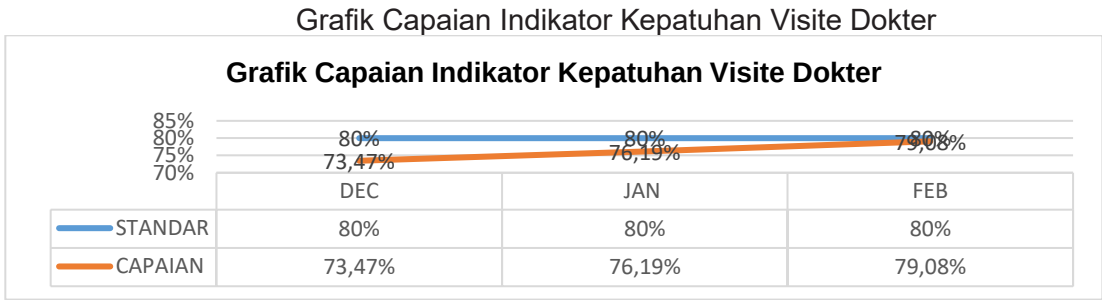
6. Penundaan Operasi Elektif



Analisis

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa masih ada penundaan operasi elektif pada bulan Desember tahun 2023 tetapi capaian masih mencapai standart. Penundaan operasi elektif dapat disebabkan karena kondisi pasien dan juga belum tersedianya alat yang akan dipasang pada pasien (orthopedi). Pada bulan Januari dan Februari tahun 2024 tidak ditemukan penundaan operasi elektif.

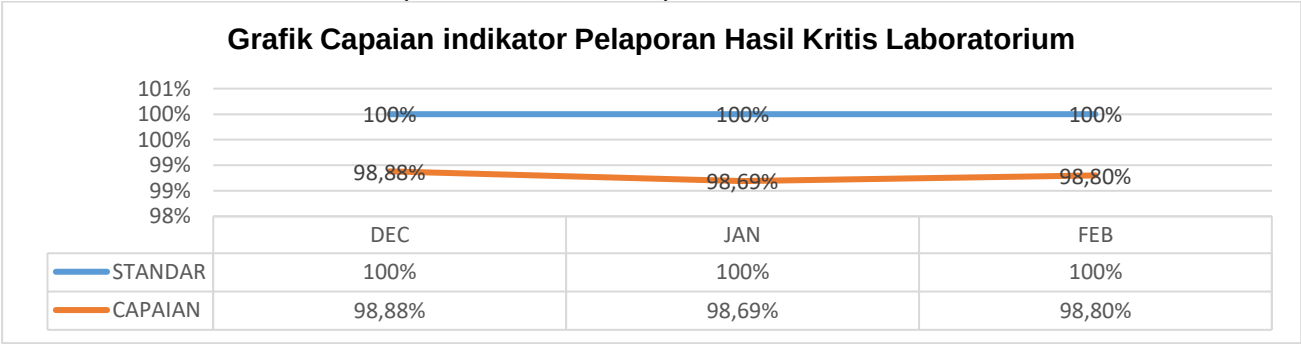
7. Kepatuhan Waktu Visite Dokter



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan waktu visite dokter hingga dapat mencapai standart 80%.				
DO	Memberikan teguran kepada DPJP yang melakukan visite lebih dari jam 14.00				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui persentase kepatuhan waktu visite dokter pada bulan Desember tahun 2023 masih belum mencapai standart. Begitu pula dibulan Januari dan Februari tahun 2024, terjadi peningkatan dari bulan Desember tetapi capaian masih belum mencapai standart. Dari hasil supervisi didapatkannya Angka kepatuhan waktu visite Dokter belum mencapai target karena masih banyak dokter yang visite diatas jam 14.00 karena masih bertugas di RS lain karena RS Prima Husada tidak memiliki Dokter tetap. Dokter visite jam 07.00-14.00 : dr. Ira, Sp.JP, dr. Mira, Sp.JP, dr. Anton, Sp.B, dr. Catur, SpS, dr. Dicky,Sp.A , dr. Elvi, Sp.P, dr. Dewi, Sp.S, dr. Ardhi, Sp.PD, dr. Humairoh, Sp.Og, dr. Aida, Sp.Og Dokter visite jam 14.00-21.00 : dr. Heriyatmo, Sp.PD, dr. Andi, Sp.P, dr. Farid, Sp.S, dr. Yoga, Sp.JP (Tidak menentu)				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	- Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	- Capaian Kepatuhan Visite dokter bisa meningkat pada bulan selanjutnya	Mengevaluasi hasil setelah memberikan teguran kepada DPJP dan memberikan surat peringatan kepada DPJP yang masih visite di atas jam 14.00	Manajemen RS	- Satu bulan

8. Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

Grafik Capaian Indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

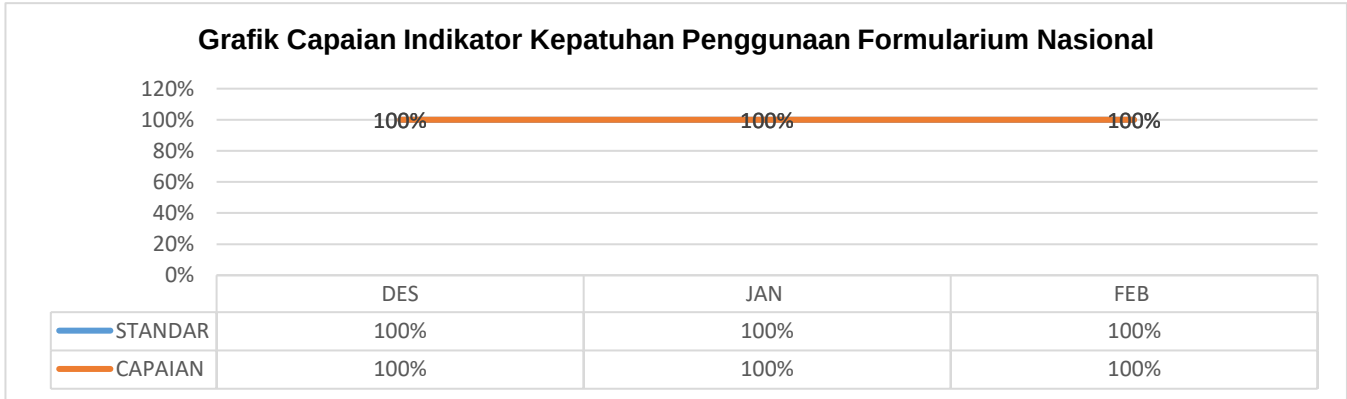


PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan pelaporan hasil kritis laboratorium hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan supervisi baik dari komite mutu maupun kepala instalasi laboratorium supaya seluruh petugas laboratorium segera melaporkan hasil kritis dan melakukan dokumentasi dengan baik dan lengkap.				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui indikator pelaporan hasil kritis laboratorium pada bulan Desember tahun 2023 masih belum mencapai standart. Begitu pula dibulan Januari dan Februari tahun 2024, berdasarkan hasil supervisi masih ada petugas yang melaporkan hasil kritis laboratorium tetapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan lengkap.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium	- Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium	- Capaian pelaporan hasil kritis laboratorium dapat mencapai standart 100% pada	- Menganalisa jumlah hasil kritis laboratorium yang terlapor dan tidak terlapor - Memberikan teguran secara langsung kepada petugas	- Komite mutu - Kepala instalasi laboratorium	- Satu bulan

		bulan berikutnya	laboratorium yang tidak melaporkan hasil kritis laboratorium ataupun yang melapor tapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan baik dan lengkap.		
--	--	------------------	--	--	--

9. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

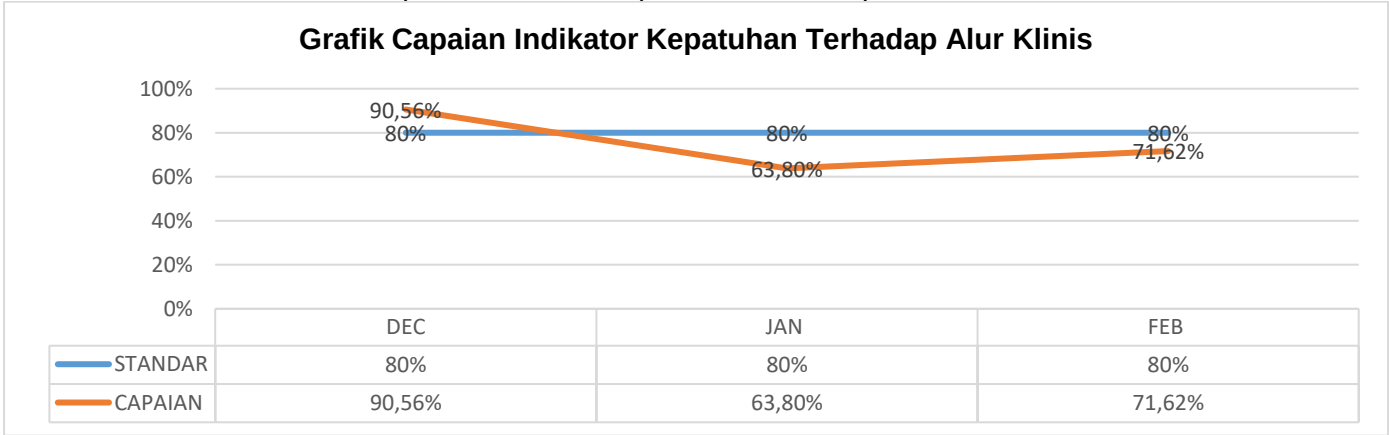
Grafik Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional



Analisis
 Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa persentase kepatuhan penggunaan formularium nasional pada Desember tahun 2023 sudah mencapai standart. Begitu pula dengan bulan Januari dan Februari tahun 2024, capaian indikator kepatuhan penggunaan formularium nasional telah mencapai standart 100%.

10. Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)

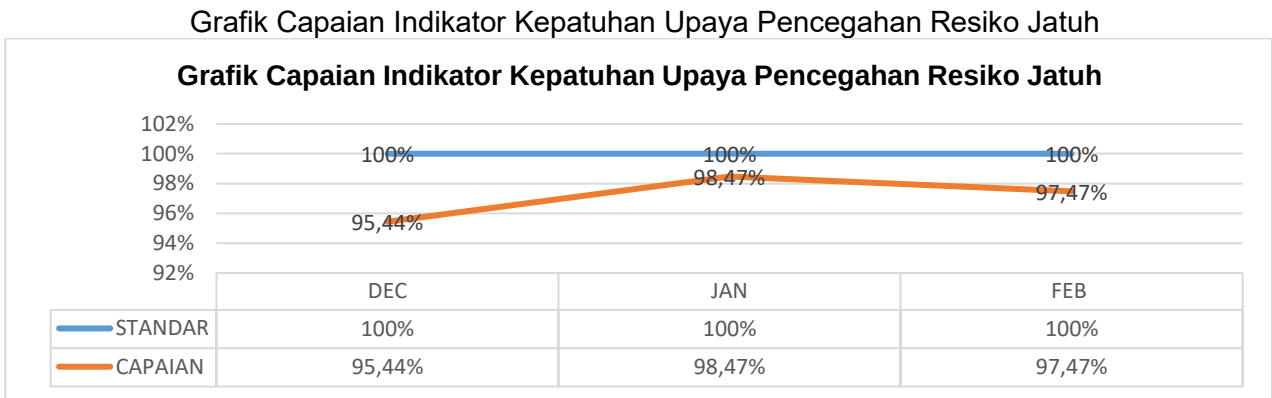
Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Terhadap Alur Klinis



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis hingga mencapai standart 80%.
DO	Melakukan koordinasi dengan seluruh bidang profesi (dokter, perawat, apoteker dan ahli gizi) supaya mengisi form CP sesuai dengan yang diberikan kepada pasien sehingga kepatuhan terhadap alur klinis dapat dianalisa.
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui indikator kepatuhan terhadap alur klinis masih belum stabil. Masih ditemukan profesi yang tidak memberikan asuhan sesuai dengan CP yang telah disepakati.

ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Meningkatkan capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis	- Meningkatkan capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis	- Capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis bisa mencapai standart 80%.	Melibatkan seluruh bidang profesi (dokter, perawat, apoteker dan ahli gizi) supaya mengisi form CP sesuai dengan yang diberikan kepada pasien sehingga kepatuhan terhadap alur klinis dapat dianalisa.	- Komite mutu	- Satu bulan

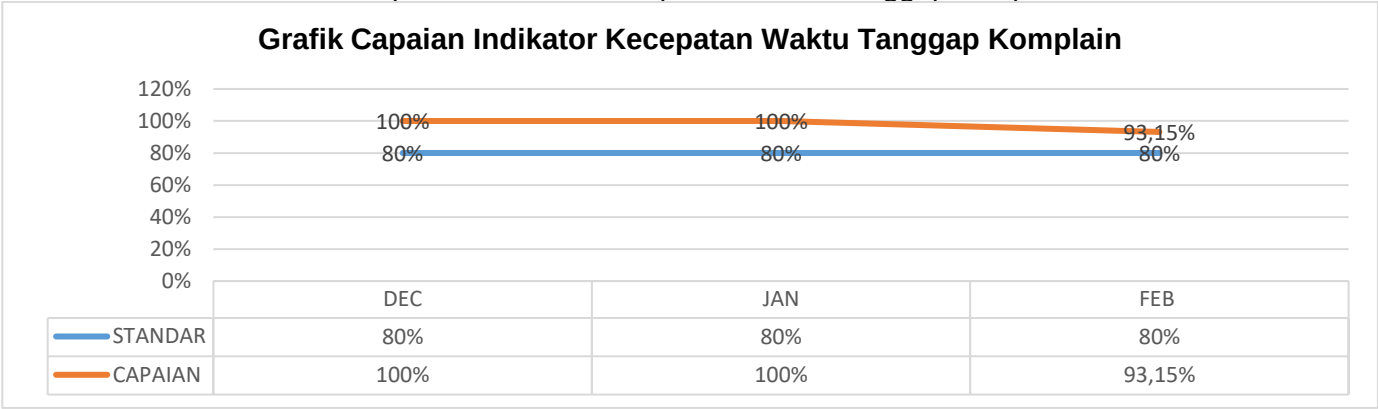
11. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan KIE kepada pasien dan keluarga tentang kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh				
STUDY	Berdasarkan capaian diatas, dapat diketahui bahwa prosentase kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Desember tahun 2023 masih belum mencapai standart, begitupun pada bulan Januari dan Februari tahun 2024. Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh belum mencapai standart karena masih ditemukan tempat tidur pasien yang tidak terpasang handrell pada pasien rawat inap. Perawat telah memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien agar selalumemasang handrell tetapi seringkali keluarga pasien tidak memasang kembali handrell ketika pasien telah dari kamar mandi.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	- Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	- Capaian indikator kepatuhan terhadap upaya pencegahan resiko jatuh bisa mencapai 100%.	KIE kepada pasien dan keluarga tentang upaya pencegahan resiko jatuh harus lebih ditekankan dan disertai tanda tangan sebagai bukti bahwa edukasi telah dilakukan.	Perawat instalasi rawat inap	- Satu bulan

12. Kecepatan Waktu Tanggap Komplain

Grafik Capaian Indikator Kecepatan Waktu Tanggap komplain

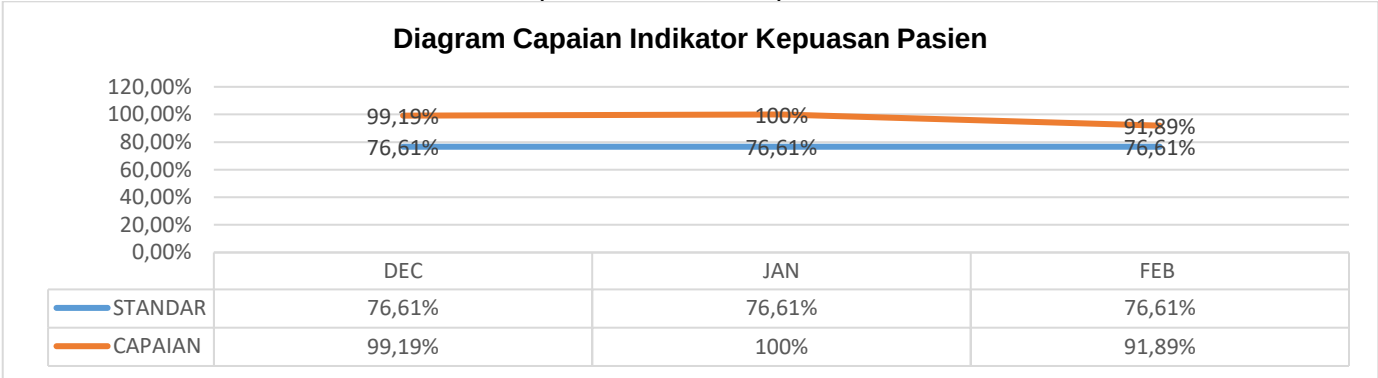


Analisis

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa persentase kecepatan waktu tanggap kompalin pada bulan Desember tahun 2023 sudah mencapai standart. Pada bulan Januari tahun 2024 capaian tetap stabil, PIPP dan bidang terkait telah menanggapi dan menyelesaikan complain kurang dari 24 jam. Pada bulan Februari capaian menurun menjadi 93,15% tetapi masih diatas standart,

13. Kepuasan Pasien

Grafik Capaian Indikator Kepuasan Pasien



Analisis

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa persentase kepuasan pasien pada bulan November, Desember tahun 2023 serta bulan Januari tahun 2024 sudah mencapai standar

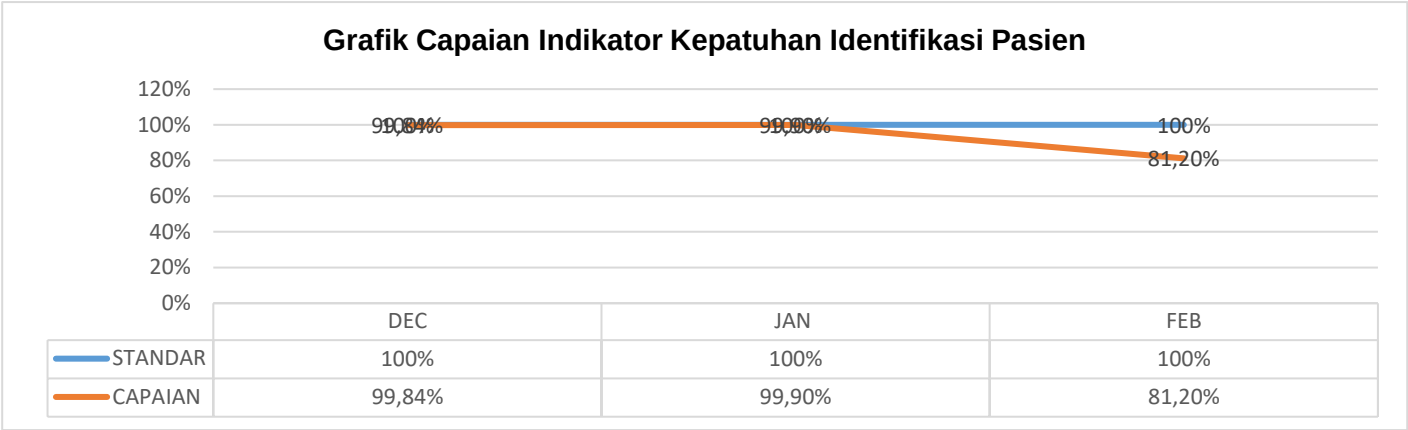
b. Indikator Mutu Prioritas

1. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien

NO.	JUDUL	STAND	DES '23	JAN '24	FEB '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	99,84%	99,9%	81,2%
2	Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert	0	0	0	0
3	Kejadian tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi	0	0	0	0
4	Kepatuhan kebersihan tangan	100%	85,97%	85,86%	85,88%
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	95,44%	98,47%	97,47%

1. Kepatuhan Identifikasi Pasien

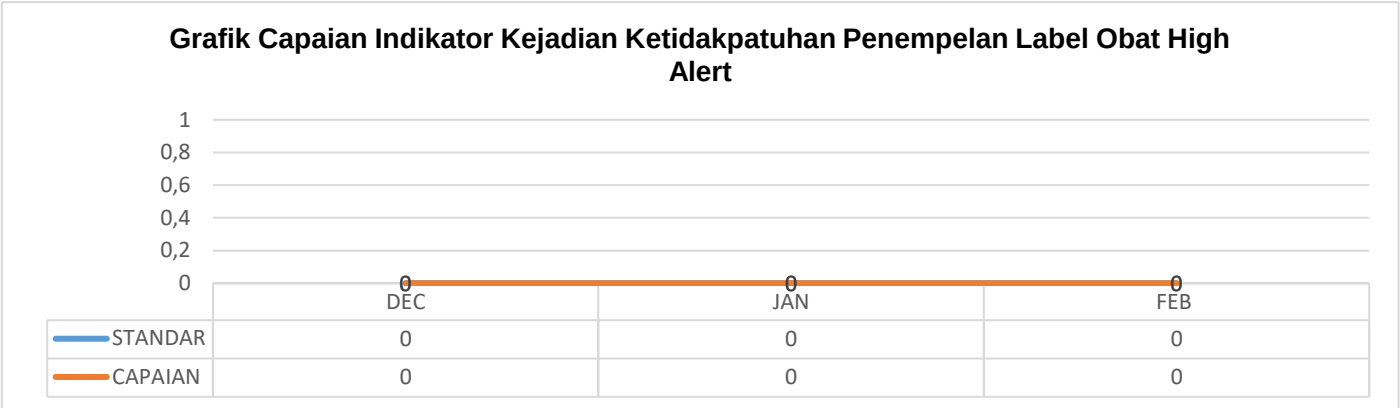
Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka keatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).				
DO	Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait identifikasi pasien Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang masih belum mencapai standart. Bahkan dapat diketahui, capaian menurun dari bulan sebelumnya. Dari hasil supervisi didapatkan masih ditemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien dengan tepat ketika akan melakukan tindakan.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien	Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien	Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	Meningkatkan supervisi pada petugas unit Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien denga tepat	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu bulan

2. Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert

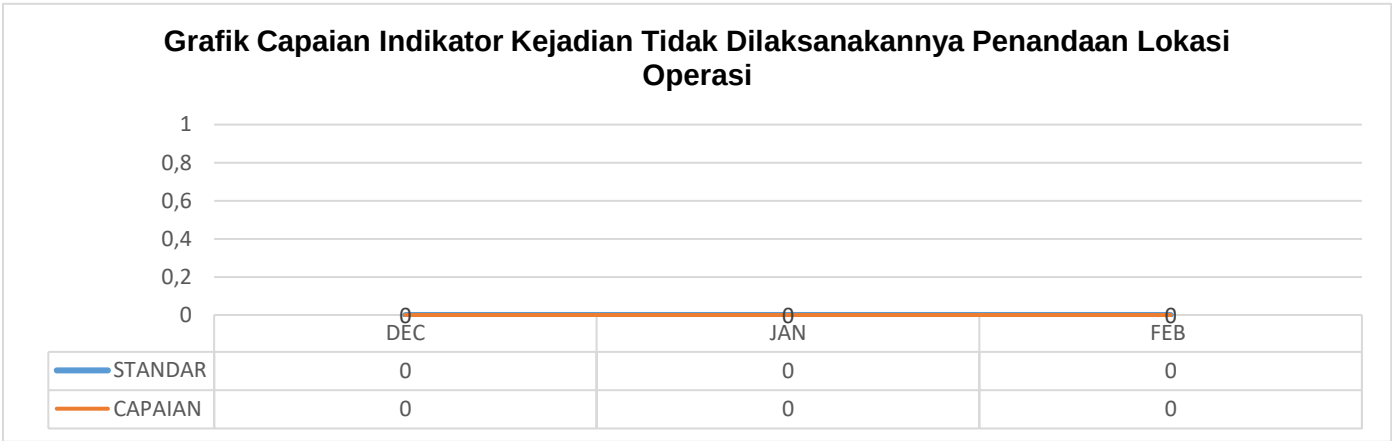
Grafik Capaian Indikator Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert



Analisis
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui persentase ketidakpatuhan penempelan label obat high alert pada Bulan Desember tahun 2023 serta bulan Januari dan Februari tahun 2024 sudah mencapai standart.

3. Kejadian Tidak Dilaksanakannya Penandaan Lokasi Operasi

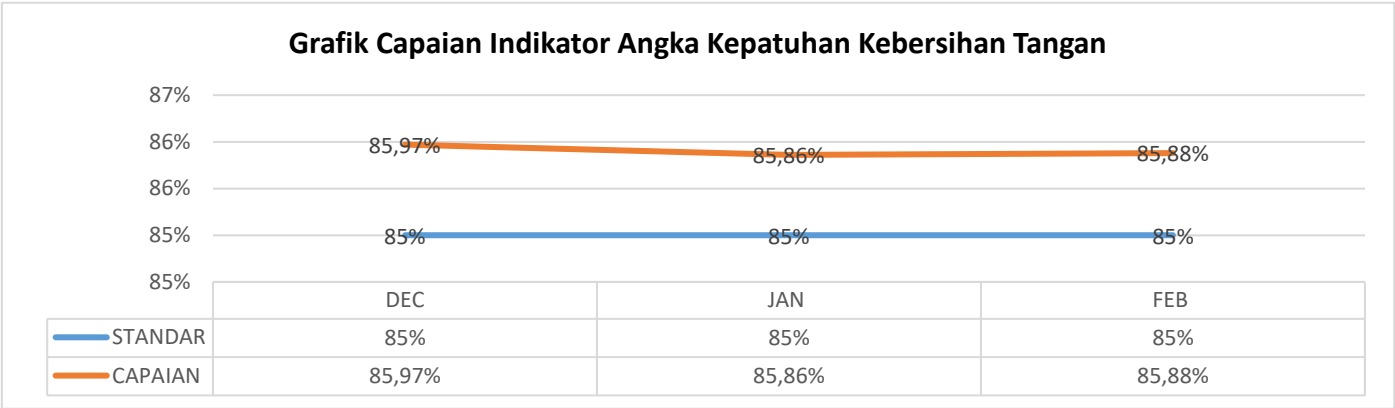
Grafik Capaian Indikator Kejadian Tidak Dilaksanakannya Penandaan Lokasi Operasi



Analisis
Berdasarkan data diatas dapat diketahui persentase tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi pada bulan Desember tahun 2023 serta bulan Januari dan Februari tahun 2024 sudah mencapai standart

4. Kepatuhan Kebersihan Tangan

Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan

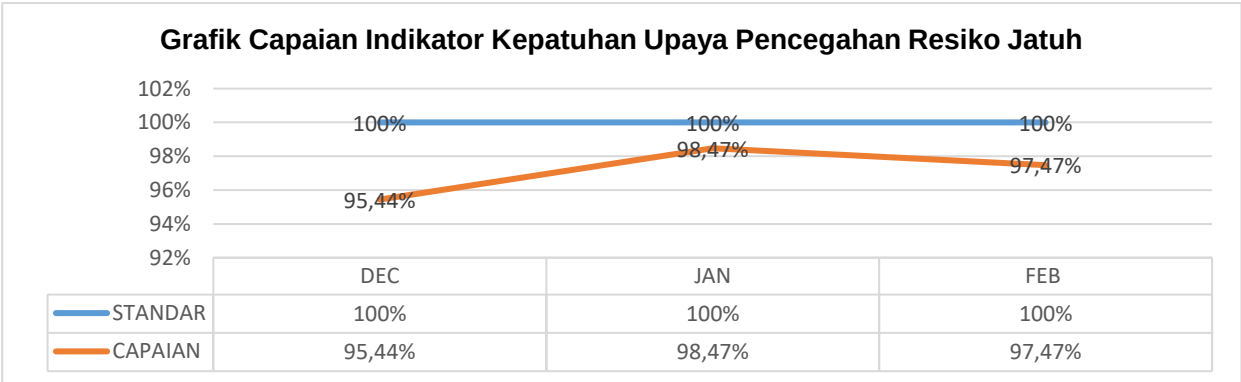


PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan kebersihan tangan semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan ± 5% setiap bulannya.
DO	Mendata ulang jumlah kebutuhan tatakan dan botol handrub unit. Mengajak Karu untuk ikut mengecek kebutuhan fasilitas kebersihan tangan unitnya.

	- Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan kebersihan tangan. - Melakukan supervisi terkait fasilitas kebersihan tangan. - Melakukan sosialisasi kebersihan tangan antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya.				
STUDY	Prosentase kepatuhan kebersihan tangan keseluruhan sudah mencapai standart minimal pada bulan ini yaitu sebesar 85,88%. Banyak ditemukan temuan petugas tidak melakukan kebersihan tangan sebelum melakukan tindakan karena terbiasa beranggapan tangannya sudah bersih dan perlu diingatkan dulu (pada saat di audit baru patuh). Selain itu, dari hasil supervise fasilitas kebersihan tangan masih ditemukan bed pasien atau troli tindakan yang tidak dilengkapi dengan handrub. Dari segi petugas, ada yang lebih memilih untuk Memakai sarung tangan (handscoon) dibandingkan dengan cuci tangan seperti pada profesi dokter.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kebersihan tangan.	- Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Tercapainya kepatuhan kebersihan unit masing-masing diatas 85%.	- Resosialisasi 5 moment dan 6 langkah cuci tangan. - Melakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. - Memberikan reward-pembelajaran. - Melakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. - Mengingatkan perawat atau nakes lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien.	-Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	- Satu bulan

5. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh



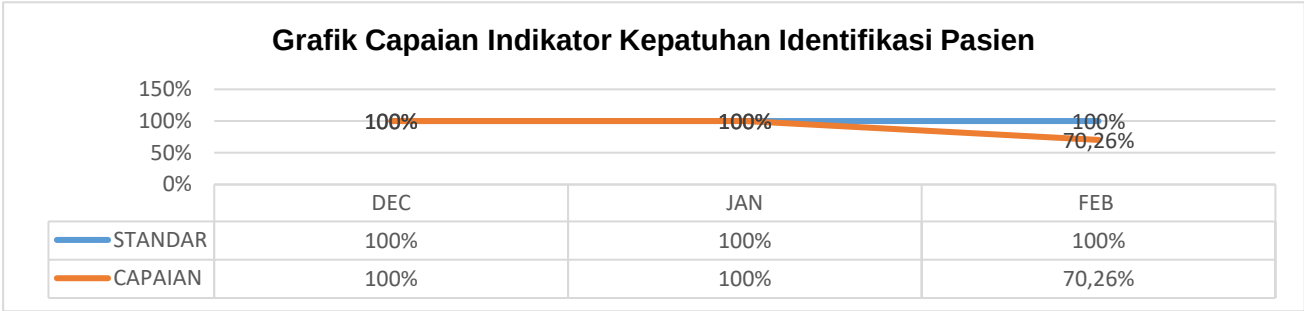
PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan KIE kepada pasien dan keluarga tentang kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh				
STUDY	Berdasarkan capaian diatas, dapat diketahui bahwa prosentase kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Desember tahun 2023 masih belum mencapai standart, begitupun pada bulan Januari dan Februari tahun 2024. Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh belum mencapai standart karena masih ditemukan tempat tidur pasien yang tidak terpasang handrell pada pasien rawat inap. Perawat telah memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien agar selalumemasang handrell tetapi seringkali keluarga pasien tidak memasang kembali handrell ketika pasien telah dari kamar mandi.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	- Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Capaian indikator kepatuhan terhadap upaya pencegahan resiko jatuh bisa mencapai 100%.	KIE kepada pasien dan keluarga tentang upaya pencegahan resiko jatuh harus lebih ditekankan dan disertai tanda tangan sebagai bukti bahwa edukasi telah dilakukan.	Perawat instalasi rawat inap	- Satu bulan

c. Indikator Mutu Pelayanan Klinis Prioritas

NO	JUDUL	STAND	DES '23	JAN '24	FEB '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	70,26%
2	Kepatuhan penggunaan formularium Nasional	≥80%	100%	100%	100%
3	Kejadian kesalahan penyiapan obat	0	1	1	0
4	Kejadian kesalahan penempelan label pada obat LASA	0	0	0	0
5	Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	0%	65,43%	68,81%	69,59%
6	Angka keterlambatan penyiapan obat racikan >60 menit.	0%	44,7%	41,48%	50,77%
7	Kejadian kesalahan pemberian obat	0	0	0	0
8	Kejadian kesalahan penulisan etiket obat.	0	0	0	0
9	Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert	0	0	0	0
10	Kejadian kesalahan input e-resep	0	0	0	0
11	Kejadian petugas tertusuk jarum	0	0	0	0
12	Kejadian terkena pemanas mesin press puyer	0	0	0	0
13	Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap	0	0	0	0
14	Kekosongan stok farmasi	0%	0,27%	0,27%	0,36%

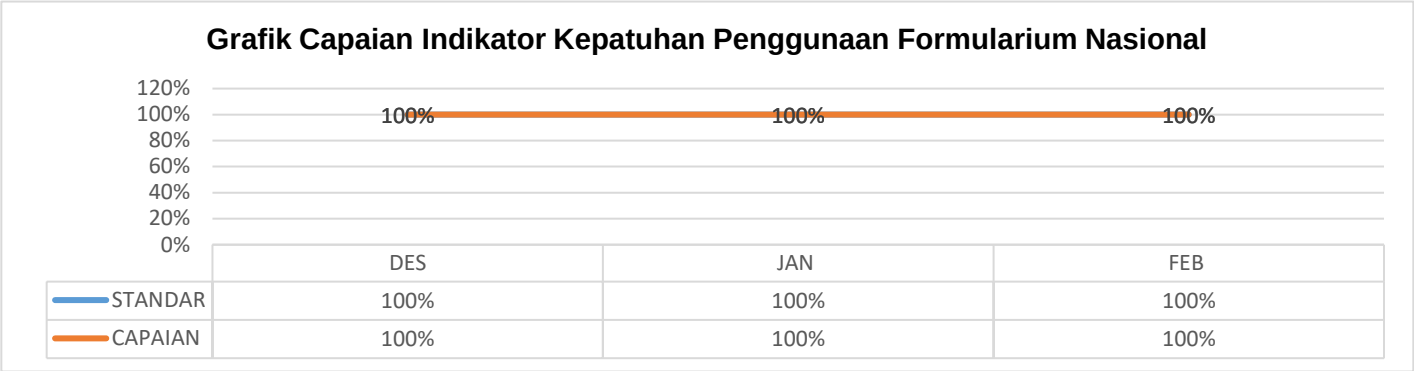
1. Kepatuhan Identifikasi Pasien

Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien



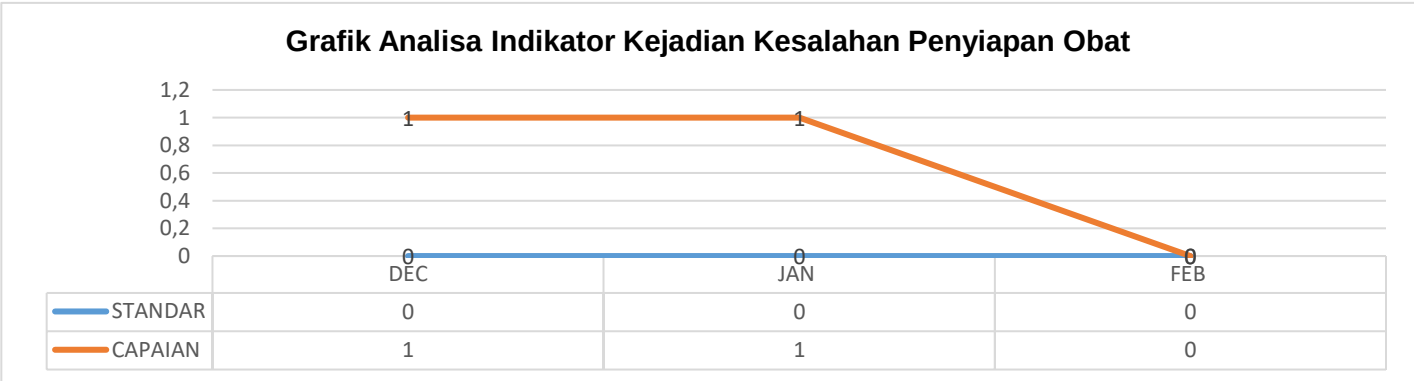
PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka keatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).				
DO	- Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan - Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait identifikasi pasien - Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang masih belum mencapai standart. Bahkan dapat diketahui, capaian menurun dari bulan sebelumnya. Dari hasil supervisi didapatkan masih ditemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien dengan tepat ketika akan melakukan tindakan. Misalnya Ketika keluarga pasien mengambil obat dan tidak tahu tanggal lahir pasie, beberapa petugas tetap memberikan obat tersebut.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien	- Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien	- Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	- Meningkatkan supervisi pada petugas unit - Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien denga tepat	- Seluruh petugas farmasi	- Satu bulan

2. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional
Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional



Analisis
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa persentase kepatuhan penggunaan formularium nasional pada bulan Desember tahun 2023 sudah mencapai standart. Begitu pula pada bulan Januari dan Februari tahun 2024, rumah sakit telah menggunakan formularium nasional sebagai acuan.

3. Kejadian Kesalahan Penyiapan Obat
Grafik Analisa Indikator Kejadian Kesalahan Penyiapan Obat



PLAN	Kami berencana untuk mempertahankan capaian kejadian kesalahan pemberian obat yang pada bulan ini telah mencapai standart.				
DO					
STUDY	Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa kesalahan pemberian obat masih terjadi pada bulan Desember tahun 2023 dan terjadi kembali pada bulan Januari 2024. Kesalahan pemberian obat terjadi karena petugas tidak teliti dalam melakukan penyiapan obat. Pada bulan Februari, diketahui tidak ada kejadian kesalahan penyiapan obat.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU

4. Kejadian Kesalahan Penempelan Label Pada Obat LASA

Grafik Analisa Kejadian Kesalahan Penempelan Label Pada Obat LASA

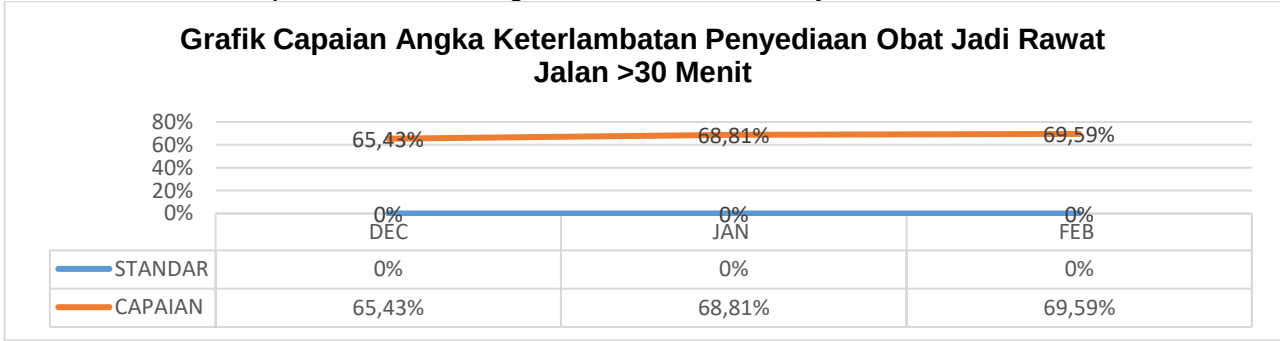


Analisis

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan tidak ditemukan kejadian kesalahan penempelan pada obat LASA pada bulan Desember tahun 2023 hingga bulan Februari tahun 2024.

5. Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Jadi Rawat Jalan >30 Menit

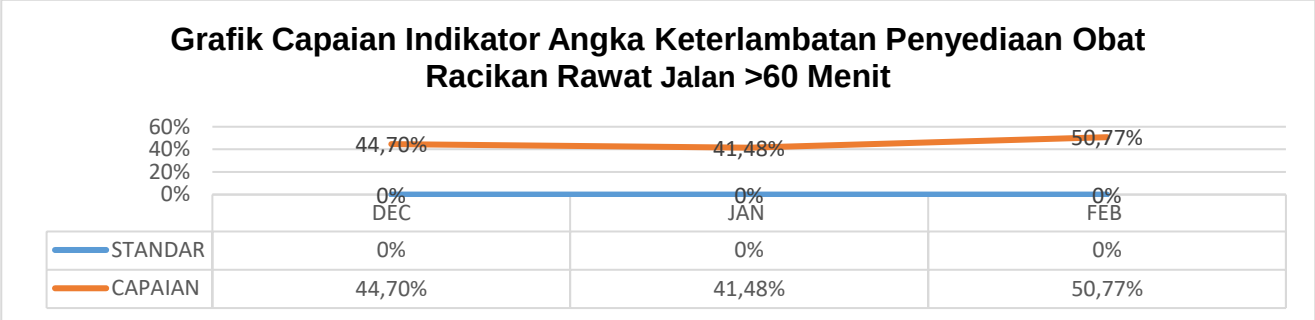
Grafik Capaian Indikator Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Jadi Rawat Jalan >30 Menit



PLAN	Kami berencana Menurunkan angka keterlambatan obat jadi rawat jalan >30 menit hingga mencapai standart 0% dengan target angka menurun 5% setiap bulan.					
DO	- Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan - Melakukan rapat Bersama kepala instalasi farmasi supaya petugas tidak merapel klik setelah pelayanan farmasi selesai - Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada betugas yang tidak langsung klik selsai pelayanan ketika layanan farmasi telah selesai					
STUDY	Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit masih belum mencapai standart. Hal ini disebabkan karena : - Pasien cendereung naik beberapa hari, efek DPJP libur lama sehingga beberapa hari pasien meningkat - Tanda tangan elektronik diperlakukan untuk semua resep, termasuk rawat jalan IGD dan rawat jalan non kronis sehingga petugas farmasi memerlukan waktu untuk menyesuaikan					
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		PELAKSANA	WAKTU
Mengura ngi angka keterlam batan penyedia an obat jadi rawat jalan >30 menit.	Menguran gi angka keterlamb atan penyediaa n obat jadi rawat jalan >30 menit.	Obat jadi rawat jalan bisa diselesaik an kurang dari 30 menit .	- Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan - Melakukan rapat Bersama kepala instalasi farmasi supaya petugas tidak merapel klik setelah pelayanan farmasi selesai - Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada betugas yang tidak langsung klik selsai pelayanan ketika layanan farmasi telah selesai		Seluruh petugas farmasi	Satu bulan

6. Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Racikan Rawat Jalan >60 Menit

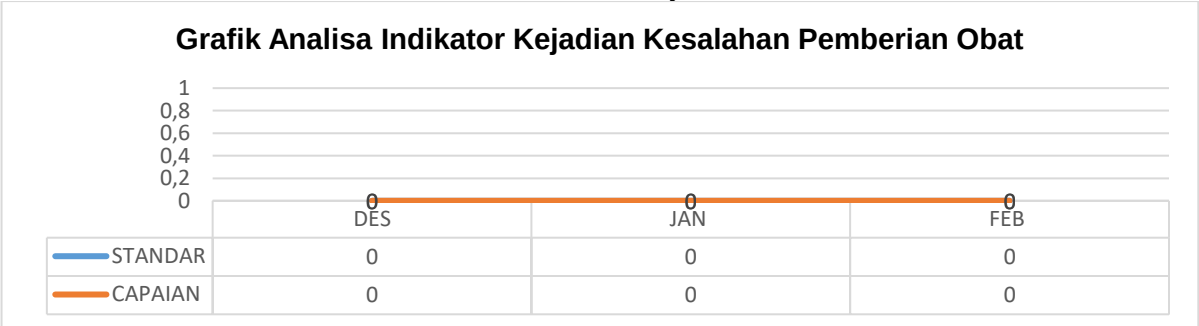
Grafik Capaian Indikator Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Racikan Rawat Jalan >60 Menit



PLAN	Kami berencana Menurunkan angka keterlambatan obat racikan rawat jalan >60 menit hingga mencapai standart 0% dengan target angka menurun 5% setiap bulan.				
DO	- Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan - Melakukan rapat Bersama kepala instalasi farmasi supaya petugas tidak merapel klik setelah pelayanan farmasi selesai - Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada betugas yang tidak langsung klik selsai pelayanan ketika layanan farmasi telah selesai				
STUDY	Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa angka keterlambatan penyediaan obat racikan rawat jalan >60 menit masih belum mencapai standart. Hal ini disebabkan karena : - Pasien cendereung naik beberapa hari, efek DPJP libur lama sehingga beberapa hari pasien meningkat - Tanda tangan elektronik diperlakukan untuk semua resep, termasuk rawat jalan IGD dan rawat jalan non kronis sehingga petugas farmasi memerlukan waktu untuk menyesuaikan				
ACTION/RT L	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Mengur angi angka keterla mbatan penyedi aan obat racikan rawat jalan >60 menit.	- Mengura ngi angka keterlam batan penyedia an obat racikan rawat jalan >60 menit.	- Obat jadi rawat jalan bisa diselesai kan kurang dari 60 menit .	- Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan - Melakukan rapat Bersama kepala instalasi farmasi supaya petugas tidak merapel klik setelah pelayanan farmasi selesai - Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada betugas yang tidak langsung klik selsai pelayanan ketika layanan farmasi telah selesai	- Seluruh petugas farmasi	- Satu bulan

7. Kejadian Kesalahan Pemberian Obat

Grafik Analisa Indikator Kejadian Kesalahan Pemberian Obat

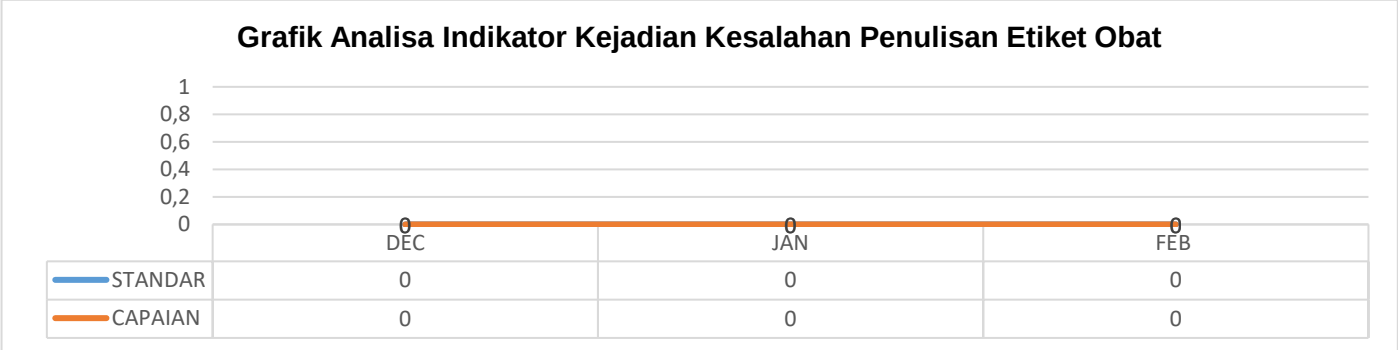


Analisis

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa tidak ditemukan kejadian kesalahan pemberian obat mulai bulan Desember 2023 hingga Februari tahun 2024.

8. Kejadian Kesalahan Penulisan Etiket Obat

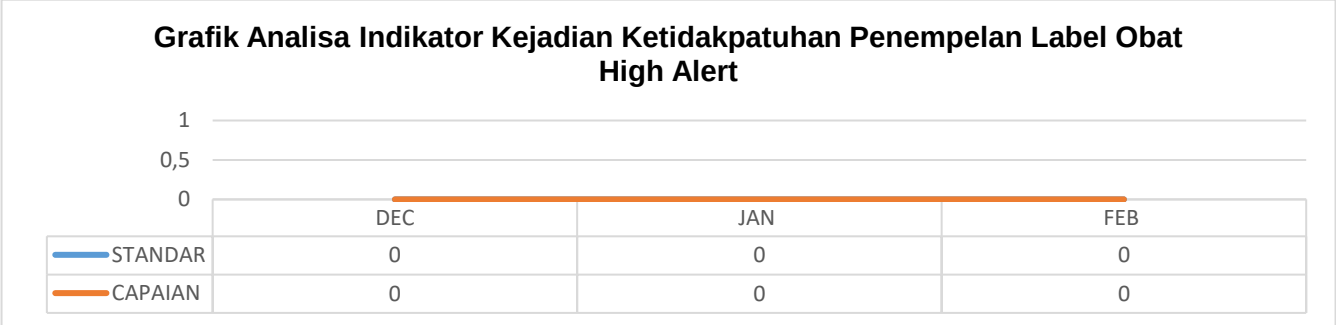
Grafik Analisa Indikator Kejadian Kesalahan Penulisan Etiket Obat



Analisis
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa tidak ada kejadian kesalahan penulisan etiket obat sejak bulan Desember tahun 2023 hingga Februari tahun 2024.

9. Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert

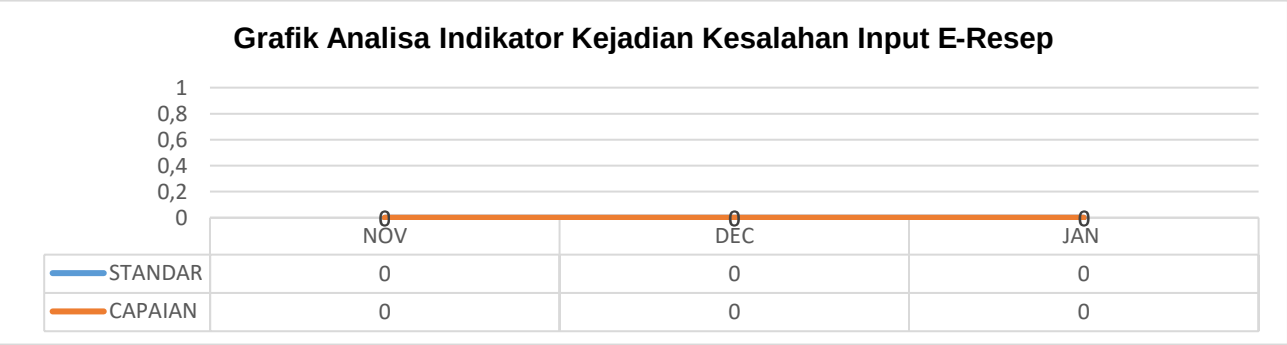
Grafik Analisa Indikator Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert



Analisis
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa tidak ditemukan kejadian ketidakpatuhan penempelan obat high alert sejak bulan Desember tahun 2023 hingga Februari tahun 2024.

10. Kejadian Kesalahan input e-resep

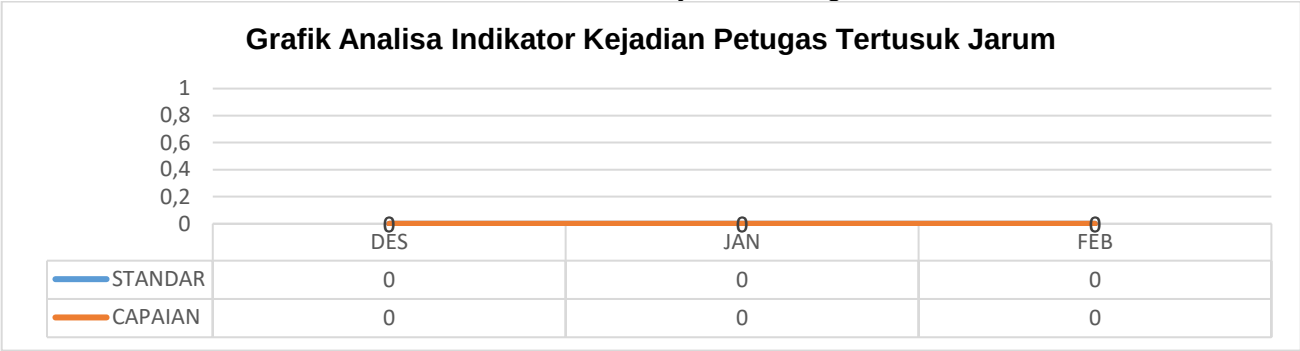
Grafik Analisa Indikator Kejadian Kesalahan Input E- Resep



Analisis
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa tidak ditemukan kejadian kesalahan input e-resep pada bulan Desember tahun 2023 hingga bulan Februari tahun 2024.

11. Kejadian Petugas Tertusuk Jarum

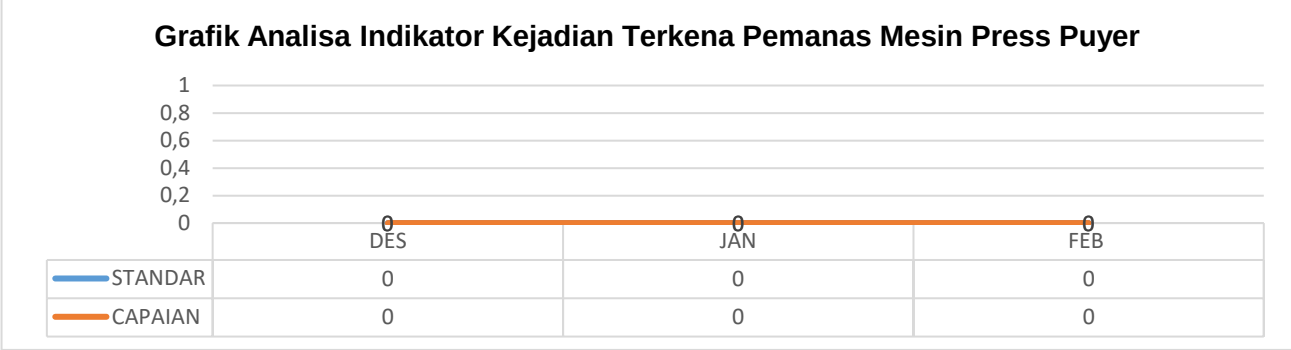
Grafik Analisa Indikator Kejadian Petugas Tertusuk Jarum



Analisis
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa tidak ada kejadian petugas tertusuk jarum sejak bulan Desember tahun 2023 hingga bulan Februari tahun 2024.

12. Kejadian Terkena Pemanas Mesin Press Puyer

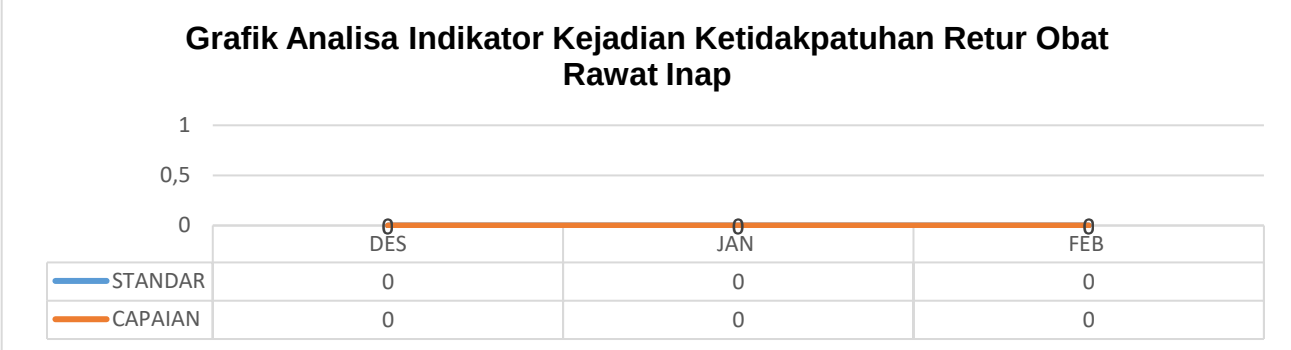
Grafik Analisa Indikator Kejadian Terkena Pemanas Mesin Press Puyer



Analisis
Dari data diatas dapat diketahui bahwa tidak ada kejadian terkena pemanas mesin press puyer sejak bulan Desember tahun 2023 hingga bulan Februari tahun 2024.

13. Kejadian Ketidakpatuhan Retur Obat Rawat Inap

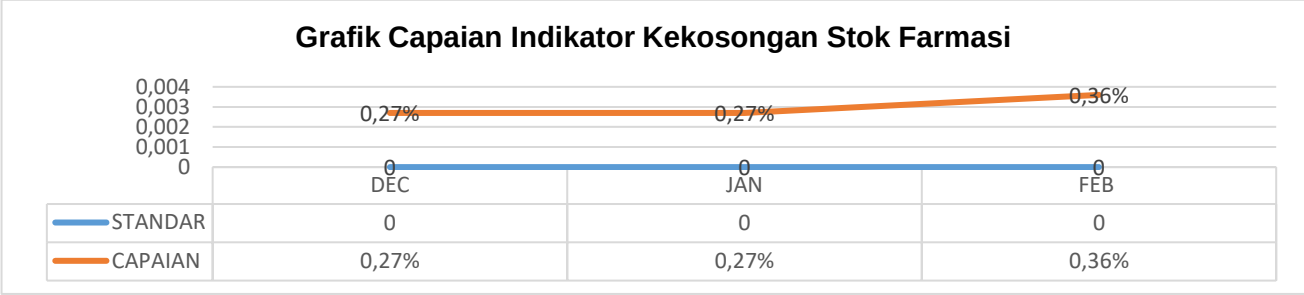
Grafik Analisa Indikator Kejadian Ketidakpatuhan Retur Obat Rawat Inap



Analisis
Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa tidak ditemukan kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap sejak bulan Desember tahun 2023 hingga bulan Februari tahun 2024.

14. Kekosongan Stok Sediaan Farmasi

Grafik Capaian Indikator Kekosongan Stok Farmasi

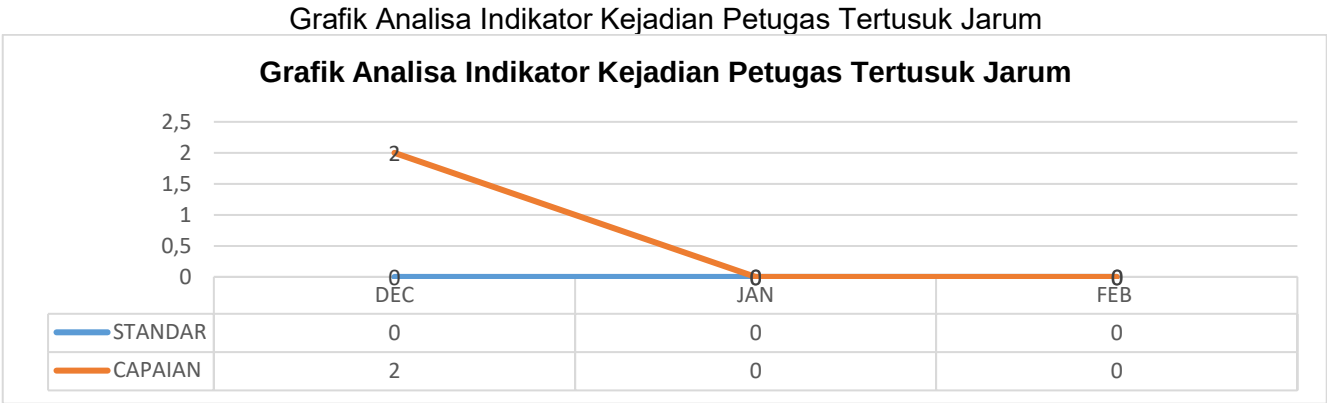


PLAN	Kami berencana Menurunkan angka kekosongan stok farmasi				
DO	Melakukan Analisa perhitungan waktu pengajuan hingga barang datang dengan kebutuhan, sehingga petugas dapat memperkirakan sediaan yang harus segera diinput pada pengadaan.				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui masih terjadi kekosongan stok farmasi yang disebabkan karena : - Barang yg sudah dipesan di pbf belum dikirim karena : - Barang sedang kosong distributor - Sp yg dikirim ke salesman belum terinput di data pemesanan pbf - Barang memang sedang kosong nasional karna bahan baku tidak ada - Human eror, bisa jadi terselip di defecta jd belum minta ke pengadaan - Barang yg awalnya slow moving, tiba2 jd fast moving. Banyak dipakai oleh dpjp ybs, padahal sebelumnya jarang sekali - Ada barang tertentu yg sedang dilakukan penyesuaian harga bpjs jadi belum bisa di jual oleh pbf - Ijin edar obat tertentu belum di setujui bpom, seperti kasus per sirup an kemarin				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Mengurangi angka kekosongan stok farmasi	- Mengurangi angka kekosongan stok farmasi	- Tidak ada kekosongan stok obat di farmasi	Memperbaruhi surat perjanjian kerjasama yang berisi tentang ketepatan waktu pengiriman obat setelah gudang farmasi order.	-Kepala Instalasi farmasi -Pengadaan Farmasi PT	- Satu bulan

d. Manajemen Resiko

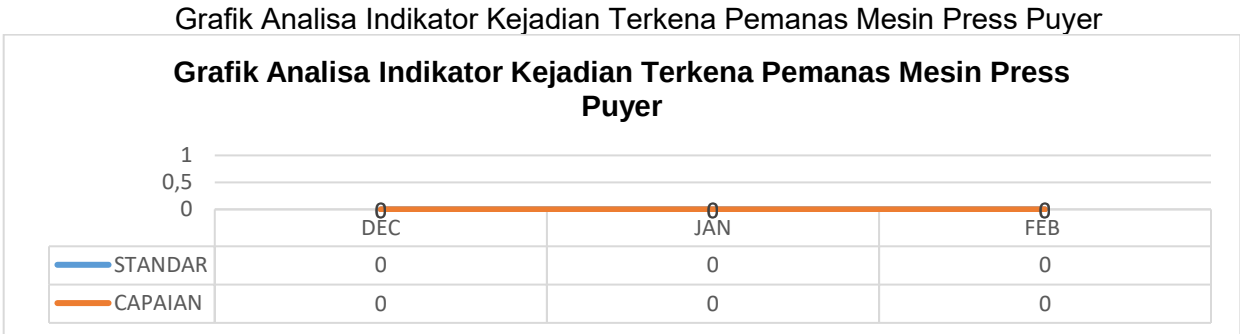
NO	JUDUL	STAND	DES '23	JAN '24	FEB '24
1	Kejadian petugas tertusuk jarum bekas pasien (pajanan)	0	2	0	0
2	Kejadian terkena pemanas mesin press puyer	0	0	0	0

1. Kejadian Petugas Tertusuk Jarum



PLAN	Kami berencana untuk menurunkan kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan) seminimal mungkin (0).				
DO	- Menginputkan laporan pada surveilans SIMRS dan kolaborasi dengan K3RS dan SDM. - Mengevaluasi keadaan luka pasien dan kondisi penyakit sumber pajanan. - Melakukan supervise terkait pengolahan benda tajam dan penyuntikan yang aman. - Melakukan supervise terkait penggunaan APD yang benar sesuai transmisi dan tindakan yang akan dilakukan.				
STUDY	Pada bulan ini tidak ditemukan kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan).				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Melakukan penyuntikan aman.	Mempertahankan capaian kejadian pajanan 0 kejadian.	Tercapainya standar pajanan 0 kejadian setiap bulannya.	Mempertahankan kegiatan penyuntikan yang aman karena sudah meminimalisir kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien.	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan

2. Kejadian Terkena Pemanas Mesin Press Puyer



Analisis
Dari data diatas dapat diketahui bahwa tidak ada kejadian terkena pemanas mesin press puyer sejak bulan Desember tahun 2023 hingga bulan Februati tahun 2024.

3.1 Instalasi Gawat Darurat

NO	JUDUL	STAND	DES '23	JAN '24	FEB '24
1.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	96,41%	100%	96,25%
2.	Angka Tidak Terpasangnya Gelang Identitas Pasien IGD	0%	0%	0%	0,17%
3.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	87,16%	100%	100%
4.	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	1,15%	0,7%	0,85%
5.	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi	≥80%	100%	100%	100%

3.2 IRNA 2C

NO	JUDUL	STAND	DES '23	JAN '24	FEB '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	89,15%	93,41%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	69,23%	80%	73,53%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	0%	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	96,8%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	4,26%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%		94,7%	100%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%		86,49%	86,36%

3.3 IRNA 3A

NO	JUDUL	STAND	DES '23	JAN '24	FEB '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	95,12%	93,18%	89,4%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0,75%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%		84,96%	87,65%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%		-	-

3.4 IRNA 4A

NO	JUDUL	STAND	DES '23	JAN '24	FEB '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	66,7%	94,84%	78,23%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	93%	71,83%	97%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0,75%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%		100%	90,75%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%		-	-

3.5 IRNA 3C ANAK

NO	JUDUL	STAND	DES '23	JAN '24	FEB '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	95,92%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	43,48%	100%	100%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	0%	0%	0%
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%		100%	100%
7.	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%		-	-

3.6 IRNA 5C

NO	JUDUL	STAND	DES '23	JAN '24	FEB '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	65,59%	62,07%	66,86%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0,54%	0,54%	0,55%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%		99,13%	97,75%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%		86,49%	100%

3.7 IRNA 6A

NO	JUDUL	STAND	DES '23	JAN '24	FEB '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	55,06%	61,11%	79,63%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0,14%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator baru 2024)	100%		100%	100%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator baru 2024)	100%		100%	100%

3.8 IRNA 7A

NO	JUDUL	STAND	DES '23	JAN '24	FEB '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	65%	58,22%	76,67%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	96,67%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator baru 2024)	100%		100%	86,52%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator baru 2024)	100%		-	-

3.9 IRNA 8A

NO	JUDUL	STAND	DES '23	JAN '24	FEB '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	73,3%	54,39%	78,49%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	99,15%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator baru 2024)	100%		100%	100%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator baru 2024)	100%		-	100%

3.10 ICU

NO	JUDUL	STAND	DES '23	JAN '24	FEB '23
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	98,07%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	96%	100%	100%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-		
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	87,75%	81,8%	92,53%
5	Angka kelengkapan asesmen pasien tahap akhir kehidupan	100%	-	100%	100%
6	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk ICU.	100%	100%	100%	100%
7	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	1,92%	-	0%

3.11 HCU

NO	JUDUL	STAND	DES '23	JAN '24	FEB '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	100%	100%	100%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%
5	Angka kelengkapan asesmen pasien tahap akhir kehidupan	100%	-	-	-
6	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk HCU	100%	100%	100%	100%
7	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%

3.12 IRJA

No	Judul	Stand	Des '23	Jan '24	Feb '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	99,75%	100%
2	Waktu tunggu rawat jalan	≥80%	91,73%	95,2%	91%
3	Ketepatan Waktu Jam Praktek Dokter	100%	85,27%	84,42%	82,35%
4	Angka rujukan horizontal FKRTL	0%	0%	0%	0%

3.13 Maternitas

NO.	JUDUL	STAND	DES '23	JAN '24	FEB '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%
2	Waktu tanggap operasi Seksio Sesarea Emergensi.	≥80%	100%	100%	100%
A3	Kepatuhan waktu visite dokter.	≥80%	100%	99,44%	100%

4	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥80%	100%	100%	100%
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh.	100%	100%	100%	100%
6	Angka keterlambatan operasi sectio caesaria (SC) > 30 menit	<5%	0%	0%	0%
7	Angka keterlambatan penyediaan darah > 60 menit	<10%	0%	0%	0%
8	Angka kematian ibu	0%	0%	0%	0%
9	Kejadian perdarahan post partum	0	0	0	0
10	Kejadian partus lama	0	0	1	2
11	Kejadian eklamsi	0	0	0	0
12	Kejadian pre eklamsi	0	6	3	1
13	Kejadian infeksi nifas	0	0	0	0
14	Angka ketidaklengkapan 10T pada ANC	0%	0%	0%	0%
15	Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP	100%	7,63%	3,82%	0,83%
16	Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	100%	7,56%	3,82%	0,83%
17	Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran	0	0	0	0
18	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%

3.14 NICU

NO	JUDUL	STAND	DES '23	JAN '24	FEB '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	≥80%	-	-	-
3	Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	100%	100%	100%	100%
4	Kepatuhan waktu visite dokter	≥80%	82,98%	85,92%	90,63%
5	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	4,17%
6	Angka Kematian Bayi	0	0%	0%	0%
7	Kejadian tidak dilakukannya IMD (inisiasi menyusui dini) pada bayi baru lahir	0	13	0	0

4.15 IKO

NO	JUDUL	STAND	DES '23	JAN '24	FEB '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien.	100%	100%	100%	100%
2	Penundaan operasi elektif.	≤ 5%	0%	0%	0%
3	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh.	100%	96,65%	100%	100%
4	Kejadian keterlambatan operasi> 30 menit	0	0	0	10

5	Kejadian konversi tindakan anestesi dari local/regional ke general	0	0	0	0
6	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring pemulihan anestesi dan sedasi dalam	0	0	0	0
7	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring fisiologis selama anestesi	0	0	0	0
8	Kejadian tidak dilaksanakannya asesmen pra sedasi dan pra anestesi	0	0	0	0
9	Kejadian tidak dilaksanakannya pemantauan diskrepansi diagnose pre dan post op	0	0	0	0
10	Kejadian tidak dilaksanakan SSC	0	0	0	0
11	Kejadian tidak lengkapnya asesmen pra bedah	0	0	0	0
12	Kejadian tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi	0	0	0	0
13	Kejadian ketidaklengkapan formular penandaan pasien operasi	0	0	0	0
14	Angka ketidakhadiran dokter anak saat operasi SC (indikator baru 2024)			0	0

3.16 Laboratorium

NO	JUDUL	STAND	DES '23	JAN '24	FEB '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%
2	Pelaporan hasil kritis laboratorium	100%	98,88%	98,69%	98,8%
3	Kejadian Pengulangan Phlebotomi Saat Sampling	0	6	3	2
4	Kejadian salah input hasil laboratorium	0	0	0	0
5	Waktu Tunggu Hasil Laboratorium >140 menit (Indikator baru 2024)	0%		0%	0%

3.17 Radiologi

NO	JUDUL	STAND	DES '23	JAN '24	FEB '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%
2	Angka ketidaklengkapan permintaan form radiologi	0%	3,15%	3,72%	3,61%
3	Kejadian Ketidakpatuhan persiapan pasien USG (Indikator baru 2024)	0		1	0

3.18 Gizi

NO	JUDUL	STAND	DES '23	JAN '24	FEB '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	99,76%	100%
2	Kejadian kesalahan pemberian diit	0	0	1	0
3	Kejadian adanya benda asing dalam makanan	0	0	0	0
4	Kejadian Pasien Tidak Mendapat Makan	0		0	1

3.19 Farmasi

NO	JUDUL	STAND	DES '23	JAN '24	FEB '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	70,26%
2	Kepatuhan penggunaan formularium Nasional	≥80%	100%	100%	100%
3	Kejadian kesalahan penyiapan obat	0	1	1	0
4	Kejadian kesalahan penempelan label pada obat LASA	0	0	0	0
5	Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	0%	65,43%	68,81%	69,59%
6	Angka keterlambatan penyiapan obat racikan >60 menit.	0%	44,7%	41,48%	50,77%
7	Kejadian kesalahan pemberian obat	0	0	0	0
8	Kejadian kesalahan penulisan etiket obat.	0	0	0	0
9	Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert	0	0	0	0
10	Kejadian kesalahan input e-resep	0	0	0	0
11	Kejadian petugas tertusuk jarum	0	0	0	0
12	Kejadian terkena pemanas mesin press puyer	0	0	0	0
13	Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap	0	0	0	0

3.20 Pengadaan Farmasi

NO	JUDUL	STAND	DES '23	JAN '24	FEB '24
1	Kekosongan stok farmasi	0%	0,27%	0,27%	0,36%

3.21 PPI

NO.	JUDUL	STAND	DES '23	JAN '24	FEB '24
1.	IDO (Infeksi Daerah Operasi)	≤ 2 %	0,31%	0,24%	0,8%
2.	IADP (Infeksi Aliran Darah Primer)	≤3,5‰	0‰	0‰	0‰
3.	VAP (Ventilation Associated Pneumonia)	≤ 5,8 ‰	0‰	0‰	0‰
4.	ISK (Infeksi Saluran Kencing)	≤ 4,7 ‰	0‰	0‰	0‰
5.	Infeksi Aliran Darah Perifer /ILI (Phlebitis)	≤ 5 %	0,18%	0,28%	0,22%
6.	Decubitus	0%	0%	0%	0%
7.	Angka kepatuhan kebersihan tangan	>85%	85,97%	85,86%	85,88%
8.	Angka kepatuhan penggunaan APD oleh petugas	100%	92,77%	93,04%	93,05%
9.	Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius di Unit Pelayanan	100%	91,35%	91,91%	92,09%
10.	Kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan)	0	2	0	0

3.22 PIPP

NO.	JUDUL	STAND	DES '23	JAN '24	FEB '24
1	Angka Terhubungnya Display TT Dengan Mobile JKN	100%	100%	100%	100%
2	Angk Terhubungnya Operasi Dengan Mobile JKN	100%	100%	100%	100%
3	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	100%	100%	100%	93,15%
4	Kepuasan Pasien	76,61%	99,19%	100%	91,89%
5	Kepatuhan Petugas Dalam Mengumpulkan Kuesioner Kompalin dan Kepuasan Pelanggan (Indikator baru 2024)	100%		86,94%	75,31%

3.23 SDM

NO.	JUDUL	STAND	DES '23	JAN '24	FEB '24
1	Kejadian keterlambatan pengurusan SIP/SIK.	0	2	0	0
2	Angka kedisiplinan staf terhadap finger print.	100%	98,42%	98,99%	98,97%
3	Angka keterlambatan kehadiran staf	0%	2,97%	3,32%	3,34%

3.24 Rekam Medis

NO.	JUDUL	STAND	DES '23	JAN '24	FEB '24
1	Angka kejadian nomor rekam medis ganda.	0%	0%	0%	0%
2.	Kejadian kendala pada SIMRS dalam upaya menunjang pelayanan rekam medis rekam medis elektronik (Indikator baru 2024)	0		0	0
3.	Kelengkapan Inform Consent Setelah Mendapatkan Informasi (Indikator baru 2024)	100%		100%	100%
4.	Kejadian pasien tidak di SEP(Indikator baru 2024)	0		0	0
5.	Kelengkapan Keakuratan Pada Penginputan Data Pasien di SIMRS (Indikator baru 2024)	100%		100%	100%

3.25 Keuangan

NO	JUDUL	STAND	DES '23	JAN '24	FEB '24
1	Angka keterlambatan pembayaran klaim lebih dari 90 hari	0%	12,96%	7,7%	6%
2	Kejadian piutang umum atas permintaan sendiri	0	0	0	0
3	Angka keterlambatan pembayaran klaim BPJS	0%	0%	0%	0%

3.26 K3RS

NO	JUDUL	STAND	DES '23	JAN '24	FEB '24
1	Angka kepatuhan petugas melakukan pengecekan APAR.	100%	100%	100%	100%
2	Kejadian kebakaran di ruangan.	0	0	0	0

3.27 Asuransi Center

NO.	JUDUL	STAND	DES '23	JAN '24	FEB '24
1	Angka pending klaim BPJS	0%	0,45%	1,07%	1,04%
2	Angka kelengkapan dokumen rekam medik pasien BPJS rawat inap	100%	24%	26,59%	25,75%
3	Prosentase readmisi pasien rawat inap	0%	1,82%	1,69%	1,04%
4	Angka kelengkapan berkas klaim di SIMRS (Indikator baru 2024)	100%		9,73%	0,57%
5	Keterlambatan pengumpulan DRM pasien rawat inap lebih dari 24 jam (Indikator baru 2024)	0%		3,92%	3,92%

3.28 IPSRS

NO	JUDUL	STAND	DES '23	JAN '24	FEB '24
1	Angka Keterlambatan penanganan pelaporan kerusakan oleh unit dalam 1x 24 jam	0%	100%	100%	91%

3.29 UMUM

NO	JUDUL	STAND	DES '23	JAN '24	FEB '24
1	Keterlambatan barang datang di Gudang	0	3	3	7
2	Ketidakpatuhan pengambilan barang oleh unit	0	5	11	4

3.30 Cleaning Service

NO	JUDUL	STAND	NOV '23	DES '23	JAN '24
1	Angka ketidakpatuhan penggunaan spillkit	0%	0,22%	1,39%	1,67%

3.31 Kesekretariatan

NO	JUDUL	STAND	DES '23	JAN '24	JAN '24
1	Angka keterlambatan pengumpulan laporan bulanan unit tanggal 5 setiap bulannya	0%	12,5%	2,28%	0%
2	Angka ketidaklengkapan pengumpulan dokumen meeting RS 1x 24 jam hari kerja	0%	0%	25%	100%
3	Angka tindaklanjut balasan surat masuk eksternal lebih dari 2x24 jam	0%	0%	65%	-

3.31 Laundry

NO	JUDUL	STAND	DES '23	JAN '24	FEB '24
1	Angka keterlambatan penyediaan linen	0%	1,14%	0%	5,2%
2	Kejadian linen ruang perawatan hilang	0	0	0	0

3.33 CSSD

NO	JUDUL	STAN	DES '23	JAN '24	FEB '24
1	Kejadian ditemukannya instrument hilang	0	0	1	0
2	Kejadian instrument kurang	0	0	1	0

3.34 Humas dan Pemasaran

NO	JUDUL	STAND	DES '23	JAN '24	FEB '24
1	Angka kunjungan rawat inap >80 pasien perhari	0%	100%	99,17%	90,88%
2	Angka kunjungan rawat jalan >300 pasien perhari	0%		93,71	100%

3.35 IT

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24
1	Kejadian downtime	0	0	0
2	Respon time penanganan internet dan billing error < 30 mnt	100%	100%	100%
3	Respon Time untuk penanganan computer < 15 menit	100%	96,97%	100%

3.36 Kamar Jenazah

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24
1	Pencatatan kematian pasien di kamar mayat (registrasi) < 2jam	100%	100%	100%

E. Permasalahan Rumah Sakit Rumah Sakit

1. Permasalahan Instalasi Kamar Operasi (IKO)

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Permintaan FS yang diberi tidak sesuai permintaan dengan alasan barang di farmasi kosong, sehingga kami harus melakukan permintaan farmasi dan mengambil barang ke farmasi	P	Memperbaiki sistem Floor Stok di IKO
		D	Membuat alur dan SPO yang tepat untuk penggunaan obat dan BMHP di farmasi
		S	Monitoring, evaluasi dan supervise dari Karu IKO dan Ka.Inst Farmasi untuk pengadaan obat dan BMHP di IKO
		A	Langsung melakukan pencatatan dan melakukan pelaporan untuk stok obat dan BMHP yang terdapat selisih

2. Permasalahan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Ada komplain pasien yang mengaku tidak segera mendapat pelayanan padahal setelah ditelusur sebenarnya pasien masuk di triase hijau dan ditangani sesuai kegawat daruratannya	P	Menggalakkan edukasi pada pasien mengenai triase, pasien ditangani berdasarkan kegawat daruratannya
		D	Dokter IGD dan perawat sudah mengedukasikan hal tersebut kepada pasien
		S	Karena load IGD yang cukup tinggi terkadang dokter dan perawat tidak sempat mengedukasi semua pasien satu persatu
		A	Memberikan tanda / sign di bed pasien, mengenai triase dan Tindakan yang sudah dilakukan
2	Masih ada rujukan pro ventilator padahal RS sudah memiliki ventilator dan dokter spesialis anestesi bersedia melakukan intubasi	P	Mengurangi jumlah rujukan pro ventilator
		D	Mengkomunikasikan pada DPJP mengenai ventilator
		S	Terdapat 1 DPJP yang masih merujuk pro ventilator dengan alasan takut plafon jebol
		A	Kembali mendatangi DPJP dan menyampaikan bahwa penggunaan ventilator >96 jam dapat top up plafon

3. Permasalahan Rawat Inap

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Pasien komplain karena ketidakpuasan penjelasan DPJP	P	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas dari DPJP pada pasien
		D	Menyampaikan complain pasien secara langsung ke DPJP dan meminta DPJP untuk lebih komunikatif pada pasien
		S	Ada DPJP yang tidak mengindahkan masukan manajemen
		A	Mengalihkan pasien dengan risiko complain pada DPJP dengan skill komunikasi yang lebih Memberikan OPPE pada DPJP tiap 3 bulan
2	Pasien tidak mengenali perawatnya	P	Membuat pelatihan komunikasi efektif evaluasi bagaimana diklat
		D	1. Menjalankan lagi operan yang tidak terlaksana 2. Mendisiplinkan lagi perawat yang tidak pakai nametag
		S	Beberapa perawat tidak memperkenalkan saat akan melakukan tindakan yang akan dilakukan
		A	1. Mengadakan rapat internal antara para karu

			2. Monitoring dan evaluasi setelah di jalankan oleh perawat 3. Harus selalu memakai nametag saat bekerja
3	Rekam medis tidak lengkap	P	Kepala ruang harus selalu supervisi kelengkapan rekam medis
		D	Supervisi setiap saat oleh kepala ruang kepada rekam medis yang di kerjakan oleh stafnya
		S	Perawat tidak tertib dalam pengisian rekam medis
		A	Melakukan supervisi secara berkala sehingga rekam medis lengkap
4	Matras Bed Penunggu pasien kurang banyak	P	Melakukan proses telusur penyebab kekurangan matras
		D	Mencatat/mendata ruangan yang butuh
		S	Berkoordinasi dengan kepala CS untuk perbaikan matras
		A	Melakukan supervisi setiap saat

4. Permasalahan Rawat Jalan

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Ruangan audiometri belum pindah,sehingga tidak bisa melakukan tindakan audiometri	P	Merencanakan perpindahan ruangan audiometri secepatnya
		D	Tim iprs segera menindaklanjuti ruangan audiometri untuk ruangan yang baru
		S	Mengevaluasi ruangnya yang akan disiapkan untuk di tempati audiometri
		A	Kepala ruangan harus segera koordinasi dengan tim iprs untuk segera perpindahan ruangan audiometri
2	Pindahan poli ke lantai 2,pasien sebagian besar masih bingung	P	1. Berkoordinasi dengan security dan tim umum jika ada pasien masih bingung langsung di arahkan 2. Membuat petunjuk arah sehingga pasien langsung mengerti
		D	Megajukan ke bagian pengadaan umum untuk membuat petunjuk arah
		S	Monitoring dan mengevaluasi dengan adanya petunjuk arah dan security
		A	Sering supervisi kebawah untuk melihat pasien yang masih bingung
3	Ruang laktasi sudah ada tetapi isinya masih kosong	P	Membuat laktasi yang nyaman untuk ibu menyusui
		D	Mengajukan peralatan ke pengadaan umum perlengkapan yang kurang
		S	Dari pedoman rumah sakit ruang laktasi ini diperlukan
		A	Menginput barang barang yang akan di ajukan

5. Permasalahan Instalasi Farmasi

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Selisih stok di Depo Farmasi, Gudang Farmasi dan Floorstock IKO	P	Memperbaiki sistem floorstock di IKO
		D	Koordinasi dengan programmer terkait sistem IKO untuk meminimalisir terjadinya selisih dan membuat kesepakatan alur dengan petugas IKO

		S	Monitoring, evaluasi dan supervise dari Karu IKO dan Ka IFRS untuk pengadaan obat dan BMHP di IKO
		A	Melakukan pencatatan dan melakukan pelaporan untuk stok obat dan selisih
2	Penulisan Kartu Pengambilan Obat (KPO) yang masih manual	P	Mengajukan penambahan fitur KPO digital
		D	Koordinasi dengan programmer perihal pengadaan KPO billing untuk target realisasi dan membantu DPJP dalam penulisan obat agar mudah terbaca.
		S	1) Mempermudah PPA melihat riwayat pemberian obat. 2) Mengurangi complain pasien akibat pasien lupa membawa KPO.
		A	Kains mempunyai target untuk segera menerapkan system KPO digital.
3	Penulisan kartu stok di Depo, IKO dan Gudang farmasi yang masih belum berjalan baik	P	Menegakkan punishment kedisiplinan penulisan kartu stok Memenuhi petugas farmasi di IKO
		D	Monitoring dan evaluasi petugas farmasi dalam melakukan pelayanan (barang masuk dan keluar) dengan tetap menuliskan pada kartu stok Koordinasi dengan SDM terkait evaluasi kinerja
		S	Petugas lebih teliti dan disiplin ketika menghitung pemasukan atau pengeluaran
		A	Kains melakukan supervise setiap hari
4	Terjadi kekosongan obat sehingga pelayanan tidak maksimal	P	Memperbaiki sistem ROP
		D	1) Melakukan evaluasi beberapa rumus ROP kemudian menetapkan rumus yang akan digunakan. 2) Koordinasi dengan programmer untuk mengaplikasikan rumus ROP yang disepakati kedalam sistem.
		S	1) Mempersingkat proses order. 2) Meminimalisir petugas kelewat order.
		A	Kains mempunyai target untuk segera menerapkan rumus ROP yang sudah disepakati.

6. Permasalahan Laboratorium

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Terjadi keterlambatan hasil pemeriksaan PA	P	Memperbaiki alur penerimaan hasil PA rujukan
		D	Koordinasi dengan Sp.PA dan analis untuk kesepakatan pengiriman hasil pemeriksaan
		S	Analisis mempunyai tanggungjawab terkait hasil pemeriksaan laboratorium rujukan karena berkaitan dengan klaim
		A	1) Menghubungi dr Berlian, Sp.PA untuk kesepakatan hasil pemeriksaan maksimal 4x24 jam sesuai SPO 2) Analisis melakukan pencatatan dan follow up hasil sebelum batas waktu maksimal
2	Terjadi kelalaian petugas tidak konfirmasi ruangan terkait kedatangan labu darah	P	Memperbaiki alur penerimaan labu darah.
		D	Review SPO
		S	Labu darah terinput ke pasien dan dapat di klaim
		A	Koordinasi dengan Karu terkait perbaikan SPO, pencatatan nama perawat yang menerima telpon wajib tertulis dan disertakan bukti WA.

7. Permasalahan Rekam Medis

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Tidak bisa menarik data asuhan gizi rawat jalan karena belum terdapat fitur di RM-e	P	Memiliki fitur asuhan gizi di rawat jalan untuk kebutuhan pelaporan internal dan Dinkes.
		D	Permintaan fitur ke programmer sudah dilakukan, menunggu antrian.
		S	Ahli Gizi bisa menyampaikan hasil asuhan gizi pasien rawat jalan di RM-e untuk kebutuhan penarikan data oleh Instalasi RM dan pelaporan.
		A	Follow up ke Programmer.
2	Kelengkapan ERM rawat jalan belum mencapai standar dan tidak bisa tervalidasi	P	Membuat list kekurangan form rawat jalan dan permasalahan ERM rawat jalan, kemudian diserahkan ke Programmer.
		D	1) Mengisi permasalahan yang ditemukan di link google spreadsheet. 2) Koordinasi dengan Programmer untuk ditindaklanjuti.
		S	Memudahkan DPJP dan PPA dalam melakukan pengisian.
		A	Koordinasi dengan Programmer.
3	Penumpukan DRM IRNA dan IRJA karena perpindahan tempat	P	Membuat plotting jadwal untuk target penyelesaian perpindahan DRM dan penyelesaian tugas utama di RM, Filing, Asembling dan Analisa.
		D	Melakukan plotting petugas dan supervise oleh Kabid
		S	Menyelesaikan sesuai jadwal.
		A	Pengkondisian jadwal oleh Kains.

F. Profil SDM
a. Komposisi dan Distribusi SDM

NO	UNIT	PENDIDIKAN	FEBRUARI				
			TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	0	1	0
2	Kabid Pelayanan Medik	Dokter Umum	1	1	0	1	0
3	Kabid Penunjang Medik	Bidan	1	1	1	0	0
4	Kabid Umum Keuangan	Dokter Gigi	1	1	0	1	0
5	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	1	1	0	1	0
6	Dokter IGD	Dokter Umum	7	7	0	7	0
7	Dokter Ruangan	Dokter Umum	1	1	0	1	0
8	Farmasi	SMA	34	7	0	7	0
		D3 farmasi		12	3	9	0
		S1 Farmasi		4	1	3	0
		D3 Analisis Kimia		1	0	1	0
		S1 Apoteker		10	0	10	0
11	Asuransi Center	SMA	11	2	2	0	0
		D3 Kes		3	0	3	0
		D3 RMIK		5	2	3	0
		D3 Asuransi Kes		1	0	1	0
		D4 RMIK		0	0	0	0
12	CSSD	D3 Keperawatan	4	1	1	0	0
		SMA		3	1	2	0
13	Fisioterapi	D3 Fisioterapi	4	3	2	1	0
		D4 Terapi Wicara		1	0	1	0
14	Gizi	SMA	10	10	2	8	0
		D3 Gizi	6	2	2	1	0
		D4 Gizi		2	0	2	0
		S1 Gizi		2	1	1	0
15	Humas & Marketing	SKM	2	2	0	2	0
16	ICU dan HCU	D3 Kebidanan	15	1	1	0	0
		D3 Keperawatan		5	0	5	0
		Profesi Ners		9	4	5	0
17	IGD	D3 Kebidanan	22	2	2	0	0
		D4 Kebidanan		2	0	2	0
		D3 Keperawatan		9	1	8	0
		D4 Keperawatan		1	0	1	0
		Profesi Ners		8	1	7	0
18	IKO	D3 Kebidanan	11	1	1	0	0
		D3 Keperawatan		4	1	3	0
		Profesi Ners		6	3	3	0
19	IPCN	Profesi Ners	1	1	1	0	0
20	IPSRs	D3 TEM	1	1	0	1	0
		SKM	1	1	0	1	0
		S1 Teknik	4	1	0	1	0
		SMA		3	1	2	0
27	IRJA	D3 Kebidanan	25	5	3	2	0
		D3 Keperawatan		13	6	7	0
		Profesi Ners		6	3	3	0

28	IRNA 2C	D3 Keperawatan	8	2	0	2	0
		Profesi Ners		6	1	5	0
29	IRNA 6A & 7A & 8A	D3 Keperawatan	21	12	0	12	0
		D4 Keperawatan		4	0	4	0
		Profesi Ners		3	0	3	0
30	IRNA 3C Anak	D3 Keperawatan	14	8	3	5	0
		D4 Keperawatan		1	0	1	0
		Profesi Ners		5	0	5	0
31	IRNA 3A & 4A	D3 Keperawatan	18	9	0	9	0
		Profesi Ners		9	2	7	0
32	IRNA 5C	D3 Keperawatan	10	6	0	6	0
		Profesi Ners		4	0	4	0
33	Maternitas	D3 Kebidanan	11	9	9	0	0
		D4 Kebidanan		2	1	1	0
34	Neonatologi	D3 Keperawatan	9	5	0	5	0
		Profesi Ners		4	3	1	0
35	Keuangan dan Akuntansi	SMA	9	4	1	3	0
		S1		4	3	1	0
		D3 Keuangan		1	0	1	
36	Laboratorium	D3 Kesehatan	10	4	0	4	0
		D3 Analisis Kesehatan		4	1	3	0
		D4 Analisis Kesehatan		2	0	2	0
37	Laundry	SMA	5	5	3	2	0
38	Rekam Medik	D3 Kesehatan	10	1	0	1	0
		D3 RMIK		8	4	4	0
		D4 RMIK		1	0	1	0
39	Pendaftaran	SMA	15	8	1	7	0
		D3 RMIK		4	2	2	0
		D3 Kesehatan		1	0	1	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	0	1	0
		D4 Manajemen		1	0	1	0
40	PIPP	Ners	4	1	1	0	0
		D3 Keperawatan		1	0	1	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
		D4 Kebidanan		1	1	0	0
41	PMKP	Profesi Ners	1	1	0	1	0
42	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	7	7	0	7	0
43	SDM	S1 Psikologi	2	2	0	2	0
44	Sekretaris	S1 Administrasi Perkantoran	1	1	0	1	0
45	SIMRS & IT	S1 Komunikasi	4	4	0	4	0
46	Umum	S1 Ekonomi	1	1	1	0	0
47	Cleaning Service	SMP	41	3	1	2	0
		SMA		38	5	33	0
48	Security	SMA	11	11	4	7	0
49	Driver	SMA	5	5	1	4	0
50	Gudang Umum	SMA	1	1	1	0	0
51	Orientasi Bidan dan Perawat	D4 Kebidanan	13	2	0	2	0
		Profesi Bidan		1	0	1	0

		D3 Perawat		9	0	9	0
		Profesi Ners		1	0	1	0
52	Dokter Spesialis Anak		2	2	0	2	0
53	Dokter Spesialis Syaraf		3	3	0	3	0
54	Dokter Spesialis Jantung		3	3	0	3	0
55	Dokter Spesialis Paru		2	2	0	2	0
56	Dokter Spesialis Penyakit Dalam		4	4	0	4	0
57	Dokter Spesialis Anestesi		2	2	0	2	0
58	Dokter Spesialis Bedah		3	3	0	3	0
59	Dokter Spesialis Bedah Plastik		1	1	0	1	0
60	Dokter Spesialis Orthopedi		3	3	0	3	0
61	Dokter Spesialis Patologi Anatomi		1	1	0	1	0
62	Dokter Spesialis Patologi Klinis		1	1	0	1	0
63	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi		1	1	0	1	0
64	Dokter Spesialis Mata		2	2	0	2	0
65	Dokter Spesialis Urologi		2	2	0	2	0
66	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa		2	2	0	2	0
67	Dokter Spesialis Obstetry Ginekology		4	4	0	4	0
68	Dokter Gigi Spesialis Orthodontist		1	1	0	1	0
69	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin		2	2	0	2	0
70	Dokter Spesialis THT		2	2	0	2	0
71	Dokter Spesialis Gigi Periodonti		1	1	0	1	0
72	Dokter Spesialis Radiologi		3	3	0	3	0
TOTAL STAF			434	434	95	339	0

b. Update STR/SIP

NO	NAMA	PROFESI	TANGGAL KEJADIAN	KETERANGAN
1	-	-	-	-

G. Kemajuan Piutang

a. Data Piutang yang Belum Terbayar

Tabel Piutang BPJS Kesehatan (FPK dan Pengajuan Reguler Februarii 2024)

REKAPITULASI FPK BPJS KESEHATAN							
NO	PERIODE LAYANAN	TARIF FPK/ PENGAJUAN	TGL FPK	TGL BAYAR	REALISASI PEMBAYARAN	SELISIH AUDIT DAN ADM BANK	SALDO PIUTANG FPK
PELAYANAN 2023							
1	OBAT KRONIS SEPT 23	435.837.336	18.01.2024	29.01.2024	435.837.336		-
2	FPK REG UTAMA DES 23	6.189.055.000	18.01.2024	29.01.2024	6.189.055.000		-
3	FPK PEND OKT 23	235.480.288	20.12.2024	02.01.2024	206.379.388	29.100.900	-
4	FPK PEND NOV 23	261.599.399	07.02.2024	19.02.2024	235.809.299	25.790.100	-
5	OBAT KRONIS OKT 23	493.809.876	18.02.2024	26.02.2024	493.809.876		-
6	FPK LUPIS NOV 23 AMBULANCE	6.650.000	22.02.2024	28.02.2024	6.650.000		-
7	FPK LUPIS NOV 23 ALKES	6.215.000	22.02.2024	28.02.2024	6.215.000		-
8	FPK LUPIS DES 23 AMBULANCE	7.210.000	22.02.2024	28.02.2024	7.210.000		-
9	FPK LUPIS DES 23 ALKES	6.710.000	22.02.2024	28.02.2024	6.710.000		-
PELAYANAN 2024							
1	FPK Januari 2024	7.006.082.092	18.02.2024	28.02.2024	6.967.698.792	38.383.300	-
2	Pengajuan Februari 2024 (Belum FPK)	7.702.501.900					7.702.501.900
		22.351.150.891			14.555.374.691	93.274.300	7.702.501.900

Tabel Saldo Pending BPJS Kesehatan

REKAP KLAIM DAN PENDING BPJS KESEHATAN								
NO	PERIODE LAYANAN	JENIS	JML KLAIM	FPK	Tidak Layak	JML PEND	% PEND	NILAI PENDING
1	DES 23	RJ	11.353	11.338	5	15	0,1%	12.793.800
		RI	880	769	-	111	13%	601.217.500
2	JAN 24	RJ	12.393	12.336	1	57	0,5%	20.898.600
		RI	947	867	-	80	8%	456.960.000
								1.091.869.900

b. Analisa Progres Penyelesaian Piutang

PIUTANGASURANSI RS PRIMA HUSADA MALANG												
PERIODE 2024						Y	Z	AA	AB	AC		
NO	DESKRIPSI	SALDO AWAL PIUTANG	PEMBAYARAN (BULAN SEBELUMNYA)	PENAMBAHAN PIUTANG (BULAN BERJALAN)	PEMBAYARAN (BULAN BERJALAN)	SALDO AKHIR PIUTANG	UMUR PIUTANG					JUMLAH PIUTANG
		a	b	e	f	d+h	0-30 HARI	31-60 HARI	61-90 HARI	91-120 HARI	>120 HARI	Total
PERIODE JANUARI 2024 :												
1	Asuransi	110.572.807	71.247.004	191.134.523	22.638.021	206.299.002	201.616.628	2.817.099	547.888	189.660	1.127.727	206.299.002
2	Perusahaan	133.829.999	29.402.184	49.434.985	9.064.925	144.797.875	65.621.277	3.330.071	6.639.421	19.651.611	49.555.495	144.797.875
3	Mandiri Inhealth	116.338.738	60.563.430	16.118.255	-	72.081.850	39.816.302	7.070.709	16.414.664	8.780.174	-	72.081.850
4	Jasa Raharja	3.397.004	3.397.004	91.234.936	42.032.093	49.202.843	49.202.843	-	-	-	-	49.202.843
5	BPJS Ketenagakerjaan	1.212.915.730	25.840.770	451.499.587	-	1.638.574.554	1.195.285.236	384.504.702	58.485.116	-	299.500	1.638.574.554
						2.110.956.125	1.551.542.287	397.722.581	82.087.090	28.621.445	50.982.722	2.110.956.125
PERIODE FEBRUARI 2024 :												
1	Asuransi	206.380.429	148.318.181	143.353.244	53.734.951	143.899.993	134.908.620	8.885.251	1.080.548	-	1.025.574	143.899.994
2	Perusahaan	144.797.875	40.363.755	156.259.945	6.840.000	255.811.332	193.543.912	464.565	3.046.653	5.183.372	53.572.830	255.811.332
3	Mandiri Inhealth	72.081.850	44.316.925	33.891.983	-	56.071.219	56.071.219	-	-	-	-	56.071.219
4	Jasa Raharja	49.202.843	49.202.844	119.135.415	67.739.898	51.395.517	51.395.517	-	-	-	-	51.395.517
5	BPJS Ketenagakerjaan	1.638.574.554	734.056.180	377.992.816	-	1.281.261.928	1.203.248.878	9.233.194	38.384.452	30.095.903	299.500	1.281.261.928
						1.788.439.990	1.639.168.147	16.583.010	42.511.654	35.279.275	54.897.904	1.788.439.990

Keterangan :

- 1. Saldo Piutang per 29 Februari 2024 Rp 1.788.439.990,-
- 2. Piutang Perusahaan >120 hari PT Karya Bina Sentausa Sudah Lunas pada Desember 2023 namun ada rincian yang baru selesai proses rekonsiliasi di awal Maret 2024
- 3. Piutang BPJS ketenagakerjaan terbayar di bulan Februari Rp 734.056.180,-
- 4. Piutang Mandiri Inhealth Proses telaah dan pembayaran di bulan Maret 2024

c. UPDATE IKS

NO	INSTANSI	NAMA PKS	MASA BERLAKU	TANGGAL EXPIRED	NOMOR PKS RUMAH SAKIT	NOMOR PKS INSTANSI
1	PT. Lippo General Insurance	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	18 September 2019	18 September 2024	267/RSPHS/E-PKS/DOR/VI/2019	1502/LI-HOSPT/VI/2019
2	PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk (Asuransi MAG)	Fasilitas Rawat Inap dan Rawat Jalan	28 Januari 2020	27 Januari 2024	015/DPM/E-PKS/DIR/XI/2019	PKS-0097/XI/2019/MAG-R2
3	BPJS KESEHATAN	Pelayanan Penjamin Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program JKN	1 Januari 2024	31 Desember 2024	1879/E-PKS/DIR/XII/2023	602/KTR/VII-05/1223
4	BPJS KETENAGAKERJAAN	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan	1 Januari 2023	31 Desember 2024	1571/E-PKS/DIR/XII/2022	PER/60/102022
5	Avrist Assurance	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	24 Agustus 2023	24 Agustus 2025	951/PKS/PROV/IPOP/AVR-1494/VII/2023	
6	PT. Asuransi Mandiri Inhealth Manage Care Indonesia	Pelayanan Kesehatan & pelayanan obat	30 Januari 2023	31 Januari 2025	028.2/DPM/E-PKS/DIR/II/2023	0.32/AJII/KOP-SBY/PKS/0123
7	PT. Kartika Bina Medikatama (Medika Plaza)	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	26 Juni 2023	26 Juni 2026	103.1/DPM/E-PKS/DIR/IV/2023	358/KBM-DPM/PKS/VI/2023
8	PT. Jasa Raharja (Perseroan Perwakilan Malang)	Penanganan dan Penyelesaian Santunan Korban Kecelakaan	4 Juli 2022	4 Juli 2027	912.1/E-PKS/DIR/VII/2022	P/13/SP/2022

		Penumpang Angkutan Umum dan Lalu Lintas Jalan				
9	PT. Asuransi Allianz Life Indonesia	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	12 Desember 2017	perpanjang otomatis	-	729/AZLI-LGL/AG/XII/2017
10	PT. Global Asistensi Manajemen Indonesia (GAMI)	Perjanjian Layanan Kesehatan Rawat Jalan	26 AGUST 2019-PERPANJANG OTOMATIS	perpanjang otomatis	-	640/IP-OP/PKS/GAH/VIII/2019
11	PT. Fullerton Health Indonesia	Perjanjian kerjasama Pelayanan Kesehatan	26 Agustus 2019-perpanjangan otomatis	perpanjang otomatis		640/IP-OP/PKS/FHI/VIII/2019
12	PT PRUDENTIAL LIFE INSURANCE	Surat Kesepakatan Kerjasama Pelayanan Kesehatan	13 April 2020	perpanjang otomatis		3143/PMN-PA/IV/2020
13	PT AIA FINANCIAL	Perjanjian Kerja sama Pelayanan Kesehatan	4 November 2020	perpanjang otomatis	069/DPM/E-PKS/DIR/X/2020	639/AIA-DPM/XI/2020
14	PT. Medlinx Asia Teknologi (Medlinx)	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	28/11/2016-perpanjang otomatis	perpanjang otomatis	150/ PKS-RSPRIMAHUSADA-MAT/DIR/XI/2016	
15	PT. Asuransi AA Internasional	Pelayanan Kesehatan	19 September 2019	perpanjang otomatis	-	AAII/RS/E-384/PKS/Feb/2015
16	PT. SUPRIMA MITRA ADIHUSADA	Perjanjian Kerja sama Pelayanan Kesehatan	26/08/2019	perpanjang otomatis		640/IP-OP/PKS/TIRTA/VIII/2019
17	PT. EQUITY LIFE IND-CORPORATE	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	14/10/2019	perpanjang otomatis		091/ELI/LGL/X/19
18	PT. Axa Services Indonesia	Perjanjian Kerjasama	15 Agustus 2013 - perpanjang	perpanjang otomatis	-	067/AGR-Leg/ASI/VII/2013

		Layanan Kesehatan	otomatis			
19	PT. Asuransi Jiwa Sinarmas Msig	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan	09/10/2012	perpanjang otomatis	-	063/PKS - AJSMSIG-Rs / IX/ 2012
20	PT. Asuransi Jiwa Sinarmas	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Rawat Inap	09/04/2019	perpanjang otomatis	010/DPM/E-PKS/DIR/IX/2019	364/PKS-RS/PH.RI.ASM/IX/2019
21	PT. Hanwha Life Insurance Indonesia	Perjanjian Kerjasama Layanan Kesehatan	16 Maret 2015 - perpanjang otomatis	perpanjang otomatis	-	0088/HLI-GH/ PKS-RS/03-2015
22	PT. EQUITY LIFE IND-CASSLES	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	14/10/2019	perpanjang otomatis		090/ELI/LGL/X/19
23	PT. Asuransi Adira Dinamika	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	24 Oktober 2013	perpanjang otomatis	PH/E-IKS/171/X/2013	499B/AAD-LEG-AGR/X/2013
24	PT. Prima Sarana Jasa	Pelayanan Kesehatan	17 September 2018	perpanjang otomatis	735/E-PKS/DIR/IX/2018	296/GAN/PT-6/HOSP/SEP/2018
25	PT. BNI Life Insurance	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan	25/07/2019 24/07/2019	perpanjang otomatis	082/RSPH/E-IKS/DIR/II/2016	274.PKS.BL.DIR.0716
26	Administrasi Medika (Admedika)	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	28 April 2015 - perpanjang otomatis	perpanjang otomatis	025/RSPH/E-PKS/DIR/IV/2015	141/PKS/ADMEDIKA/IV/2015
27	Asuransi Jiwa Generali	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	10/10/19 - perpanjang otomatis	perpanjang otomatis	070/DPM/E-PKS/DIR/IX/2019	109/GI/OPS/Prov-SK/IX/2019
28	PT. Aplikanusa Lintasarta (Owlexa	Nota Kesepakatan Layanan	25/02/2015	perpanjang otomatis	PH/IKS/100/II/2015	095/LA/MoU/00300/2015

	Healthcare)	Pemeriksaan Kesehatan				
29	PT. Asuransi Takaful Keluarga	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan	02 Januari 2017	perpanjang otomatis	508/RSPH/E-IKS/DIR/XI/2016	0642/PKS-RS-01/I/2017
30	PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia	Perjanjian Pelayanan Kesehatan Peserta Individu	2 MARET 2020-PERPANJANG OTOMATIS	perpanjang otomatis	017/DPM/E-PKS/DIR/XI/2019	045-02/EB-CONT/2020
31	PT. AJ CENTRAL ASIA RAYA (CAR)	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	29/11/2019	perpanjang otomatis	795/E-ADD/DIR/XI/2019	DIR/PKS-ADD/RS/154/XI/2019
32	PT. Java Smartindo	Jasa Pengelolaan Administrasi Kesehatan	21/08/2020	Perpanjang otomatis	364/DPM/I-PKS/DIR/VIII/2020	PKS.TPA-JSMART.290/VIII/20/RS.SW.C
33	PT PLN Insurance	Asuransi Pelayanan Kesehatan	30/10/2019	Perpanjang Otomatis	612/RSPHS/E-PKS/DIR/X/2019	300/PKS/TKI/X/2019
34	PT. ASURANSI JASA INDONESIA	Perjanjian Kerja sama Pelayanan Kesehatan	28/08/2020 - 27/08/2023	perpanjang otomatis	PKS.031/GHASKES/157-1/2020	053/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2020
35	PT. Asuransi Reliance Indonesia	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan	7/9/2020 - 07/09/2025	perpanjang otomatis	490/RSPH/I-IKS/DIR/XI/2016	930.01/UM/ARI-RS/XI2016
36	PT. Pan Pacific Insurance	Pelayanan Perawatan dan Pengobatan	31/08/2020	perpanjang otomatis	017/DPM/E-PKS/DIR/VII/2020	0593-01/PKS/PRV-PANFIC/RS-PHMS/VIII/2020
37	PT. Jasindo Health Care	Pelayanan Perawatan dan Pengobatan	04/01/2015	perpanjang otomatis	-	-
38	PT. International Services Pacific Cross	Asuransi Pelayanan Kesehatan	10/03/2022	Perpanjang Otomatis	150/DPM/E-PKS/DIR/X/2022	953/ISPC/PKS/X/2022

39	PT. Kartika Bina Medikatama (Medika Plaza)	Perjanjian Pelayanan Kesehatan				
40	ASABRI	PELAYANAN PENGobatan DAN PERAWATAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PESERTA ASABRI AKTIF	13 Desember 2023	13 Desember 2026	1902/E-PKS/DIR/XII/2023	PERJ-182/HK.02.01/HBL.H/XII/2023
41	PT. Jasa Raharja (Perseroan Perwakilan Malang) (ADENDUM)	Penanganan dan Penyelesaian Santunan Korban Kecelakaan Penumpang Angkitan Umum dan Lalu Lintas Jalan	7 Februari 2023	4 Juli 2027		
42	PT. ASURANSI Jiwa BCA	Asuransi Pemberian Pelayanan Kesehatan	10 Oktober 2023	10 Oktober 2028	149/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2023	286/PKS/BCAL-PHMS/2023
43	Asuransi Jiwa Generali	PKS Asuransi Kesehatan				
44	Meditap (PT TEKNOLOGI PAMADYA ANALITIKA)	Asuransi Pelayanan Kesehatan				
45	BPM Silvian Wulandari	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	10 Maret 2021	10 Maret 2024	031/DPM/E-PKS/DIR/III/2022	
46	BPM Inung Indah sari	Rujukan Asuhan Pasien	10 Januari 2022	10 Januari 2025	004.1/DPM/E-PKS/DIR/I/2022	-

47	DINKES Kabupaten Malang	Pelaksanaan Kegiatan Skrining Tuberkulosis Pada Penyandang Diabetes Melitus Dengan Metode Radiologis		31 Desember 2023	1183/E-PKS/DIR/VII/2023	415.4/61/35.07.103/2023
48	BKKBN	pelayanan keluarga berencana iud dan implant	17 Januari 2024	17 Januari 2025	294/E-PKS/DIR/I/2024	
49	Klinik Dokter 24 Jam	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	2 Agustus 2022	2 Agustus 2025		
50	Klinik Mutiara Sehat	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	5 Januari 2022	5 Januari 2025	200.11/DPM/I- PKS/DIR/I/2022	
51	Klinik Rawat Inap Muslimat Singosari	Rujukan Asuhan Pasien	15 April 2023	15 April 2026	107.1/DPM/E- PKS/DIR/IV/2023	031.A/A.1/M/RSMS/02/IV/2023
52	KLINIK TIRTO HUSADA	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	18 September 2023	18 September 2026	176.3/DPM/E- PKS/DIR/IX/2023	015.004/KTH/IX/2023
53	Klinik BLKI Singosari	Rujukan Asuhan Pasien	24 April 2023	27 April 2026	108.1/DPM/E- PKS/DIR/IV/2023	150/0187B00/IV/23
54	Klinik Brawijaya Lawang	Rujukan Asuhan Pasien	3 Juli 2023	3 Juli 2026	144.1/DPM/E- PKS/DIR/VII/2023	PKS/115/VII/2023
55	Klinik Pratama Rawat Jalan Mawar Waskitha Husada	Pelayanan Asuhan Pasien & Penunjang	23 Januari 2024	20 Januari 2027	001.34/DPM/E- PKS/DIR/I/2024	
56	Klinik Husada Asih YPAC	Kerja sama Penunjang	11 September 2012 - Tanpa Batas Waktu	Tanpa Batas Waktu		
57	Klinik Jantung Hasna Medika Malang	Pelayanan Asuhan Pasien & Penunjang	1 Desember 2023	31 November 2026	241.2/DPM/E- PKS/DIR/XII/2023	023/PKS/DIR/HMMALANG/XII/2023

58	Klinik Idamamuk	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	16 Juni 2021	16 Juni 2024	347/DPM/I-PKS/DIR/VII/2021	005/VI/2021
59	Klinik 24 Jam	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	2 Agustus 2022	2 Agustus 2025	112.1/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2022	138/MOU/VIII/CSH.2022
60	Klinik Rawat Inap Wijaya Husada	Rujukan Asuhan Pasien	15 April 2023	15 April 2026	001/PKS/15/4/2023	113.2/DPM/E- PKS/DIR/V/2023
61	Klinik Endisa Husada	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	21 Juli 2023	21 Juli 2026	148.3/DPM/E- PKS/DIR/VII/2023	PK/01/VII/2023-KEH
62	Klinik Siaga Medika	Rujukan Pelayanan Kesehatan	3 Aoktober 2023	3 Oktober 2026	188/DPM/E- PKS/DIR/X/2023	14.30/KSM/VII/2023
63	Klinik Garuda	Pelayanan Kesehatan	31 Mei 2023	31 Mei 2025	131.2/DPM/E- PKS/DIR/V/2023	B/25/VI/2023
64	Klinik Losari Medika	Pelayanan Asuhan Pasien & Penunjang	6 Februari 2024	6 Februari 2027	021/DPM/E- PKS/DIR/II/2024	
65	Laboratorium Panglima Sudirman	Pelayanan Rujukan Laboratorium	5 Juni 2023	5 Juni 2026	135.2/DPM/E- PKS/DIR/VI/2023	Q.0150/LKPS.VI/25.2023
66	CV. Galaxy Mulia Cahaya	PKS Alat Protosa Ortesa				
67	PT. ETERCON PHARMA	Sponsorship Maternity Kit Free untuk pasien Maternitas	1 Juni 2023	1 Juni 2024	132.1/DPM/E- PKS/DIR/VI/2023	039/ETC-CBX/PKS/VII/2023
68	PT. Kasoem Hearing	Pelayanan Pemasangan Alat Bantu Mendengar (ABM)	1 Maret 2022	1 Maret 2024	339.6/E- PKS/DIR/III/2022	002/KHC/KSO-SMAD/III/2022
69	PT. KTG (KENCANA TIARA GEMILANG)	Pelayanan Kesehatan	12 Desember 2021	12 Desember 2024	174.1/DPM/E- PKS/DIR/XII/2021	017/KTG/HRGA.06/XII/2021

70	PT. TSSA dan PT. Tenang Sejahtera	Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	23 Februari 2024	23 Februari 2025		
71	PT. JAYA OBAYASHI	PELAYANAN KESEHATAN	1 Juli 2020	1 Juli 2025	360/DPM/I-PKS/VIII/2020	
72	PT. MALANG INTERMEDIA PERS	Pelayanan Kesehatan	1 Juli 2020	1 Juli 2025	025/DPM/E-PKS/DIR/VII/2020	103.1/PKS/DIR/JPRM/VIII/2020
73	PT. PANCAMAS ELITE	PELAYANAN KESEHATAN	1 Juli 2020	1 Juli 2025	032/DPM/E-PKS/DIR/VII/2020	
74	PT. YAMAHA MUSICAL PRODUCTS INDONESIA	PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP BAGI KARYAWAN DAN KELUARGA	1 Juni 2022	1 Juni 2025	004/DPM/E-PKS/III/2020	452/YMPI/HI/PKS/III/2020
75	PT. TIRTA INVESTAMA	PELAYANAN KESEHATAN KARYAWAN & KELUARGA	31 Agustus 2020	31 Agustus 2025		
76	PT. TASPEN	Perawatan Peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja	1 Januari 2023	31 Desember 2025	008/E-PKS/DIR/2023	JAN-01/DIR/2023
77	PT. KSI	Pelayanan Kesehatan				
78	PT. Sumber Alfaria	Pelayanan Kesehatan	22 Juni 2023	22 Juni 2026	142.1/DPM/E-PKS/DIR/VI/2023	0002/SDM-MLG/VI/2023
79	PT. Samator	Operasional Pasokan Produk	1 September 2022	1 September 2027		DISTRIBUTIONAGREEMENT_LGL_1850
80	PT HM Sampoerna Tbk	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan	1 Juni 2014-perpanjang otomatis	perpanjang otomatis	-	55/Perj/HMS/IX/2014
81	PT Adonai Manajemen Kesehatan	Perjanjian Kerja Sama	26 Agustus 2019	perpanjang otomatis		055/PKS-PF/AMK/VIII/2019

		Pemeriksaan Medicak Chek Up				
82	PT. Nestle Indonesia Kejayan Factory	Pelayanan Kesehatan	01/04/ 2013 - Perpanjang Otomatis	perpanjang otomatis		
83	PT. Ajinomoto Sales Indonesia	Pelayanan Pengobatan dan Perawatan Kesehatan	05/01/2012	perpanjang otomatis	008/PERS/RSPH-I/2012	LEG/ASI/120510-85
84	PT. COCA COLA DISTRIBUTION INDONESIA	PELAYANAN KESEHATAN	09/01/2019	perpanjang otomatis	573/I-PKS/PMS/IV/2019	004/Perjanjian/HRSEJ/IX/2019
85	PT. Indolakto Pandaan	Jasa Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja (PPK)	01/10/2014	perpanjang otomatis		
86	PT. Nestle Indonesia Kejayan Factory	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	30/03/2015	perpanjang otomatis		
87	Harris Hotel & Convations Malang	Rujuka Pelayanan Kesehatan	14/10/2019	Perpanjang Otomatis	308/E-PKS/PMS/V/2018	001/IKS/HR/V/2018
88	PT. DUHA MULYA ABADI	Penyediaan paket BHP Operasi Katarac	11/01/2019			
89	PT. RENTOKIL	Pengendalian Hama dengan Program General Pest (GP)- Non Station	11 September 2023	11 September 2024	173.1/DPM/E- PKS/DIR/IX/2023	003/PT.RI/MLG-37/52400326/IX/2023
90	PT. DELAPAN BERUANG MADU (BEETU)	Layanan Antar Obat Pasien	15 Juni 2023	15 Juni 2024	138.2/DPM/E- PKS/DIR/VI/2023	003/PKS/V/PT.DISAPRIMAMEDIKA/MLG/23 -24
91	PT. TSSA (Teman Sejati Sejahtera Abadi)	Pengelolaan Limbah B3	6 Februari 2023	2 Juni 2024	0175/LGL-PK/DPM-TSSA- AMP/II/2023	

92	PT. PILLAR UTAMA CORTINDO	Vendor Pelayanan Pemeliharaan Peralatan Elevator	1 Juni 2023	30 Juni 2024	-	KS/PUCCSBY-1216/VII/2023
93	PT. Global Trans Jaya Mulia	Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	1 April 2023	31 Maret 2024	060.2/DPM/E- PKS/DIR/II/2023	037/SPH-T/DPM-GTJM/BSJ/IV/2023
94	PT. UNIPLASTINDO INTERBUANA	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Penunjang	8 Juni 2023	8 Juni 2024	302/DPM/I-PKS/DIR/VI/2021	001/PKS-IU-HRD/VI/2021
95	PT. NAYAKA ERA HUSADA	Pelayanan Kesehatan	30 Mei 2023	30 Mei 2025	143.1/DPM/E- PKS/DIR/VII/2023	PKS/106/072023
96	Solaris Hotel	Rujukan Pelayanan Kesehatan	1 November 2023	1 November 2026	222/DPM/E-PKS/DIR/XI/2023	108/HRD/SHM/X/2023
97	PT. ARTHAWENA SAKTI GEMILANG	Pelayanan Rujukan kesehatan	15 Juni 2023	15 Juni 2026	138.3/DPM/E- PKS/DIR/VI/2023	-
98	Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)	Kerjasama dalam proses akreditasi rumah sakit	22 April 2022	24 April 2026		
99	CV. AUMIRETA ANGGUN	Rujukan Pelayanan Kesehatan	28 Agustus 2023	28 Agustus 2026	164.1/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2023	-
100	PMI Kabupaten Malang	Pelayanan Darah Transfusi Bagi Pasien Peserta BPJS & Asuransi lainnya	1 Juni 2023	1 Juni 2025	768/E-PKS/DIR/V/2023	#REF!
101	PMI Kota Malang	Pelayanan Darah Transfusi Bagi Pasien Peserta BPJS & Asuransi	20 November 2023	31 Desember 2025	1790/E-PKS/DIR/XI/2023	2214/02.06.27/UTD/XI/2023

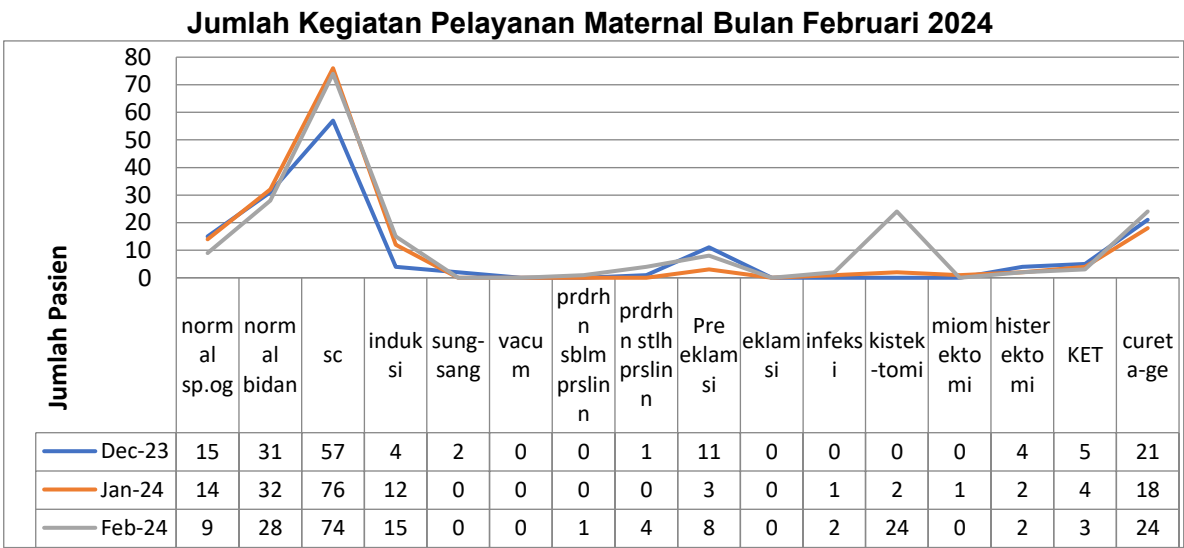
		lainnya				
102	RSUD Dr. Saiful Anwar Malang	Rujukan Asuhan Pasien	1 November 2022	1 November 2024	1562.1/e-pks/dir/xi/2022	116/302/2019
103	RS. TK.II dr. SOEPRAOEN (RST)	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Penunjang	16 September 2022	15 September 2024	152.40/DPM/E-PKS/DIR/X/2022	PKS/173/IX/2022
104	RS SITI MIRIAM LAWANG	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Pemulasaraan Jenazah	4 Oktober 2022	3 Oktober 2024	151.1/DPM/E-PKS/DIR/X/2022	810/HMS/RSSM/X/2022
105	RS LAVALETTE	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	10 Agustus 2023	10 Agustus 2025	155.2/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2023	RSL-KONTR-PKS/VII/23.124
106	RS Prima Husada Sukorejo	Rujukan Asuhan Pasien	21 Februari 2022	21 Februari 2025	213/E-PKS/DIR/III/2019	126/RSPHS/E-PKS/III 2019
107	RS PANTI NIRMALA	Kerjasama Pelayanan Rujukan	7 Oktober 2022	6 Oktober 2025	152.44/DPM/E-PKS/DIR/XI/2022	3740/069/RSPN/X/2022
108	RS SAHABAT	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	2 Desember 2016 - perpanjang otomatis	perpanjang otomatis	1097.1/E.PKS/DIR/VIII/2021	
109	RS Dr. SYAIFUL ANWAR (RSSA)	Rujukan Pekayanan Penunjang	1 November 2022	1 November 2024	1562.2/E-PKS/DIR/XI/2022	116//102.7/2022
110	RSU MUHAMMADIYAH (RSUMM)	Pelayanan Rujukan Kesehatan, Laboratorium dan Radiologi	21 Agustus 2023	21 Agustus 2024	159.1/DPM/E-PKS/DIR/VII/2023	100/SK_PKS/RSU-UMM/VII/2023
111	RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	30 Oktober 2023	30 Oktober 2026	220.1/DPM/E-PKS/DIR/X/2023	HK.03.01/D.XXXVII/12226A/2023

112	RS ISLAM UNISMA MALANG	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Pemulasaraan Jenazah	1 Januari 2024	31 Desember 2026	222.11/DPM/E-PKS/DIR/XI/2023	MENUNGGU SEKRETARIAT
113	RS Persada	Pelayanan Kesehatan, Rujukan, Laboratorium dan Radiolog	10 Oktober 2022	10 Oktober 2027	152.42/DPM/E-PKS/DIR/XI/2022	1083.b.Hs/MOU/X/PH.2022
114	PT. ASURANSI DAYIN MITRA TBK		01/05/2015	perpanjang otomatis	003/MKT/HLT/PKS/II/2015	PH/IKS/269/XII/2014
115	PT Pesta Pora Abadi	Pelayanan Kesehatan				
116	Batas Media 99	Pelayanan Kesehatan				
117	RS Puri Bunda	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Penunjang	6 Februari 2024	6 Februari 2026	020/DPM/E-PKS/DIR/II/2024	001/PKS/PB/II/2024
118	RSUD Lawang	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Penunjang			245.1/E-PKS/DIR/II/2024	074.3/35.07.302.102/2024
119	PT Kimberly Clark	Pasokan produk	1 Januari 2024	1 Januari 2025		106/KCS-PNS/MOU/II/2023

H. Program Nasional

- a. Ponek
- Kinerja Dan Produktivitas
1. Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		DESEMBER 2023	JANUARI 2024	FEBRUARI 2024
1				
	a. Persalinan Normal Sp. OG	15	14	9
	b. Persalinan Normal Bidan	31	32	28
	c. <i>SectioCaesaria</i>	57	76	74
2				
	a. Induksi / Drip	4	12	15
	b. Sungsang	2	0	0
	c. Vacum	0	0	0
3				
	a. Perdarahan sebelum Persalinan	0	0	1
	b. Perdarahan setelah Persalinan	1	0	4
	c. Pre Eklamsi	11	3	8
	d. Eklamsi	0	0	0
	e. Infeksi	0	1	2
4				
	a. Curretage	21	18	24
	b. Kistektomi	0	2	2
	c. Miomektomi	0	1	0
	d. Histerectomy	4	2	2
	e. KET	5	4	3



Evaluasi :

1. Pada jenis pelayanan Persalinan secara Sectio Caesaria pada Februari 2024 mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 74 pasien. Dan untuk persalinan normal ditolong dokter pada bulan pada bulan Februari 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu 9 pasien. Begitu juga dengan persalinan yang ditolong oleh bidan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu 28 pasien. Untuk persalinan normal, jika memang tidak ada penyulit maka persalinan bisa ditolong bidan terlebih dahulu.
2. Kebanyakan pasien yg dilakukan tindakan SC adalah pasien dari poli kandungan yang memang telah dijadwalkan untuk operasi dikarenakan ada diagnosa khusus sehingga harus dilakukan operasi SC, misalnya bekas sc, floating head, placenta previa, letak sungsang, dan lainnya, atau pasien yang ada di ruang bersalin yang gagal untuk persalinan normal dikarenakan ada penyulit seperti prolong kala 1, kala 2 lama, fetal distress. Dan juga pasien dilakukan operasi sc adalah pasien rujukan dari bidan ataupun puskesmas yang harus dilakukan operasi dikarenakan adanya kegawatan pada ibu atau bayi dan akhirnya harus dilakukan operasi sc cito.
3. Tidak ada persalinan sungsang maupun persalinan dengan vacum pada bulan Februari 2024
4. Induksi Persalinan pada bulan Februari mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu sebanyak 15 pasien.
5. Jenis pelayanan persalinan dengan komplikasi ialah pre eklamsi. Pada bulan Februari 2024 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 8 pasien. Dan tidak ada kejadian eklamsi pada bulan Desember, Januari maupun Februari 2024.
6. Jenis pelayanan curretage di bulan Februari 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada 2 bulan sebelumnya, yaitu 24 pasien. *Curretage* dilakukan untuk indikasi abortus, mola, blighted ovum, sisa plasenta dan pada kasus-kasus gynekology biasanya dengan indikasi menometoragi, hiperplasia endometrium, dan lainnya.

Rencana dan Tindak Lanjut :

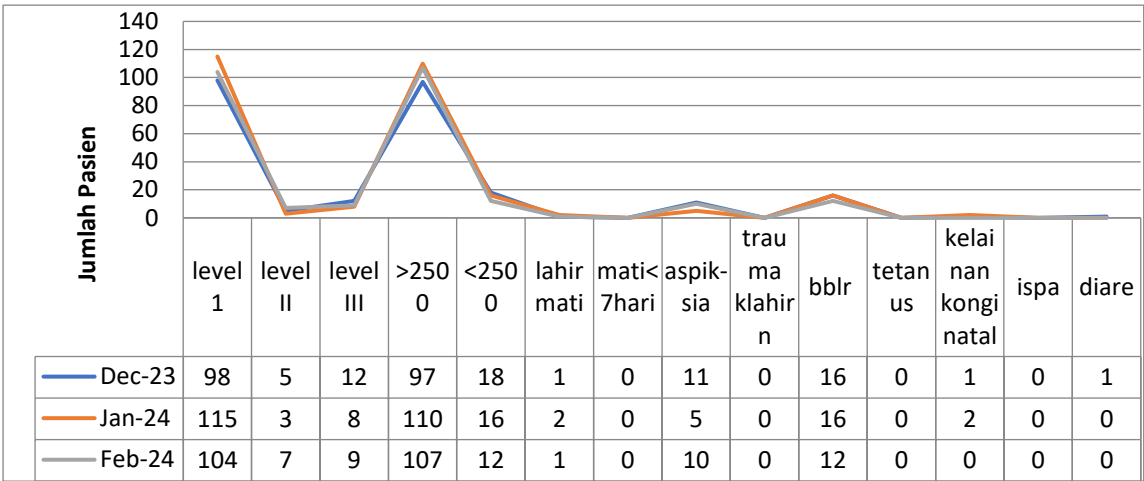
1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien obgyn salah satunya dengan mengadakan pelatihan bidan-bidan perujuk.
2. Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang konsumsi makan makan yang mengandung garam terlalu tinggi, terutama pasien dengan riwayat darah tinggi.
3. Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang tanda dan bahaya pada kehamilan.
4. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 tentang tanda-tanda persalinan.

2. Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		DESEMBER 2023	JANUARI 2024	FEBRUARI 2024
1				
	a. Level 1	98	115	104
	b. Level II	5	3	7
	c. Level III	12	8	9
2				
	a. ≥ 2500 gram	97	110	107
	b. ≤ 2500 gram	18	16	12

3				
	a. Kelahiran Mati	1	2	1
	b. Mati Neonatal < 7 Hari	0	0	0
4				
	a. Asphyxia	11	5	10
	b. Trauma Kelahiran	0	0	0
	c. BBLR	18	16	12
	d. Tetanus Neonatorum	0	0	0
	e. Kelainan Congenital	1	2	0
	f. ISPA	0	0	0
	g. DIARE	1	0	0
5	Lain-lain	0	0	0

Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Bulan Februari 2024



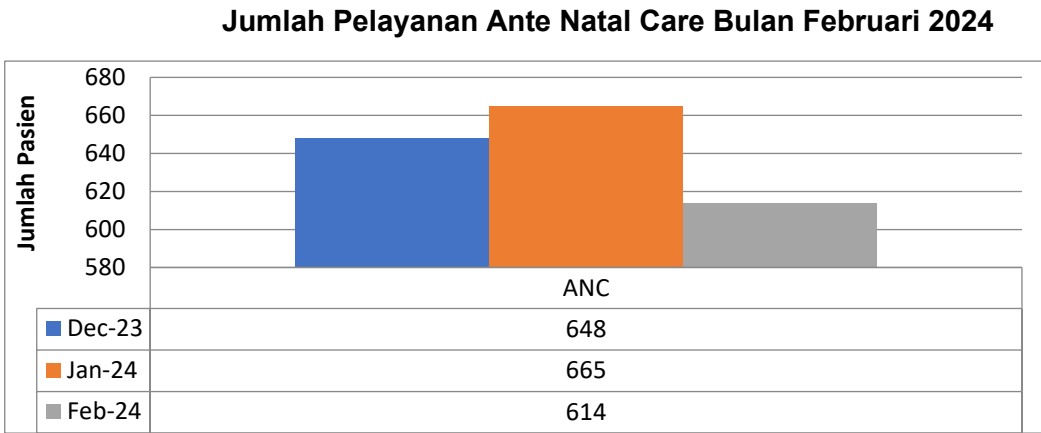
Evaluasi :

1. Pada jenis pelayanan pasien neonatal level 1 di bulan Februari 2024 sedikit menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 104 bayi. Sedangkan level 2 pada sedikit meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya. Sedangkan pada level 3 juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 9 bayi.
2. Pada jenis pelayanan bayi lahir hidup ialah >2500 gram di bulan Februari 2024 mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu sebanyak 107 bayi.
3. Dan masih terdapat jumlah bayi lahir hidup <2500 gram (BBLR) di bulan Februari 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 12 bayi. Masih adanya kelahiran < 2500 gram dikarenakan kelahiran belum cukup bulan atau IUGR.
4. Kasus BBLR pada bulan Februari 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu 12 bayi.
5. Terdapat kasus kelahiran mati pada bulan Desember 2023 dan Februari 2024 sebanyak 1 kasus, sedangkan pada bulan Januari 2024 sebanyak 2 kasus.
6. Tidak Ada kasus kematian neonatus <7 hari pada 3 bulan terakhir

Rencana dan Tindak Lanjut :

1. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC untuk mengurangi kegiatan berat dan istirahat cukup agar tidak terjadi partus prematurus imminens (PPI) yang mengakibatkan kelahiran prematur.
2. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC terkait asupan gizi saat ibu hamil, guna mencegah bayi lahir dengan IUGR.

3. Pelayanan Ante Natal Care (ANC)				
NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		DESEMBER 2023	JANUARI 2024	FEBRUARI 2024
1	ANC	648	665	614



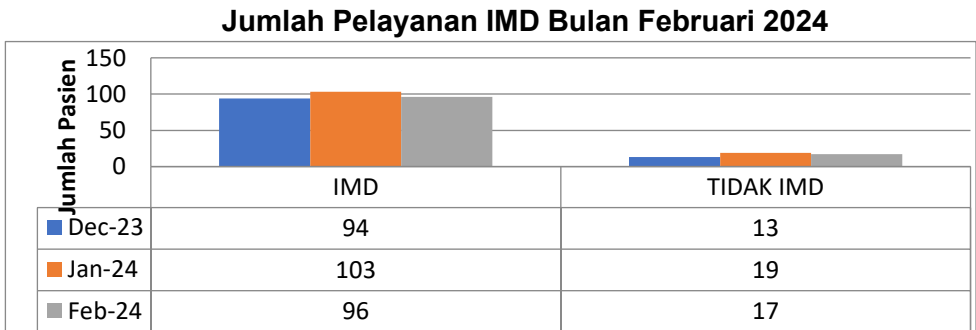
Evaluasi :

Pelayanan ANC pada bulan Februari 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 614 kunjungan.

Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan promosi terkait pemeriksaan ANC seperti USG 4 dimensi serta kegiatan senam hamil yang diharapkan menarik minat para ibu hamil untuk memeriksakan kehamilanya di RS.

4. Inisiasi Menyusu Dini (IMD)				
NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		DESEMBER 2023	JANUARI 2024	FEBRUARI 2024
1	IMD	94	103	96
2	Tidak IMD	13	19	17



Evaluasi :

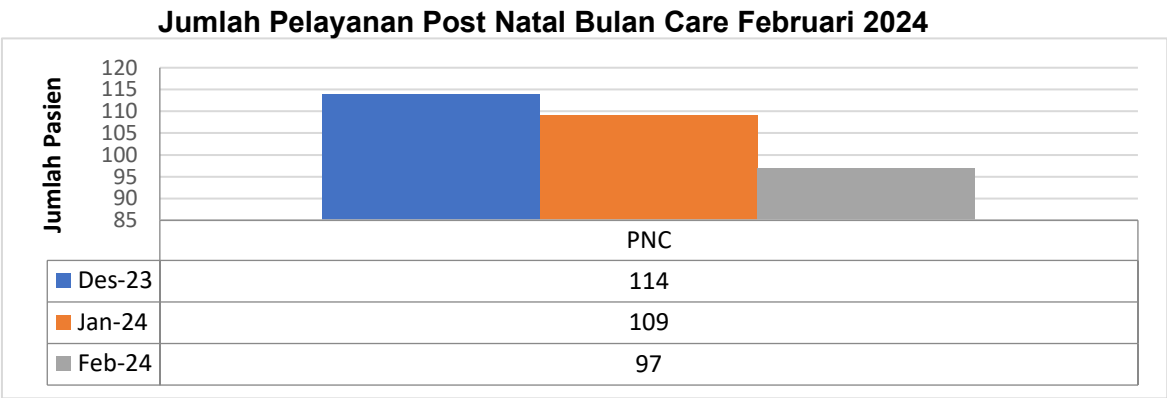
- 1. Bayi yang dilakukan IMD pada bulan Februari 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 96 bayi. Dan tidak semua bayi baru lahir dilakukan IMD, dikarenakan tidak memenuhi kriteria untuk dilakukannya IMD.
- 2. Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan Februari 2024 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 17 bayi. Hal ini terjadi diiringi dengan masih adanya bayi lahir dengan berat <2500 gr sehingga tidak dilakukan IMD.
- 3. Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan skrining sebelum dilakukan tindakan inisiasi menyusui dini (IMD) pada bayi baru lahir, apakah sesuai dengan syarat ataukah tidak.

5. Pelayanan Post Natal Care (PNC)

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		DESEMBER 2023	JANUARI 2024	FEBRUARI 2024
1	PNC	114	109	97



Evaluasi :

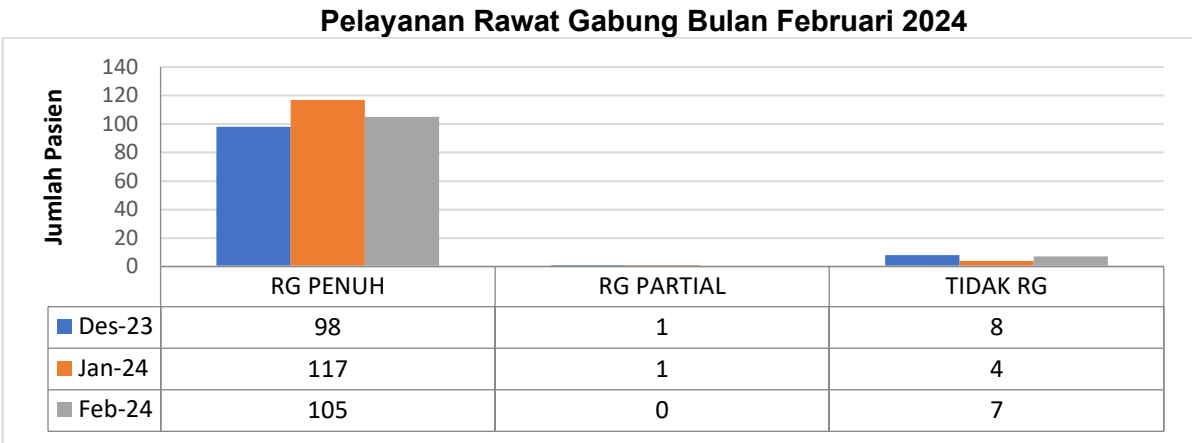
Pelayanan PNC pada bulan Februari 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 97 kunjungan.

Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan Edukasi ke pasien pasca bersalin untuk melakukan pemeriksaan PNC di RS Prima Husada

6. Pelayanan Rawat Gabung

No	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		DESEMBER 2023	JANUARI 2024	FEBRUARI 2024
1	Rawat gabung penuh	98	117	105
2	Rawat gabung partial	1	1	0
3	Tidak Rawat gabung	8	4	7

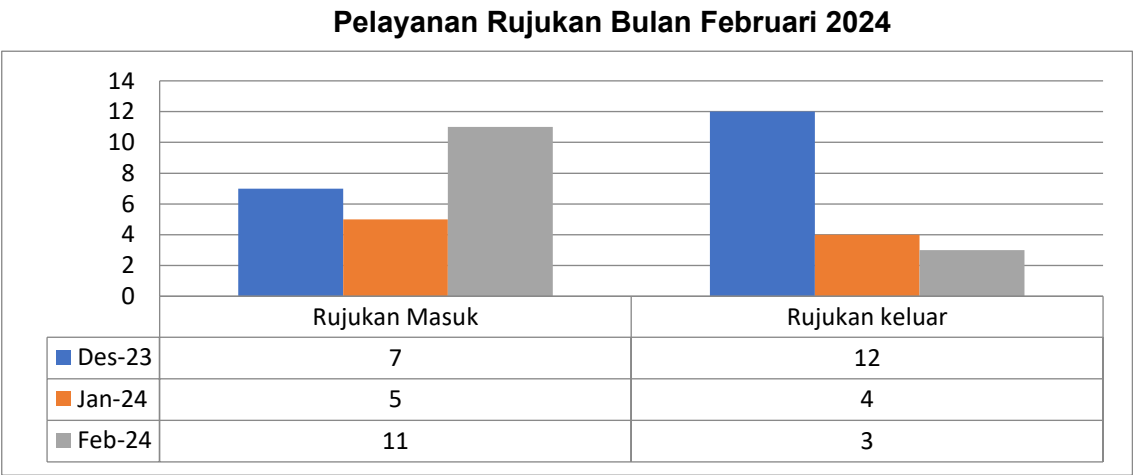


- Evaluasi :**
1. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung pada bulan Februari 2024 menurun jika dibandingkan dengan 1 bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 105 bayi. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung dengan syarat bayi dan ibu dalam kondisi sehat
 2. Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung pada bulan Februari 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 7 bayi.
 3. Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung adalah bayi yang membutuhkan perawatan khusus yaitu diletakkan di cuvis atau incubator karena berat bayi < 2500 gram dan masih belum memungkinkan dilakukan rawat gabung karena masih menggunakan alat bantu pernafasan.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan skrening awal untuk pasien yang layak dilakukan rawat gabung ibu dan bayi.

7. Pelayanan Jejaring Rujukan

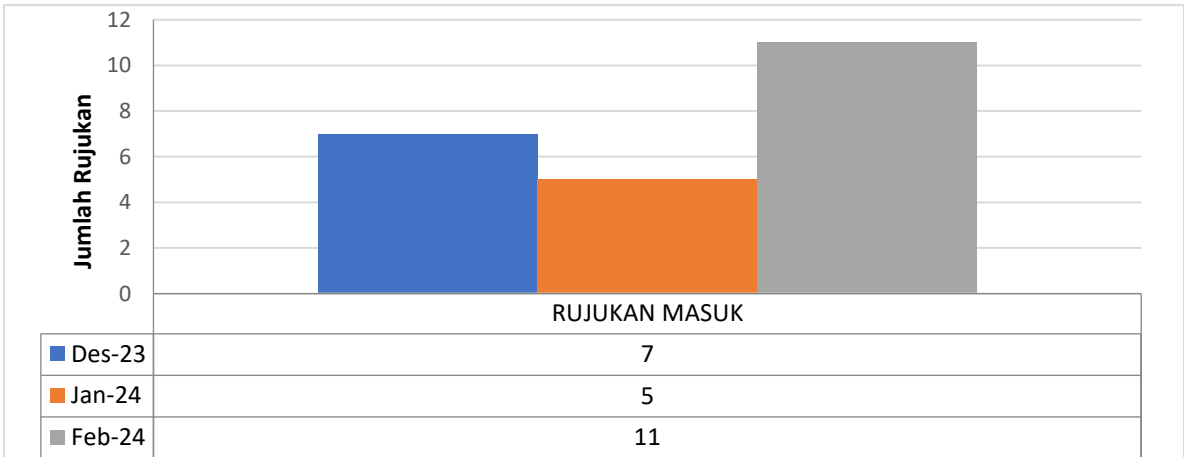
NO	RUJUKAN	DESEMBER 2023	JANUARI 2024	FEBRUARI 2024
1	Rujukan Masuk	7	5	11
2	Rujukan keluar	12	4	3



7.1 Rujukan Masuk

Bulan Desember 2023		
1	G1 P0000 Ab000 uk 40-41 mgg dg fetal distres	PMB Titik
2	G1 P0000 Ab000 Uk 30-32 mgg dg PPI + HT Gestasional	PMB Yena
3	G2 P1001 Ab000 uk 28-30 mgg dg PPI	Pustu Bida Yeni
4	Asfiksia, TTN	RS Siti Miriam
5	Asfiksia	RS UMM
6	Asfiksia, BBLR	RS UMM
7	Asfiksia, Hepatomegali	RS UMM
Bulan Januari 2024		
1	Bronchopneumonia	RS Siti Miriam
2	Bronchopneumonia	RS Siti Miriam
3	G1 P0000 Ab000 UK : 40 mgg dengan DJJ Irreguler	BPM Titik
4	G1 P0000 Ab000 UK : 32 mgg dg Susp. Inpending Eklamsia	BPM Yena
5	G2 P1001 Ab000 UK 28-30 mgg dg Susp Plasenta Letak Rendah	PKM Pembantu desa Dengkol
Bulan Februari 2024		
1	G3 P2002 Ab000 UK 40 mgg dg PEB	BPM Nurul ismawati
2	G3 P2002 Ab000 UK 10 – 12 mgg dg DHF	Klinik Putra Husada
3	G4 P3003 Ab000 11-12 mgg dg Abortus Inkomplit	BPM Suma'iyah
4	G2 P1001 ab000 Uk 39 – 40 mgg dg gemelli + KIFA + PE	BPM Rini Idawati
5	G2 P0000 ab100 uk 39 – 40 mgg dg KIFL	BPM Indi
6	G1 P0000 ab000 uk 40-41 mgg dg kala 2 lama	BPM Tri Widiyawati
7	G1 P0000 Ab000 Uk 39-40 mgg dg susp CPD	BPM Titik
8	G2 P1001 ab000 uk 39-40 mgg dg BSC	BPM Titik
9	G3 P2002 ab000 Uk 39 – 40 mgg dg KIFA	BPM Indi
10	G1 P0000 Ab000 uk 6-8 mgg dg HEG	Klinik Mutiara Sehat
11	NKB + BBLSR + ASFIKSIA	BPM

Pelayanan Rujukan Masuk Bulan Februari 2024



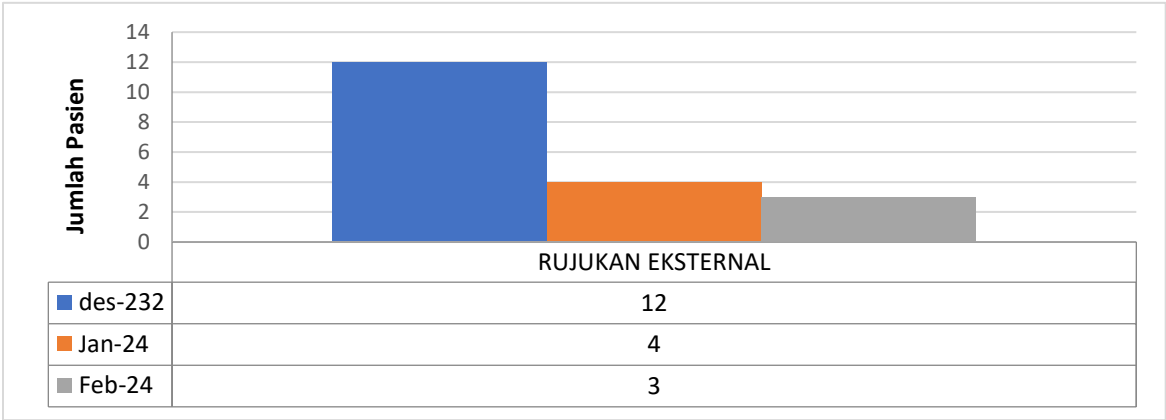
Evaluasi :
Jumlah rujukan masuk pada bulan Februari mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 11 rujukan masuk.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Bekerja sama dengan tim PKRS untuk melakukan promosi kesehatan dan mengajak BPM atau RS setempat untuk bekerja sama.

7.2 Rujukan Keluar

Bulan Desember 2023		
1	G1 P0000 Ab000 uk 30-32 mgg dg PE + ASD + PH	RSSA
2	G1 P0000 Ab000 Uk 30-32 mgg dg PEB + Kelainan Kongenital	RSSA
3	P0202 Ab000 dg Retensio Plasenta	RSSA
4	Mola Hidatidosa dd PTG + HT + PVC	RSSA
5	G5 P1001 Ab300 Uk 10-12 mgg dg HEG + DM + HT + KAD	RSSA
6	Neonatus Hipoglikemi	RSSA
7	BBLR + Asfiksia	RST Soepraoen
8	Asfiksia	RS LAvalette
9	NKB + BBLSR + Asfiksia + Atelektasis lobus superior paru kanan	RSSA
10	NKB + Asfiksia	RS Lavalette
11	NKB + BBLSR	RS LAvalette
12	NKB + BBLSR + Atresia Ani	RSSA
Bulan Januari 2024		
1	NKB + Atresia Ani + susp PJB	RSSA
2	G3 P1001 Ab100 Uk : 24-26 mgg dg PPROM + Plasenta Previa+ BSC + Letak lintang + Fetal Distres	RSSA
3	G5 P1001 Ab300 Uk : 10 – 12 mgg dg HEG + DM + HT + KAD	RSSA
4	APB + PEB curiga Inpending Eklamsi	RSSA
Bulan Februari 2024		
1	NKB+BBLR+ASFIKSIA	RS Soepraoen
2	NKB+BBLSR+ASFIKSIA	RS Soepraoen
3	Pneumonia, Asfiksia. BBLR	RS Lavalette

Pelayanan Rujukan Eksternal Bulan Februari 2024



Evaluasi :

Pada bulan Februari 2024 pasien yang dirujuk keluar menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan Sebelumnya, yaitu 3 pasien.

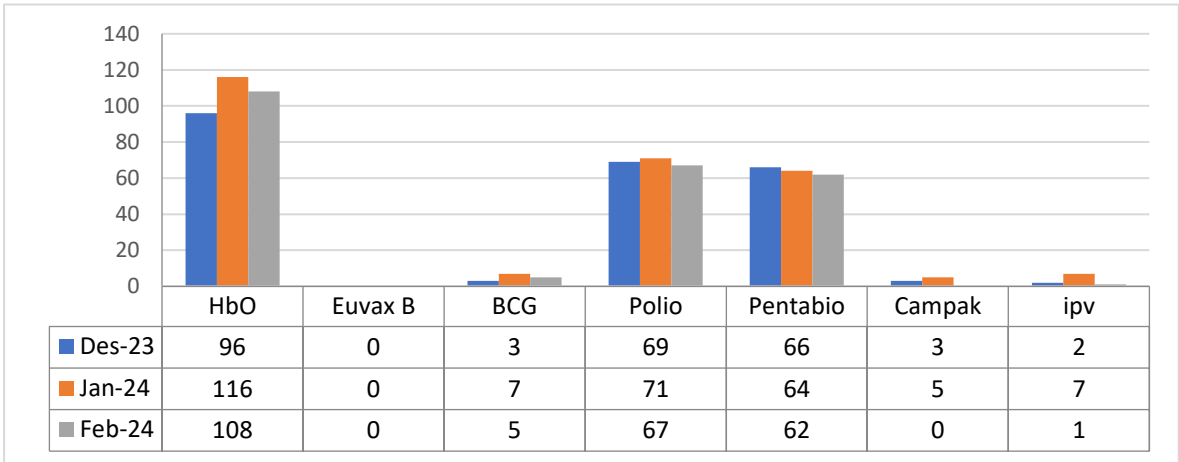
Rencana dan Tindak Lanjut :

Menambah jumlah pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, sehingga meminimalisasikan untuk dilakukan rujukan keluar.

8. Pelayanan Imunisasi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		DESEMBER 2023	JANUARI 2024	FEBRUARI 2024
1	HbO	96	116	108
2	Euvax B	0	0	0
3	BCG	3	7	5
3	Polio	69	71	67
4	Pentabio	66	64	62
5	Campak	3	5	0
6	IPV	2	7	1

Pelayanan Imunisasi Bulan Februari 2024



Evaluasi :

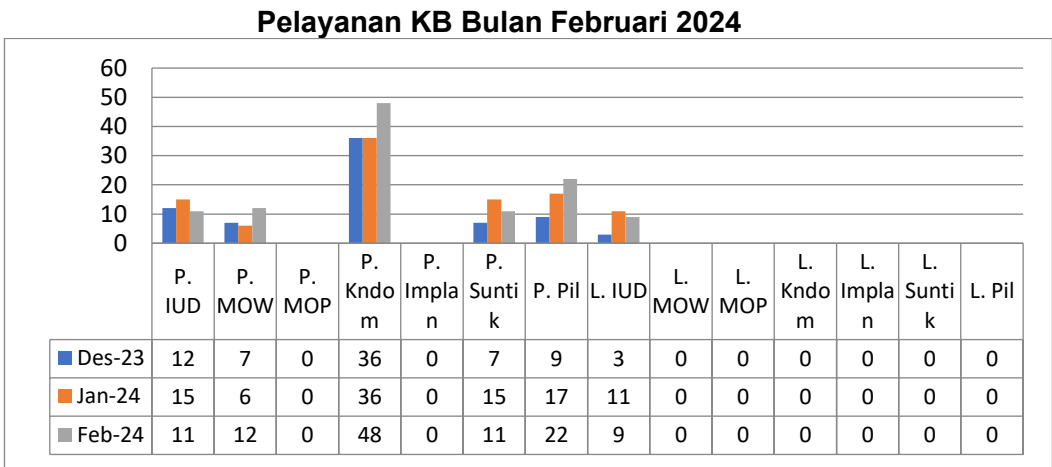
1. Tidak ada penggunaan vaksin euvax B pada periode Februari 2024 maupun 2 bulan sebelumnya, hal ini dikarenakan banyak nya pasien bayi baru lahir dengan status BPJS, sehingga memakai imunisasi HB.O unijek.
2. Imunisasi Hbo pada bulan Februari mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 108 bayi. Dan ini seiring dengan jumlah bayi baru lahir yang ada di RS
3. Bayi yang melakukan Imunisasi IPV Pada bulan Februari menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 1 bayi
4. Bayi yang melakukan Imunisasi BCG Pada bulan Februari 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 1 bulan sebelumnya, yaitu 5 pasien.
5. Pada periode Februari 2024 tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi Campak
6. Bayi yang melakukan Imunisasi Polio Pada bulan Februari 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 67 bayi
7. Jumlah pasien yg imunisasi Pentabio pada bulan Februari 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 62 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut :

1. Membuat surat permintaan berupa laporan bulanan kepada puskesmas untuk pemenuhan kebutuhan vaksin di rumah sakit.
2. Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit.

9. Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

NO	JENIS	JUMLAH PASANG			JUMLAH LEPAS		
		DESEMBER 2023	JANUARI 2024	FEBRUARI 2024	DESEMBER 2023	JANUARI 2024	FEBRUARI 2024
1	IUD	12	15	11	3	11	9
2	MOW	7	6	12	0	0	0
3	MOP	0	0	0	0	0	0
4	Kondom	36	36	48	0	0	0
5	Implant	0	0	0	0	0	0
6	Suntikan	7	15	11	0	0	0
7	Pil	9	17	22	0	0	0



Evaluasi :

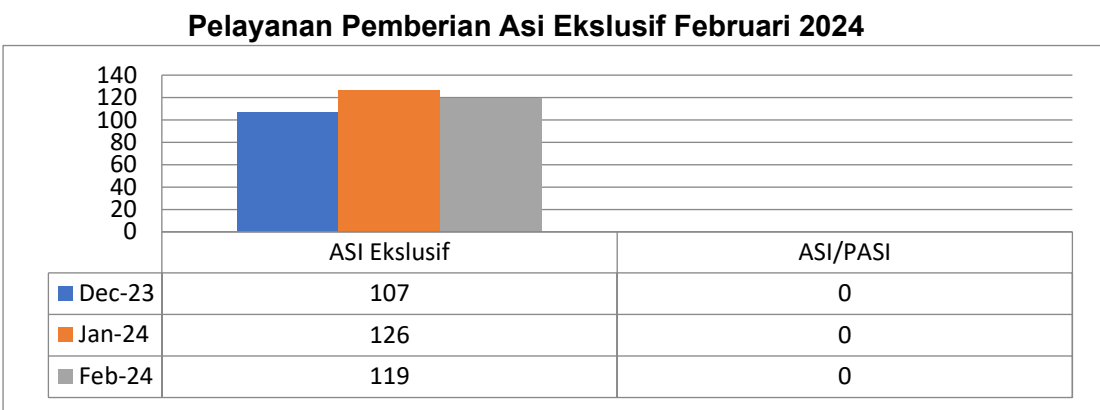
- 1. Pemasangan KB IUD pada bulan bulan Februari 2024 menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 11 akseptor, yang terdiri dari IUD Nova T sebanyak 6 akseptor dan IUD Copper T sebanyak 5 akseptor
- 2. Pasien yang menggunakan metode MOW pada bulan Februari sedikit meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 12 pasien. Untuk pemasangan KB MOW dilakukan sesuai dengan indikasi pasiennya, seperti pada pasien grande multipara dan primi tua sekunder.
- 3. Pasien yang menggunakan metode kondom pada bulan Februari 2024 meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya sebanyak 48 pasien.
- 4. Pasien yang menggunakan metode Pil pada bulan Februari 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 22 pengguna
- 5. Pasien yang menggunakan metode suntik pada bulan Februari 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 11 pengguna

Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

10. Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif

NO	PEMBERIAN ASI	JUMLAH PASIEN		
		DESEMBER 2023	JANUARI 2024	FEBRUARI 2024
1	Asi eksklusif	107	126	119
2	Asi /PASI	0	0	0

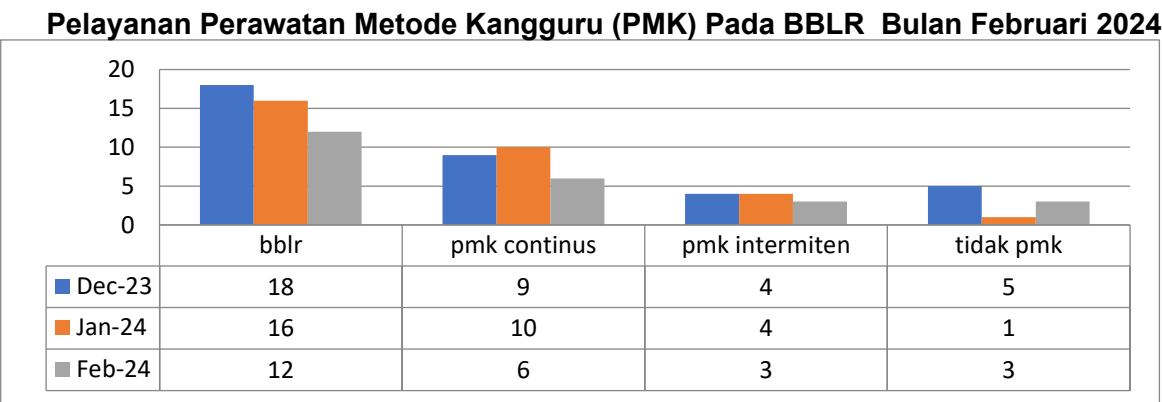


- Evaluasi :**
- 1. Pelayanan pemberian ASI eksklusif pada bulan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 119 bayi. Hal ini dikarenakan meskipun ada bayi dengan BBLR juga tetap diberikan ASI eksklusif
 - 2. Diperbolehkan menggunakan sufor pada bayi dengan kondisi tertentu, dan pastinya atas rekomendasi dari dokter spesialis anak.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Dilakukannya edukasi dengan adanya kelas ibu menyusui saat dilakukan perawatan di rumah sakit. Sehingga ada kegiatan tanya jawab, demonstrasi dan bertukar ilmu terkait pemberian ASI eksklusif

11. Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		DESEMBER 2023	JANUARI 2024	FEBRUARI 2024
1	Bayi BBLR	18	16	12
2	PMK continuos	9	10	6
3	PMK Intermiten	4	4	3
4	Tidak PMK	5	1	3



- Evaluasi :**
- 1. Bayi yang dilakukan PMK continus dan PMK intermiten adalah bayi dengan berat badan <2500gram.
 - 2. Pelayanan perawatan metode kangguru (PMK) dengan metode intermiten pada BBLR di bulan Februari 2023 menurun menjadi 3 bayi.
 - 3. Sedangkan metode PMK continus pada bulan Februari 2024 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 6 bayi. hal ini seiring dg jumlah BBLR yang ada

4. Dan terdapat 3 bayi yang masih tidak dilakukan PMK pada bulan Februari 2024, dan meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. hal ini dikarenakan kondisi bayi yg tidak mendukung untuk dilakukan PMK atau bayi di rujuk ke RS lain.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Perawatan Metode Kangguru sesuai dengan SPO yang berlaku

b. TB Dots
Kinerja Produktivitas

1. Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan Tentang Tuberculosis

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH KEGIATAN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1	Penyuluhan kesehatan tentang tuberculosis	1	1	

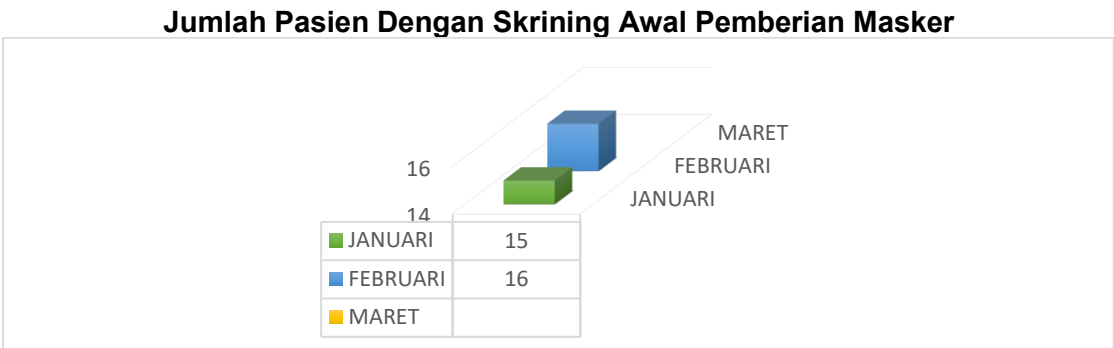


Evaluasi :
Peserta audiens ditujukan kepada pasien dan keluarga pasien, dengan harapan peserta memahami hasil penyuluhan.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Harus diadakan promosi kesehatan secara berkala terkait TBC seperti; pentingnya patuh dalam pengobatan TBC, kapan waktu yang tepat minum obat TBC, apa tanda gejala TBC, dll.

2. Skrining Pasien

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Pemberian Masker	15	16	



Evaluasi :
1. Pada bulan Januari 2024 terdapat 15 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart

2. Pada bulan Februari 2024 terdapat 16 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart

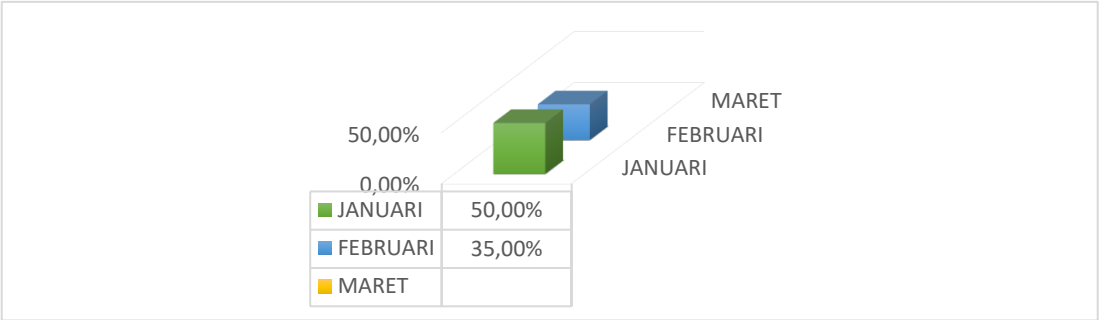
Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1. Memfasilitasi ketersediaan masker
- 2. Edukasi pemakaian masker (meliputi fungsi, waktu penggunaan, dan siapa saja yang perlu menggunakan)

3. Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Proporsi pasien (terduga dan baru) tekonfirmasi bakteriologis	50	35	

Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis



Evaluasi :

- 1. Pada bulan januari 2024 jumlah proporsi Pasien terduga TB 50
- 2. Pada bulan februari 2024 jumlah proporsi Pasien terduga TB 35

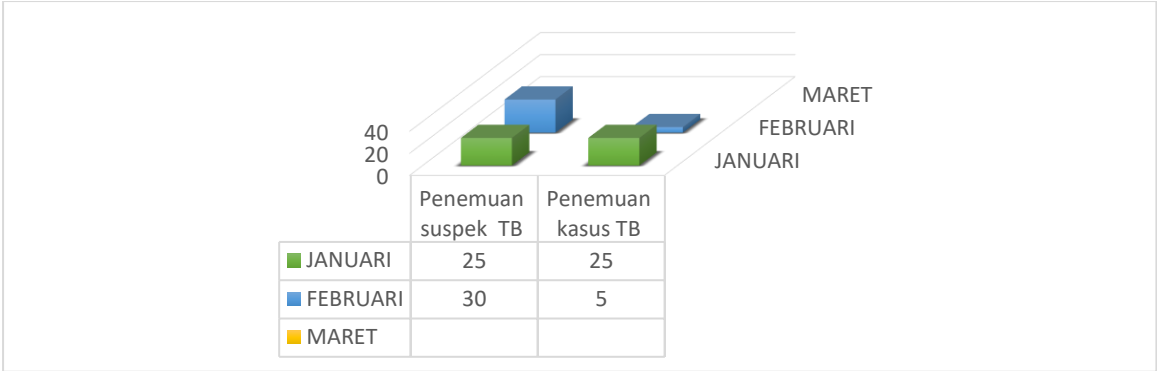
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan edukasi terhadap keluarga pasien dengan kontak TB untuk melakukan skrining TB

4. Penemuan Kasus TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Penemuan suspek TB	25	30	
2	Penemuan kasus TB	25	5	

Penemuan Kasus TB Baru



Evaluasi :

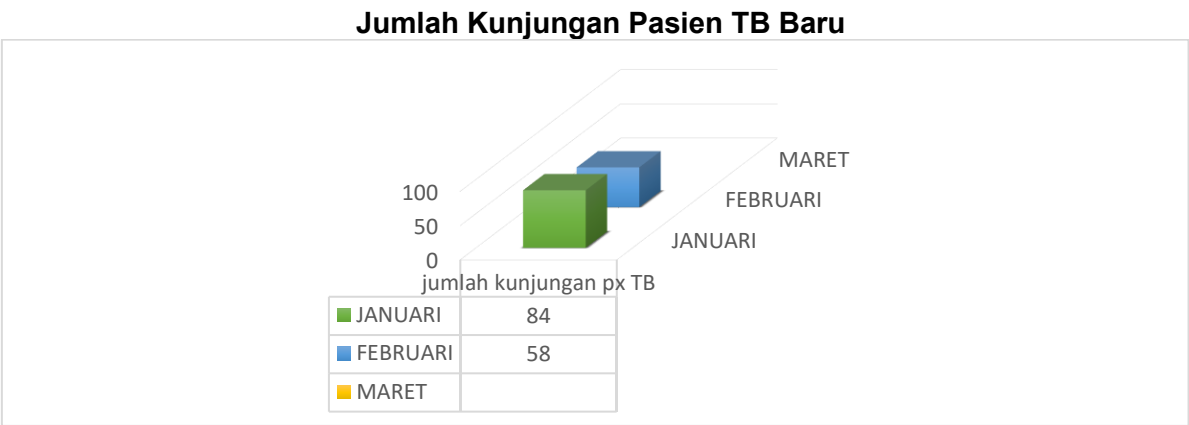
- 1. Pada bulan januari 2024 terdapat 25 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 25 pasien
- 2. Pada bulan februari 2024 terdapat 30 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 5 pasien

Rencana Dan Tindak Lanjut :

Menginformasikan kepada pasein dan keluarga pasien untuk melakukan pengobatan dengan teratur dan sesuai jadwal, serta mengedukasi kepada keluarga pasie untuk melakukan skrinning TB

5. Jumlah Kunjungan pasien TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Pasien TB kunjungan keseluruhan	84	58	



Evaluasi :

- 1. Jumlah keseluruhan kunjungan bulan Januari 2024 di poli pasien TBC mencapai 84 pasien.
- 2. Jumlah keseluruhan kunjungan bulan Februari 2024 di poli pasien TBC mencapai 58 pasien.

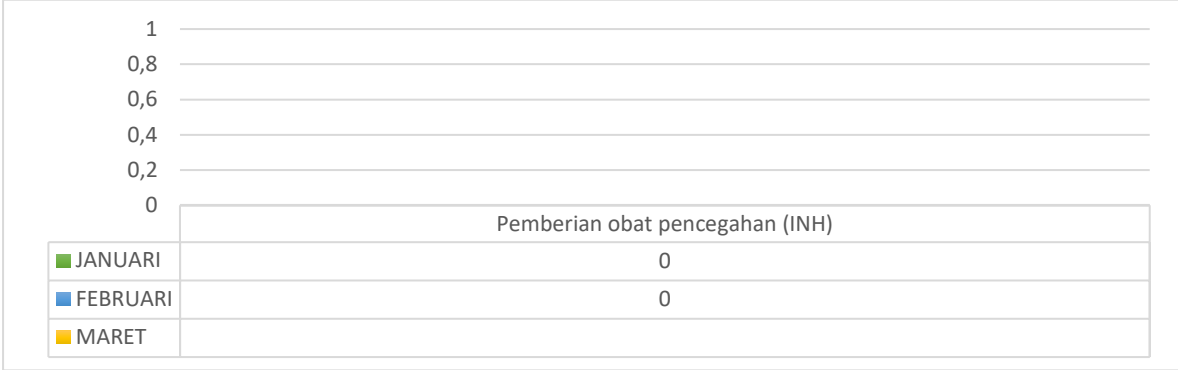
Rencana dan Tindak Lanjut :

Meningtkan kunjungan pasien

6. Pemberian Obat Pencegahan

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Pemberian obat pencegahan (INH)	0	0	

Pemberian Obat Pencegahan



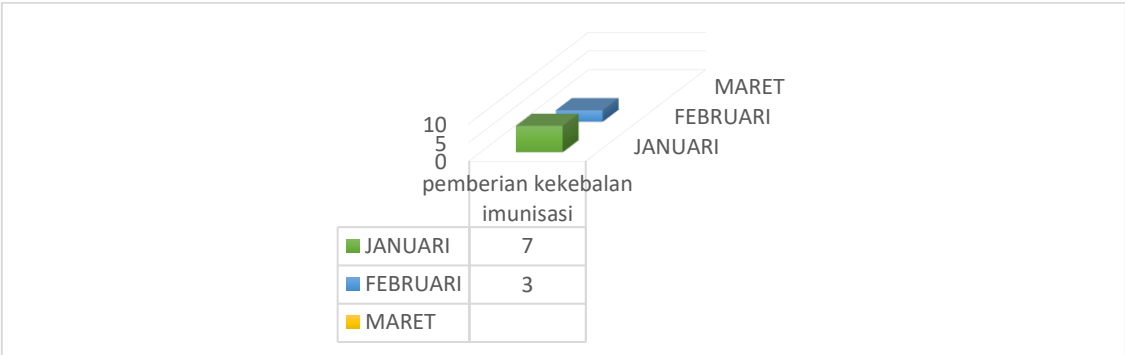
Evaluasi :
Tidak ada yang mendapat obat pencegahan (INH), hal ini dikarenakan kurang pengetahuannya pasien dan keluarga pasien mengenai pengobatan pencegahan (INH)

- Rencana dan Tindak Lanjut :**
1. Memberikan edukasi kepada keluarga pasien bahwa jika ada salah satu keluarga yang terdiagnosa TB kemudian memiliki saudara dengan usia dibawah 17 tahun, agar segera memeriksakan dan bersedia di berikan obat pencegahan (INH)
 2. Pemberian obat INH ditujukan pada anak usia dibawah 5 tahun yang memiliki kontak erat dengan pasien TB aktif dan orang dengan HIV/AIDS yang tidak terdiagnosa TB

7. Pemberia Imunisasi BCG

N O	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Pemberian imunisasi BCG	7	3	

Pemberian Kekebalan Imunisasi



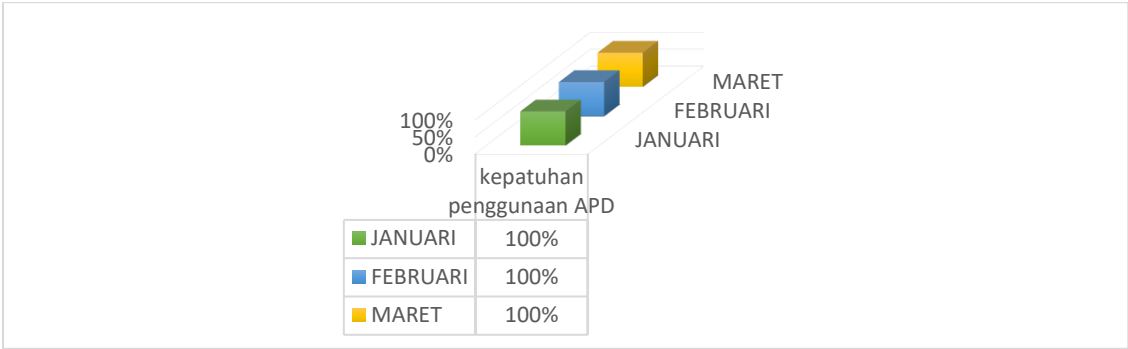
- Evaluasi :**
1. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 7 pasien yang diimunisasi pada bulan Januari
 2. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 3 pasien yang diimunisasi pada bulan Februari

- Rencana dan Tindak Lanjut :**
1. Dilakukan screening pasien dalam memberikan vaksin BCG
 2. Setelah dilakukan vaksin BCG dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemberian vaksin yang akan dilakukan pencatatan dan pelaporan tiap bulanya.

8. Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APD

NO	KEGIATAN	Jumlah Pasien		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Kepatuhan staf dan petugas terhadap APD	100%	100%	

Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APD



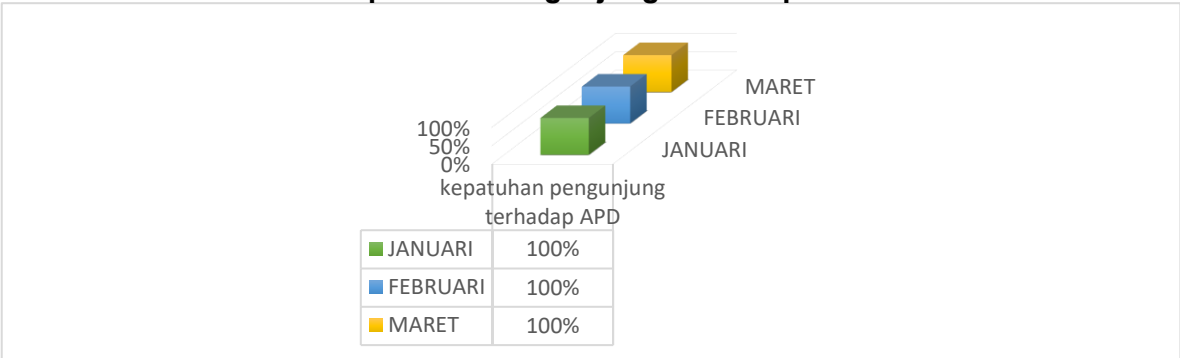
Evaluasi :
Semua staf sudah patuh dalam penggunaan APD, hal ini menunjukkan kesadaran bahwa sangat penting menjaga diri agar tidak tertular pasien.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan kepatuhan dalam penggunaan APD di tiap bulanya

9. Kepatuhan Pengunjung Pasien Terhadap APD

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Kepatuhan pengunjung pasien terhadap APD	100%	100 %	

Kepatuhan Pengunjung Terhadap APD

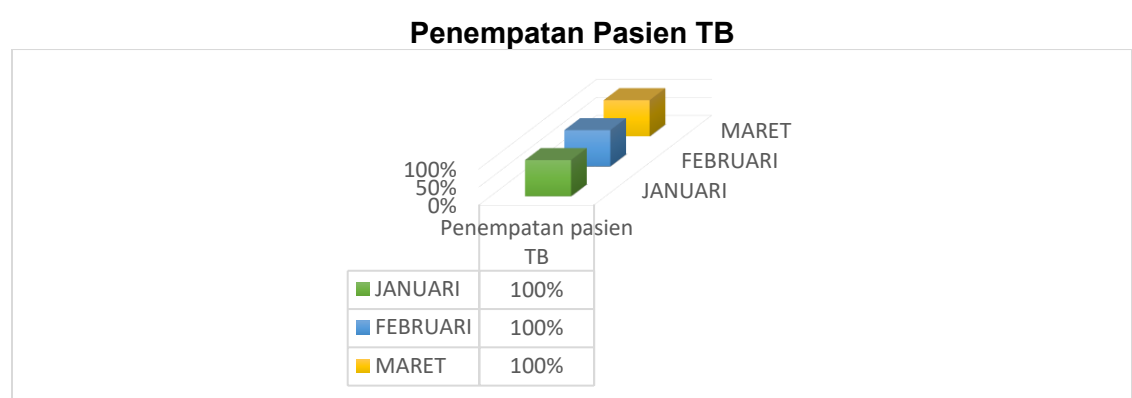


Evaluasi :
Hasil diatas menunjukan (100%) kepatuhan terhadap APD. Hal ini terjadi karna peningkatan kesadaran pengunjung akan cara penulara.n karena disebabkan covid yang terus menularkan virus

Rencana dan Tindak Lanjut :
Memperkuat kepatuhan pengunjung dengan cara wajib memberikan masker kepada pengunjung saat di nerstation dengan menanyakan keluarga dari pasien isolasi.

10. Penempatan Pasien TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Penempatan pasien TB	100%	100 %	

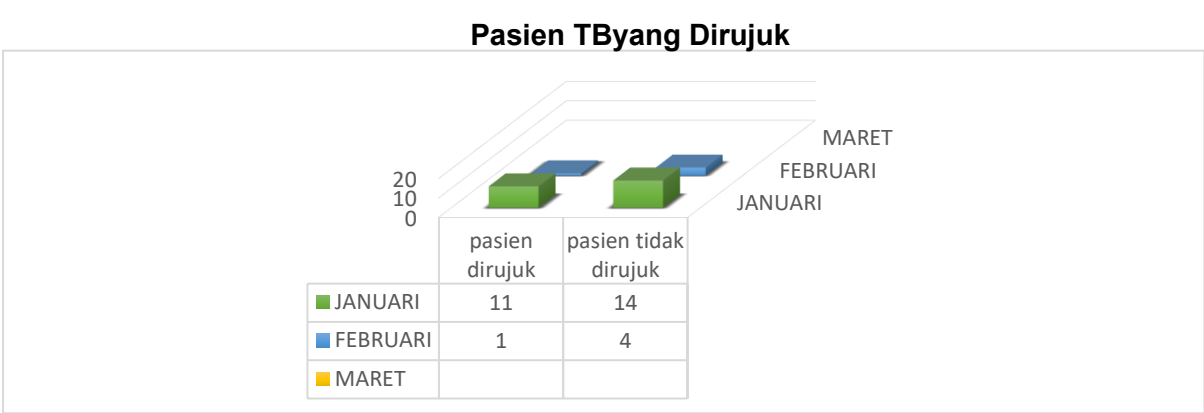


Evaluasi :
Semua pasien TB sudah ditempatkan di ruang isolasi, hal ini menunjukkan kesadaran staff medis agar antar pasien satu dengan lainnya tidak tertular.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan penempatan dengan benar

11. Pasien TB yang dirujuk

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Pasien TB yang dirujuk	11	1	
2.	Pasien TB yang tidak dirujuk	14	4	



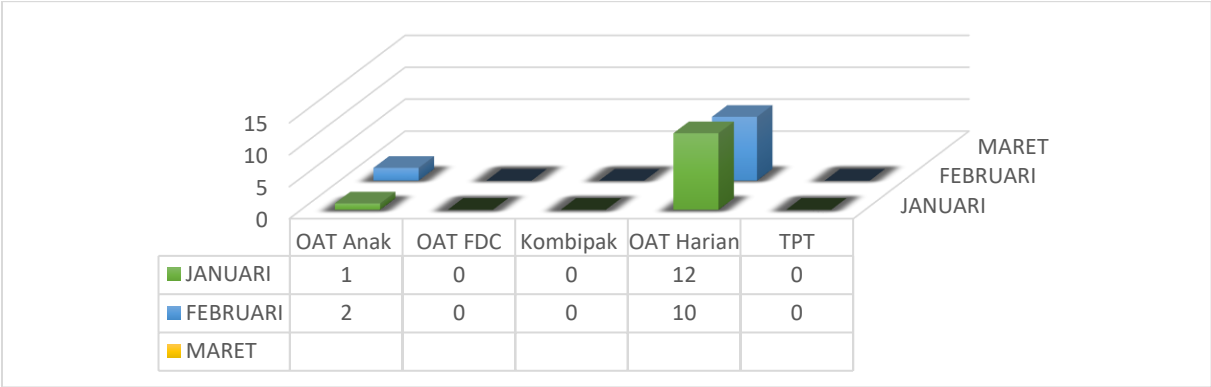
- Evaluasi :**
1. Pada bulan Januari 2024 terdapat 11 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.
 2. Pada bulan Februari 2024 terdapat 1 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan pelayanan yang terbaik untuk pasien sesuai pilihan pasien untuk berobat.

12. Stok OAT

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	OAT Anak	1	2	
2.	OAT Dewasa	0	0	
3.	Kombipak	0	0	
4.	OAT Harian	12	10	
5.	TPT	0	0	

Stok Obat TBC



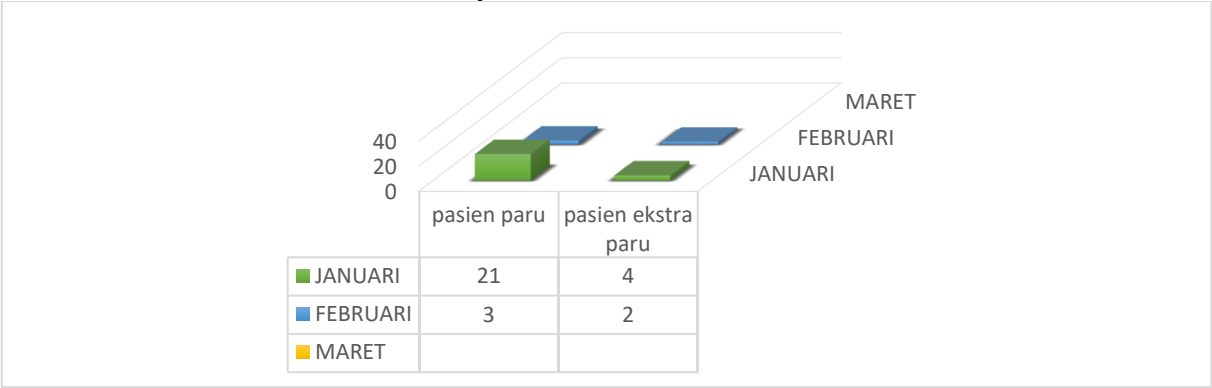
Evaluasi :
Setiap 1 bulan sekali farmasi akan melakukan pengadaan obat terkait permintaan ke Dinkes

Rencana dan Tindak Lanjut :
Menetapkan pengambilan obat dengan sesuai jadwal.

13. Pasien Paru dan Ekstra Paru

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Pasien paru	21	3	
2.	Pasien Ekstra paru	4	2	

Pasien paru dan Ekstra Paru



Evaluasi :

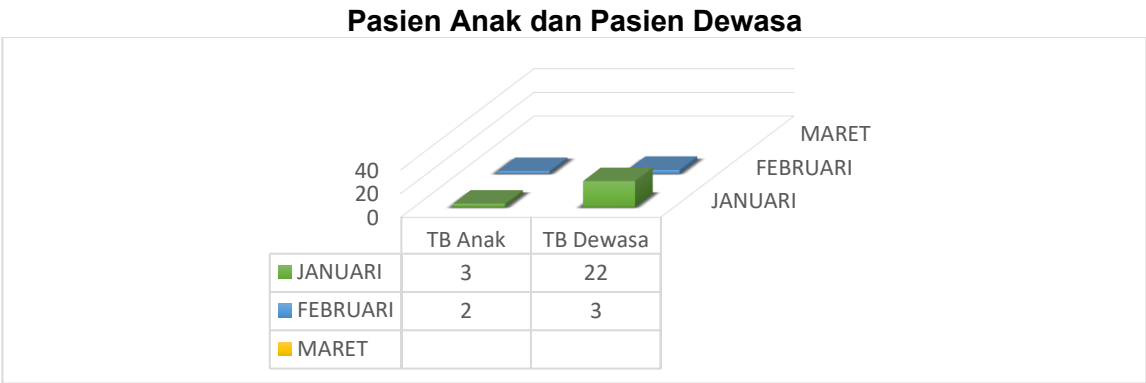
- 1. Pada bulan januari 2024 terdapat 4 pasien ekstra paru
- 2. Pada bulan januari 2024 terdapat 2 pasien ekstra paru

Rencana dan Tindak Lanjut :

Memberikan pengobatan yang sama pada ekstra paru meski pengobatannya akan lebih lama.

14. Pasien Anak Dan Pasien Dewasa TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Pasien Anak	3	2	
2.	Pasien Dewasa	22	3	



Evaluasi :

- 1. Pada bulan Januari terdapat 3 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 22 pasien
- 2. Pada bulan Februari terdapat 2 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 3 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut :

Mempertahankan pencatatan TB sesuai kategori pasien

15. Kepatuhan Dokter Terhadap PPK TB

NO	KEGIATAN	NAMA PASIEN	PATUH	TIDAK PATUH	ALASAN
1.	dr. Andy, Sp. P	Ny. S	V		
		Ny. I	V		
		Ny. S	V		
2.	dr. Catur Elvi p., Sp. P	Tn. P	V		

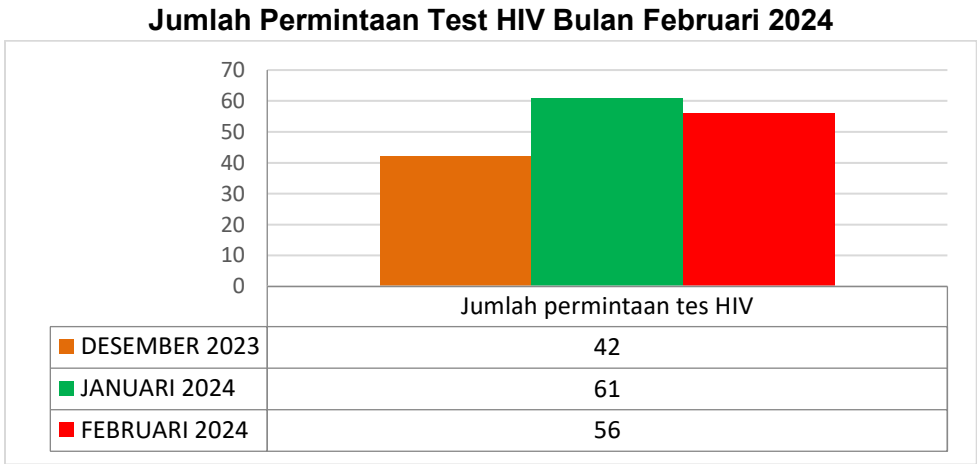
3.	Dr. Yunita, Sp. P				
		Ny. S	V		

Evaluasi :
 Semua dokter sudah patuh akan PPK (Panduan Praktek Klinis) TB, baik dari anamnesis, kriteria diagnosis, pemeriksaan penunjang, dan Edukasi. Akan tetapi pada *point* edukasi sosial (pencarian kontak serumah) tidak dilakukan

Rencana dan Tindak Lanjut :
 Tetap mempertahankan kepatuhan dokter sesuai dengan PPK TB yang berlaku di RS Prima Husada Kabupaten Malang.

c. HIV
Kinerja dan Produktivitas
 1. Jumlah permintaan Tes HIV

NO	URAIAN	BULAN		
		DESEMBER 2023	JANUARI 2024	FEBRUARI 2024
1	Permintaan Test HIV	42	61	56



Analisis :
 Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah permintaan test HIV pada bulan Februari 2024 menurun menjadi 56 pemeriksaan dibandingkan pada bulan Januari 2024 sebanyak 61 pemeriksaan. hal ini dikarenakan terdapat pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya.

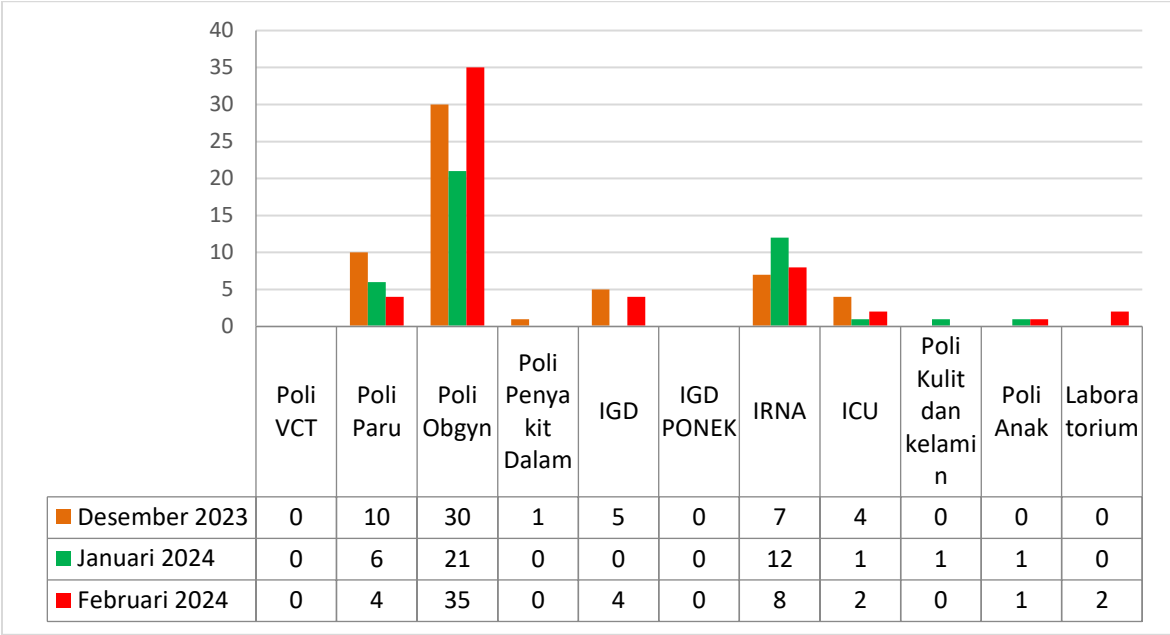
Rencana Tindak Lanjut :

Dilakukan skrining ulang pada pasien-pasien yang terduga HIV, pasien hamil trimester 3 dan juga pasien-pasien mandiri yang ingin dilakukan pemertiksaan HIV sesuai sukarela baik pasien IGD, rawat jalan maupun rawat inap.

2. ASAL PERMINTAAN TES HIV

No	URAIAN	BULAN		
		DESEMBER 2023	JANUARI 2024	FEBRUARI 2024
1	Poli Paru	0	0	0
2	Poli Obgyn	10	6	4
3	Poli Penyakit Dalam	30	21	35
4	IGD	1	0	0
5	IGD PONEK	5	0	4
6	IRNA	0	0	0
7	ICU	7	12	8
8	Poli Kulit dan Kelamin	4	1	2

Jumlah Asal Permintaan Tes HIV Bulan Februari 2024



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah asal permintaan test HIV di Poli kandungan tetap tinggi dibandingkan dari unit lain mulai bulan Januari 2024 21 pasien sedamngakan pda bulan februari 2024 35 pasien. Hal ini dikarenakan sudah tersdianya Reagen HIV dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk program ibu hamil sehingga pasien dengan kriteria hamil trimester II sudah bisa dilakukan screening HIV.

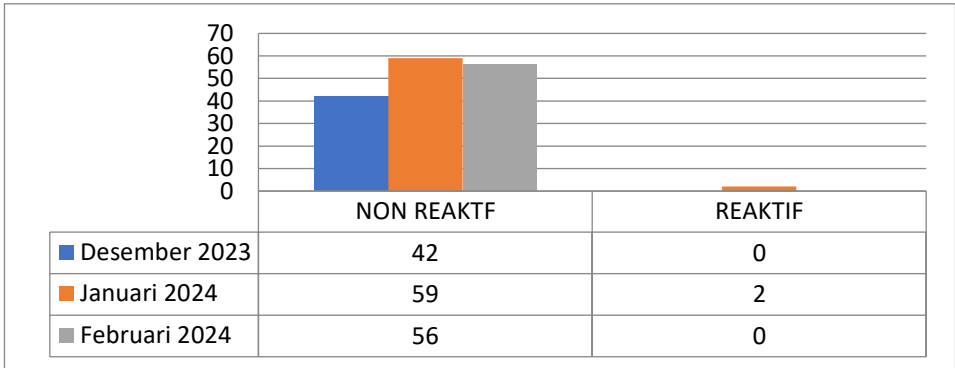
Rencana Tindak Lanjut :

Dilakukan sosialisasi terkait Permintaan testing HIV dilakukan baik di IGD, rawat jalan, maupun rawat jalan sesuai dengan kebutuhan pasien. Sehingga capaian permintaan testing HIV bisa berjalan.

3. STATUS HIV

NO	URAIAN	BULAN		
		DESEMBER 2023	JANUARI 2024	FEBRUARI 2024
1	Non Reaktif	42	59	56
2	Reaktif	0	2	0

Status HIV Bulan Februari 2024



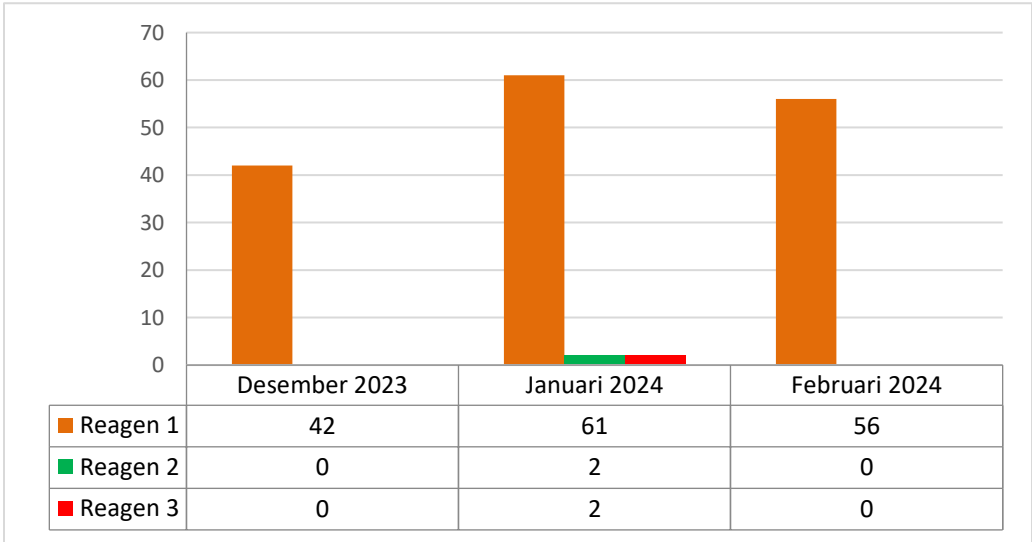
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data status HIV dengan status reaktif pada pada bulan februari 2024 sebanyak 0 pasien. Jumlah status reaktif dibanding pada bulan sebelumnya menurun dari 2 pasien menjadi 0

Rencana Tindak Lanjut :
Rumah sakt prima husada malang masih belum bisa melakukan pelayanan pasien dengan HIV/AIDS, apabila ditemukan pasien dengan HIV reaktif maka akan kami lakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah MOU dengan RS Prima Husada Malang.

4. JUMLAH PEMAKAIAN REAGEN

NO	URAIAN	BULAN		
		DESEMBER 2023	JANUARI 2024	FEBRUARI 2024
1	Reagen 1	42	61	56
2	Reagen 2	0	2	0
3	Reagen 3	0	2	0

Jumlah Pemakaian Reagen Bulan Februari 2024



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa pemakaian reagen Pada Januari 2024 sampai dengan reagen 3 sedangkan pada bulan february 2024 pemakaian reage hanya ampai reagen 1 saja. Hal ini dikarenakan pada bulan february 2024 tidak ada pasien dengan hasil HIV Reaktif.

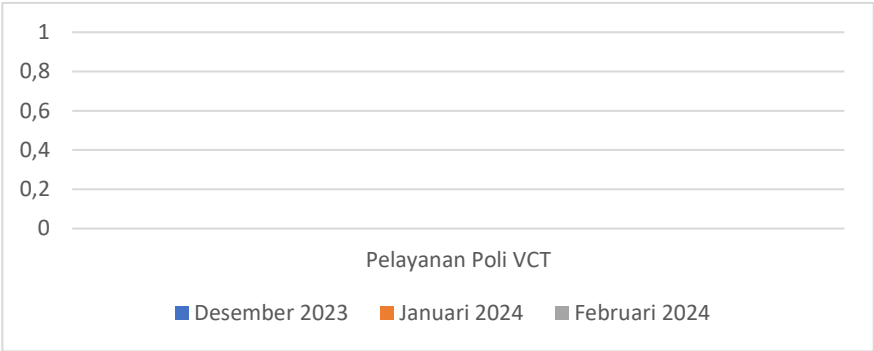
Rencana Tindak Lanjut :

Pemakaian reagen HIV tergantung dari hasil pemeriksaan dengan Reagen 1. Apabila dilakukan pemeriksaan dengan Reagen 1 hasil Non Reatif maka tidak dilanjutkan pemakaian Reagen 2 dan 3.
Tetapi apaila saat pemeriksaan dengan Reagen 1 ditemukan hasil Reaktif maka pemeriksaan dilanjutkan dengan penggunaan Reagen 2 dan Reagen 3

5. PELAYANAN VCT (*Voluntary Conseling And Testing*)

NO	URAIAN	BULAN		
		DESEMBER 2023	JANUARI 2024	FEBRUARI 2024
1	Pelayanan Poli VCT	0	0	0

Pelayanan Poli VCT Bulan Februari 2024



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa tidak ada kunjungan di poli VCT di RS Prima Husada. Hal ini dikarenakan kurang tahunya masyarakat terkait pentingnya deteksi pemeriksaan HIV/AIDS

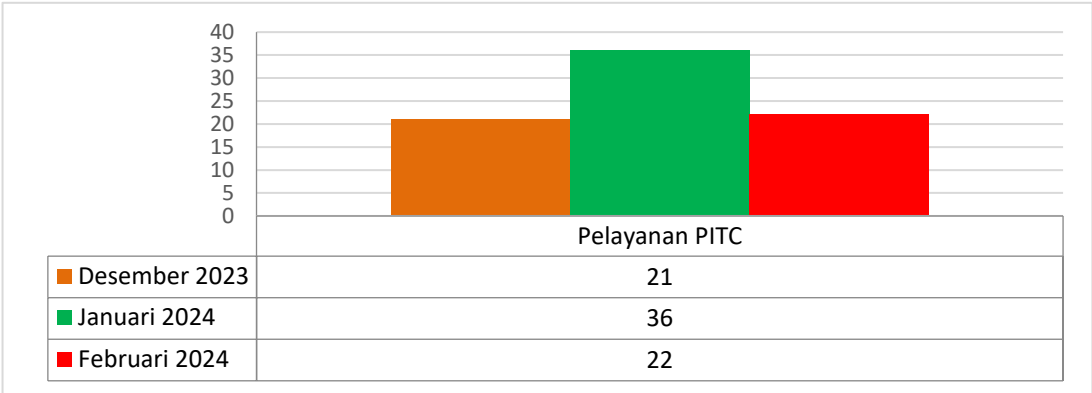
Rencana Tindak Lanjut :

Pelayanan Poli VCT di Rumah Sakit Prima Husadabelum berdiri sendiri, melainkan masih bergabung dengan oli penyakit Dalam di Rawat jalan. Hal ini dikarena asih belum adanya kunjungan pasien ke poli VCT

6. PELAYANAN PITC (*Provider Initiated Testing and Counseling*)

NO	URAIAN	BULAN		
		DESEMBER 2023	JANUARI 2024	FEBRUARI 2024
1	Pelayanan PITC	21	36	22

Pelayanan PITC Bulan Februari 2024



Analisis :

Dari data diatas terdapat keimpulan bahwa telah dilakukan edukasi pemeriksaan HIV oleh petugas kesehatan untuk dilakukan testing HIV pada bulan desember sebanyak 21 pasien. pada bulan Januari 2024 sebanyak 36 pasien sedangkan pada bulan februari 2024 sebanyak 21 pasien. Hal ini dikarenakan testing dan konseling dilakukan saat pasien menunjukan gejala HIV dan dilakukanya sreening baik di ruangan maupun IGD

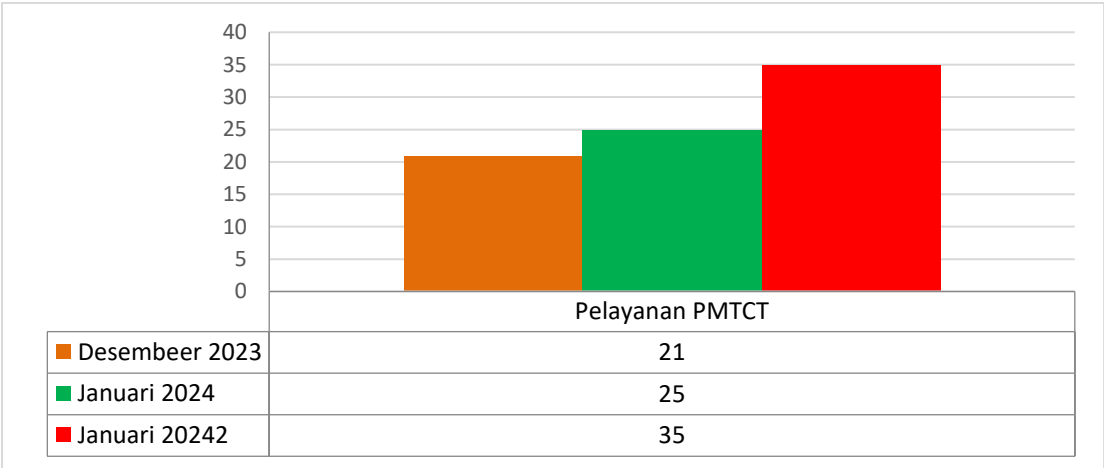
Rencana Tindak Lanjut :

Dilakukan peningkatan terkait penjarangan pasien dengan dialkukanya edukasi pasien tentang testing HIV kepada pengunjung atau masyarakat sehingga pasien paham tentang pentingnya dilakukan pemeriksaan HIV.

7. PELAYANAN PMTCT (Prevention to Mother Of Child Transmision)

NO	URAIAN	BULAN		
		DESEMBER 2023	JANUARI 2024	FEBRUARI 2024
1	Pelayanan PMTCT	21	25	35

Pelayanan PMTCT Bulan Februari 2024



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HIV sebagai screening dan deteksi pencegahan penularan dari ibu ke Bayi. Pada bulan januari 2024 sebanyak 25 pasien sedangkan pada bulan februari meningkat menjadi 34 pasien.

Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

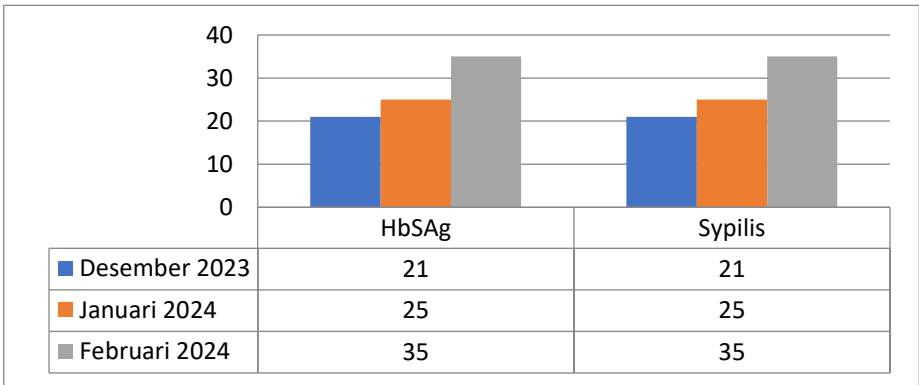
Rencana Tindak Lanjut :

Reagen pemeriksaan HIV yang diperoleh dari dinas kesehatan sudah tersedia di RS Prima Husada Malang sehingga Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

8. PELAYANAN PEMERIKSAAN TRIPLE EIMINASI PADA IBU HAMIL

NO	URAIAN	BULAN		
		DESEMBER 2023	JANUARI 2024	FEBRUARI 2024
1	HbSAg	21	25	35
2	Sypilis	21	25	35

**Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil
Bulan Februari 2024**



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HbSAg dan Sypilis pada bulan desember 21 pasien. pada bulan januari 2024 sebanyak 25 pasien sedangkan pada bulan februari 2024 sebanyak 34 pasien.

Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan triple eliminasi dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan Triple eliminasi di RS Prima Husada Malang untuk pemeriksaan HbSAg dan Sypilis bisa dilakukan.

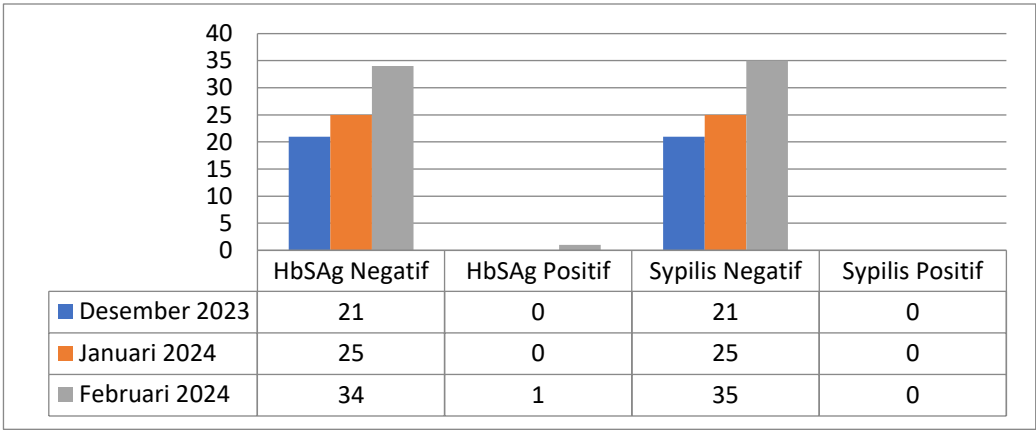
Rencana Tindak Lanjut :

Pemeriksaan Triple eliminasi untuk ibu hamil bersifat wajib dan dilakukan 1 kali saat awal kehamilan. Di RS Prima Husada skrining pemeriksaan triple eliminasi sudah berjalan dan dilakukan saat kunjungan pada Trimester 2.

9. STATUS PELAYANAN PEMERIKSAAN TRIPLE EIMINASI PADA IBU HAMIL

NO	URAIAN	BULAN		
		DESEMBER 2023	JANUARI 2024	FEBRUARI 2024
1	HbSAg			
	Negatif	21	25	34
	Positif	0	0	1
2	Sypilis			
	Negatif	21	25	35
	Positif	0	0	0

Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil
Bulan Februari 2024



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa ditemukan 1 kasus pasien dengan HbSAg positif pada buan Februari 2024 sebanyak 1 pasien. Sedangkan pada pemeriksaan syphilis tidak ada kasus pasien positif.

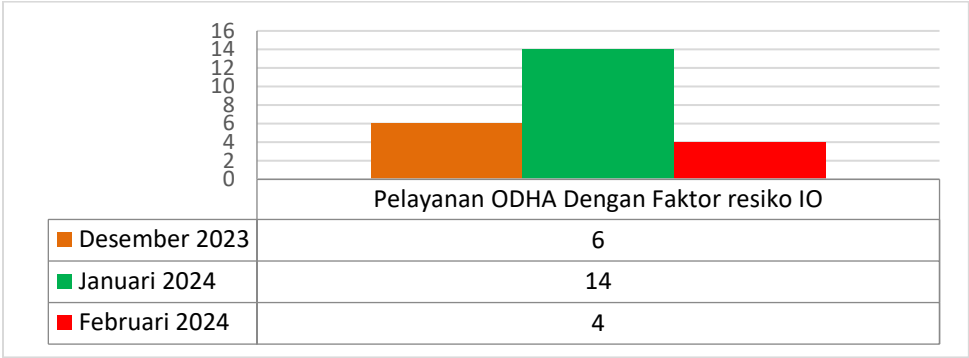
Rencana Tindak Lanjut :

1. Pada pasien HbSAg
- Saat kelahiran aka nada pemberian vaksin Hepatitis kepada bayi yaitu Hiper Heb dan juga Hb.O unijec yang diberikan saat bayi baru lahir sampai dengan maksimal 24 jam pemberian. Untuk ibu dengan HbSAg akan dilakukan pemberian vaksin hepatitis oleh Puskesmas sesuai domisili pasien.Penanganan pasien dengan HbSAg Rumah Sakit Prima Husada Malang Kolaborasi dengan puskesmas sesuai dengan domisili pasien.
2. Pada pasien Sypilis
- Di rumah sakit Prima Husada Malang sudah bisa melakukan pengobatan pasien dengan syphilis positif. Sehingga tidak lagi melakukan rujuk keluar.

10. PELAYANAN ODHA DENGAN FACTOR RESIKO INFEKSI OPORTUNISTIK

NO	URAIAN	BULAN		
		DESEMBER 2023	JANUARI 2024	FEBRUARI 2024
1	Pelayanan ODHA Dengan Faktor resiko IO	6	14	4

Pelayanan ODHA dengan Faktor Resiko IO
Bulan Februari 2024



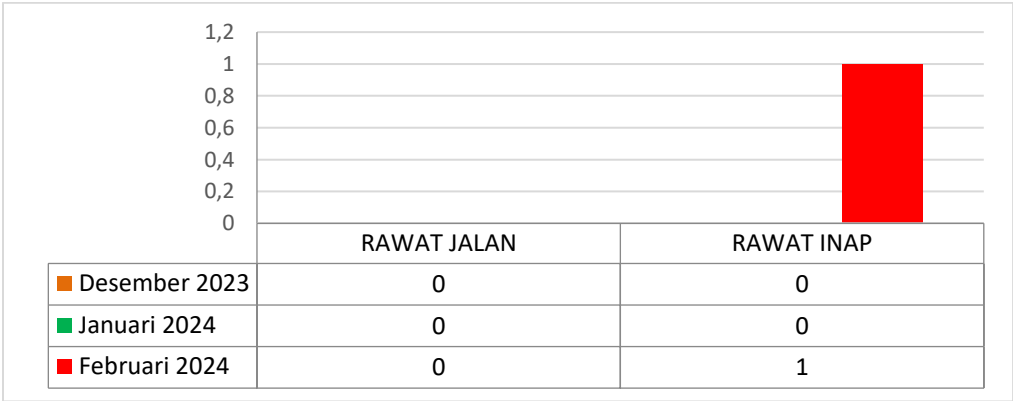
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa terdapat pasien dengan diagnose TB positif yang dilakukan pemeriksaan HIV di RS Prima Husada. Pada bulan Desember 2023 terjadi sebanyak 6 pasien. pada bulan Januari 2024 terjadi penigkatan yaitu 14 pasien. Sedangkan pada bulan Februari 2024 terjadi penurunan yaitu sebanyak 4 pasien. Hal ini dikarenakan dilakukanya screening pasien TB di RS Prima Husada Malang.

Rencana Tindak Lanjut :
Pasien-pasien dengan diagnose TB positif di Rumah Sakit Prima Husada Malang sudah patuh dilakukan screening pemeriksaan HIV/AIDS sesuai dengan SPO. Diharapkan bisa saling kerjasama antar tim yaitu TIM TB dan Tim HIV.

11. PELAYANAN RUJUKAN PASIEN DENGAN HIV/AIDS

NO	URAIAN	BULAN		
		DESEMBER 2023	JANUARI 2024	FEBRUARI 2024
1	Rawat Jalan	0	0	0
2	Rawat Inap	0	0	1

Pelayanan Rujukan Pasien dengan HIV/AIDS
Bulan Februari 2024



Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa pada bulan februari 2024 terdapat 1 pasien yang dilakukan rujuk eksternal dari rawat inap. Hal ini dikarenakan RS Prima husada malang belum bisa menangani pasien yang ditemukan positif HIV

Rencana Tindak Lanjut :

Pelaksanaan Rujukan dilakukan apabila hasil pemeriksaan HIV Reaktif. Rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah bekerjasama dengan Rumah Sakit Prima Husada Malang.

d. Stunting dan Wasting

1. Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting

NO	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1	Peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh staf , pasien, dan keluarga tentang masalah stunting dan wasting	Melakukan promosi kesehatan dengan melaksanakan edukasi pasien dan sosialisasi kepada seluruh staff mengenai pentingnya pencegahan dan penanganan stunting dan wasting.
2	Program 1000 HPK	Pemberian Penyuluhan tentang pentingnya pengasuhan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien
3	Suplementasi Folat Pada Ibu hamil	Suplementasi Folat Pada ibu hamil dilaksanakan di poli kandungan di RS Prima Husda Malang
4	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil	Pemberian PMT pada ibu hamil dilaksanakan pada saat kegiatan senam hamil di RS Prima Husada Malang
5	Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	1. Kegiatan konseling IMD dilaksanakan sesaat setelah ibu melahirkan 2. Konseling IMD dan ASI eksklusif dilaksanakan pada saat ibu telah memasuki rawat inap maternitas 3. Penyuluhan tentang pentingnya IMD dan pemberian ASI eksklusif juga dilaksanakan di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan
6	Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Pemantauan pertumbuhan bayi dan balita dilaksanakan di ruang rawat inap dan melakukan pendampingan di poli anak RS prima husada
8	Pemberian imunisasi	Pemberian imunisasi dilaksanakan di poli anak RS prima husada malang sesuai dengan jadwal praktek dokter spesialis anak dan di rawat inap sesaat setelah bayi baru dilahirkan.
9	Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Pemberian makanan tambahan balita gizi kurang dilaksanakan apabila ditemui balita dengan gizi kurang di rawat inap
10	Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi	1. Menyelenggarakan pelayanan konseling kesehatan maternal dan neonatal. 2. Konseling pemberian ASI eksklusif. 3. Penyediaan Pojok Laktasi untuk mendukung pemberian ASI eksklusif
11	Rumah Sakit sebagai pusat rujukan kasus stunting dan wasting	1. Penyusunan Pedoman Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Stunting, Gizi Kurang, Gizi Buruk pada Balita 2. Memastikan kasus, penyebab dan tatalaksana lanjut oleh dokter spesialis anak. 3. Melakukan evaluasi pelayanan, audit kesakitan dan kematian, pencatatan dan pelaporan gizi buruk dan stunting.
12	Rumah Sakit sebagai pendamping klinis dan manajemen serta	Pada Bulan Februari tidak terdapat Kerjasama dengan komunitas eksternal

	merupakan jejaring rujukan	
13	Program Pemantauan dan Evaluasi	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait edukasi yang sudah diberikan, serta membuat laporan dan evaluasi kegiatan.

Analisis :

1. Melakukan tindakan pelayanan penurunan dan penanggulangan stunting dan wasting di rumah sakit.
2. Melakukan edukasi mengenai pencegahan dan penanggulangan stunting dan wasting kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien di rumah skait.

2. Peningkatan Efektifitas Intervensi Gizi Spesifik

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	LOKASI	DES 2023	JAN 2024	FEB 2024
Program 1000 HPK	Penyuluhan mengenai kehidupan 1000 hari pertama	Pengunjung RS Prima Husada Malang	IRJA anak dan Kandungan	1	1	1
Suplementasi Asam folat pada ibu hamil	1. Penyuluhan tentang pentingnya konsumsi asam folat pada ibu hamil 2. Pembagian tablet tambah darah dan asam folat	Ibu Hamil	Senam Hamil , Poli Kandungan , Hall gedung baru lantai 5	1	1	1
Pemberian PMT Ibu Hamil	Pemberian PMT dengan tinggi kalori terutama pada ibu hamil terindikasi KEK	Ibu Hamil	Hall gedung baru lantai 5	1	1	1
Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Penyuluhan mengenai pentingnya Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Ibu hamil	IRJA anak dan kandungan, irna maternitas	1	1	1
Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)	1. Penyuluhan tentang stunting , makanan sehat	IRNA Anak	-	1	1	1

	pada bayi dan balita 2. Pembagian PMBA					
Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Melakukan Pencatatan dan plotting pada buku KIA setelah pengukuran berat badan dan tinggi badan anak	Pasien Anak	IRJA anak	1	1	1
Pemberian Imunisasi	Memastikan ketersediaan imunisasi agar selalu tersedia di poli anak	Pasien anak dan Bayi baru lahir	IRJA anak	1	1	1
Pemberian vitamin A	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian vitamin A	Pasien anak	IRJA anak	0	0	0
Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Memberikan PMT tinggi kalori dengan membantu menyusun menu yang sesuai dengan ketersediaan bahan pangan di lingkungan	Pasien anak	Rawat Inap	2	1	0
Pemberian Taburia pada Baduta	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian bubuk taburia	Pasien anak	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0
Pemberian Obat cacing pada ibu	Bekerja sama dengan	Ibu Hamil	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0

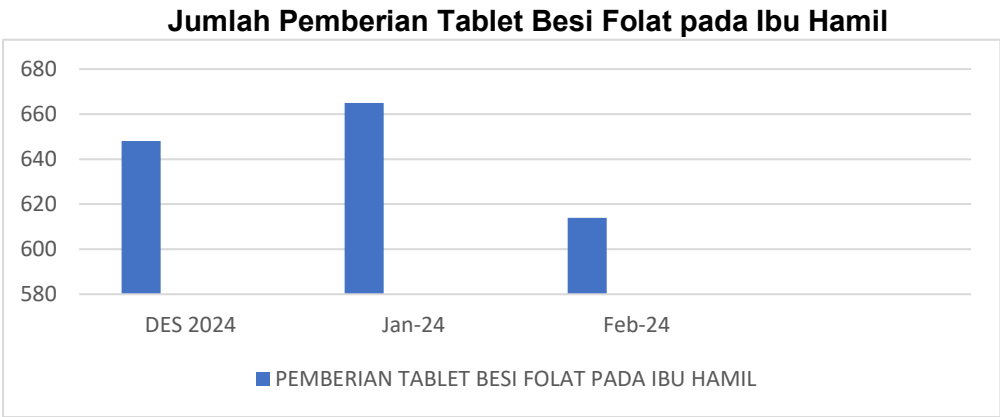
hamil	puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian obat cacing pada ibu hamil					
-------	---	--	--	--	--	--

Analisis :
 Sebagian besar intervensi spesifik yang dapat dilaksanakan di rumah sakit telah dilaksanakan. Akan tetapi pada intervensi spesifik berupa pemberian taburia dan vitamin A pada balita, pemberian obat cacing pada ibu hamil masih belum dilakukan karena ketersediaan taburia, obat cacing, dan vitamin A terdapat pada faskes 1.

Rencana Tindak Lanjut :
 Bekerjasama dengan puskesmas setempat agar dapat melakukan pendampingan intervensi spesifik di posyandu disekitar wilayah rumah sakit dan melakukan pemantauan kepada balita stunting.

3. Pemberian Tablet Besi Folat bagi Ibu Hamil

BULAN	DES 2023	JAN 2024	FEB 2024
Jumlah Ibu Hamil yang diberikan tablet besi folat di Poli kandungan	648	665	614

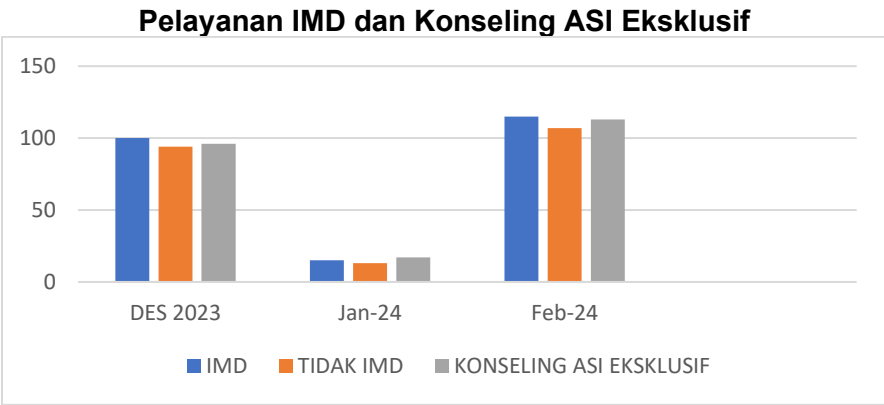


Analisis :
 Pemberian asam folat diberikan kepada ibu hamil pada usia kandungan trimester pertama. Sedangkan pemberian tablet zat besi diberikan pada usia kandungan trimester 2 dan 3. Jumlah pemberian tablet besi folat menurun pada bulan Februari yaitu 614 ibu hamil.

- Rencana Tindak Lanjut:**
- Koordinasi dengan tim farmasi untuk mendukung penyediaan tablet tambah darah, agar program suplementasi tablet tambah darah kepada ibu hamil terus berlanjut
 - Koordinasi dengan tim humas rumah sakit agar ibu hamil yang bergabung semakin banyak agar program suplementasi tablet besi folat semakin baik.

4. Angka capaian Ibu yang Melakukan IMD dan Mendapat konseling ASI Eksklusif

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		DESEMBER 2023	JANUARI 2024	FEBRUARI 2024
1	IMD	100	94	96
2	Tidak IMD	15	13	17
3	Mendapat Konseling ASI Eksklusif	115	107	113



Analisis :

1. Bayi yang dilakukan IMD pada bulan Februari 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan sebelumnya, yaitu 96 bayi, dikarenakan tidka semua bayi memenuhi kriteria melakukan IMD.
2. Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan Februari 2024 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 17 bayi. Hal ini terjadi diiringi dengan masih adanya bayi lahir dengan berat <2500 gr sehingga tidak dilakukan IMD.
3. Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
4. 100% ibu melahirkan telah mendapatkan edukasi menyusui. Untuk mendukung pemberian ASI secara eksklusif. Jumlah Ibu mendapat konseling ASI Eksklusif meningkat pada bulan Januari 2024 dikarenakan terdapat dokter spesialis kandungan baru sehingga juga meningkatkan kunjungan jumlah pasien ibu hamil.

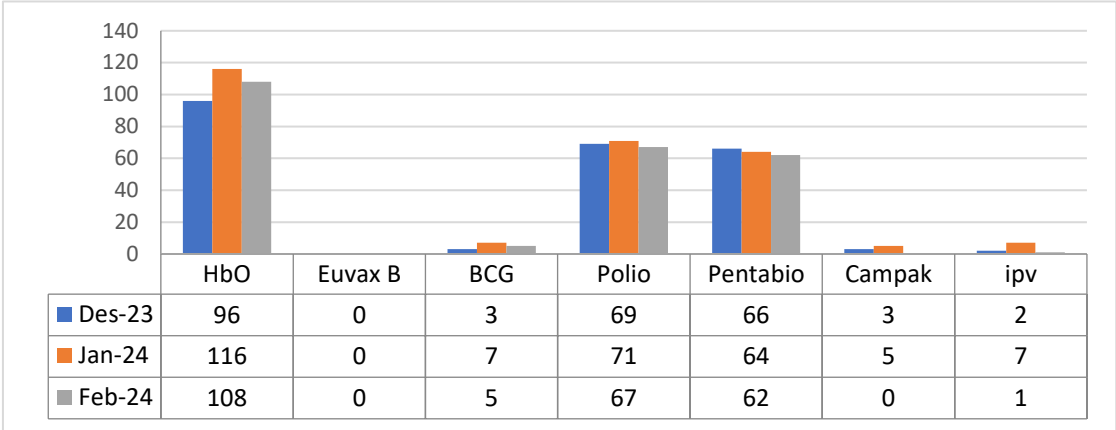
Rencana Tindak Lanjut:

Tingkatkan koordinasi dengan dokter kandungan dan bidan rumah sakit dalam pemberian edukasi tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif serta mendokumentasikan bukti telah melakukan edukasi kepada ibu melahirkan pada lembar edukasi.

5. Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		DESEMBER 2023	JANUARI 2024	JANUARI 2024
1	HbO	96	116	108
2	Euvax B	0	0	0
3	BCG	3	7	5
3	Polio	69	71	67
4	Pentabio	66	64	62
5	Campak	3	5	0
6	IPV	2	7	1

Pelayanan Imunisasi Bulan Februari 2024



Analisis:

- 1. Tidak ada penggunaan vaksin euvax B pada periode Februari 2024 maupun 2 bulan sebelumnya, hal ini dikarenakan banyak nya pasien bayi baru lahir dengan status BPJS, sehingga memakai imunisasi HB.O unijek.
- 2. Imunisasi Hbo pada bulan Februari mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 108 bayi. Dan ini seiring dengan jumlah bayi baru lahir yang ada di RS
- 3. Bayi yang melakukan Imunisasi IPV Pada bulan Februari menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 1 bayi
- 4. Bayi yang melakukan Imunisasi BCG Pada bulan Februari 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 1 bulan sebelumnya, yaitu 5 pasien.
- 5. Pada periode Februari 2024 tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi Campak
- 6. Bayi yang melakukan Imunisasi Polio Pada bulan Februari 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 67 bayi
- 7. Jumlah pasien yg imunisasi Pentabio pada bulan Februari 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 62 pasien
- 8. Secara keseluruhan jumlah pemberian imunisasi pada balita menurun dikarenakan Sebagian besar balita melakukan pin polio di posyandu masing masing sehingga membuat jumlah kunjungan imunisasi yang dilakukan di poli anak menurun.

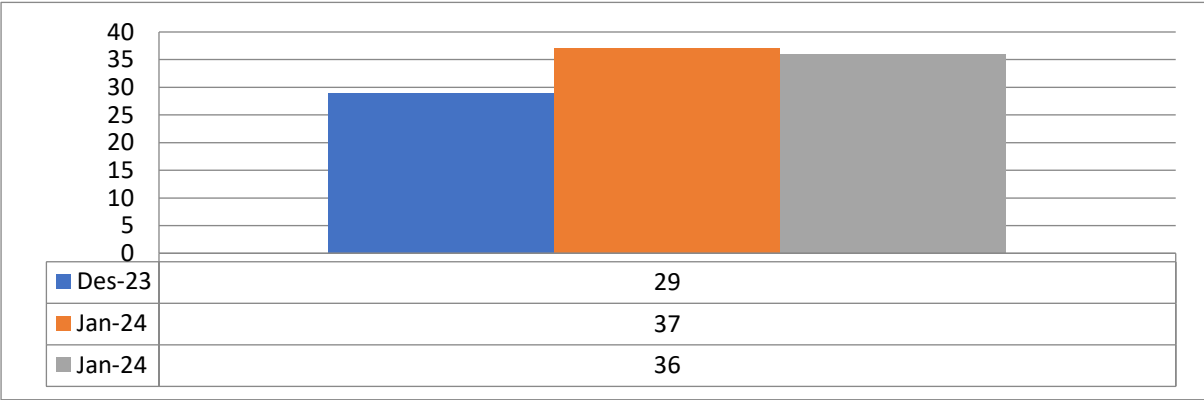
Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit.

6. Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi

KEGIATAN PENERAPAN RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI	DESEMBER 2023	JANUARI 2024	FEBRUARI 2024
Ruang Pojok Laktasi	1	1	1
Senam Hamil	25	37	36
Pembentukan Grup Laktasi	1	1	1

Senam Hamil Bulan Februari 2024



Analisis :

- 1. Pojok laktasi sudah tersedia untuk ibu dan bayi yang akan menyusui di wilayah rumah sakit prima husada malang.
- 2. Grup Laktasi dibentuk untuk memberikan tips menyusui.
- 3. Peserta Senam Hamil pada bulan Februari mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 36 peserta. Dengan meningkatkan sarana yang nyaman, diharapkan dapat meningkatkan jumlah peserta senam hamil.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Mengajukan perlengkapan untuk keperluan menyediakan pojok laktasi yang nyaman bagi bayi, balita, dan ibu menyusui seperti pampers dan tissue basah jika terdapat pasien atau pengunjung yang membutuhkan.
- 2. Melakukan edukasi mengenai pentingnya mengikuti senam ibu hamil pada ibu hamil yang tidak memiliki kondisi penyulit saat hamil.

7. Rumah Sakit Sebagai Pusat Rujukan Kasus Stunting Dan Wasting

NO	RUJUKAN	DESEMBER 2023	JANUARI 2024	FEBRUARI 2024
1	Rujukan Masuk	0	0	0
2	Rujukan Keluar	0	0	0

Analisis :

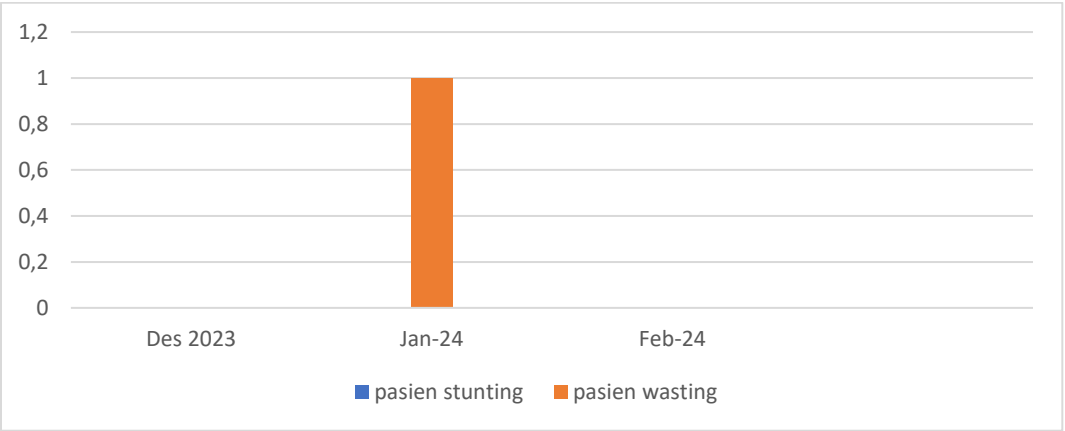
Tidak Terdapat pasien stunting dan wasting yang dirujuk keluar maupun masuk pada bulan Februari 2024.

Rencana Tindak Lanjut:

Perlu diadakan kerjasama lagi dengan puskesmas dan klinik faskes pertama untuk bekerjasama dalam menjangir pasien stunting dan wasting.

8. Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan

BULAN	DESEMBER 2023	JANUARI 2024	FEBRUARI 2024
Jumlah Pasien Stunting	0	0	0
Jumlah Pasien Wasting	0	1	0



Analisa :
Terdapat 1 pasien wasting pada bulan Januari. Hal tersebut berkaitan dengan pola makan pasien yang terbilang kurang yaitu 2x sehari dan jumlah asupan makan sekali makan terbilang kurang yaitu 2 sdm tiap makan.

Rencana Tindak Lanjut :
Tim Stunting dan Wasting RS Prima Husada memberikan terapi dengan bekerja sama dengan dokter spesialis anak untuk memberikan vitamin dan antibiotik yang dibutuhkan untuk mengatasi infeksi yang diderita pasien. Selain itu tim SW juga bekerjasama dengan cara melaporkan pasien stunting kepada petugas Gizi Puskesmas wilayah pasien tinggal untuk melakukan pemantauan lebih lanjut dan pemberian intervensi lanjutan kepada balita stunting dan wasting tersebut.

- 9. Program Pemantauan dan Evaluasi**
Program pemantauan dan evaluasi yang diberikan kepada pasien stunting dan wasting adalah dengan cara mengontrol pola makan, berat badan dan tinggi badan pasien pada saat pasien melakukan kunjungan kontrol *post KRS*.

Analisa :
Program pemantauan dan evaluasi pasien stunting yang ditemukan saat rawat inap masih belum terlaksana dikarenakan pasien tersebut tidak melakukan kunjungan kontrol *post KRS*.

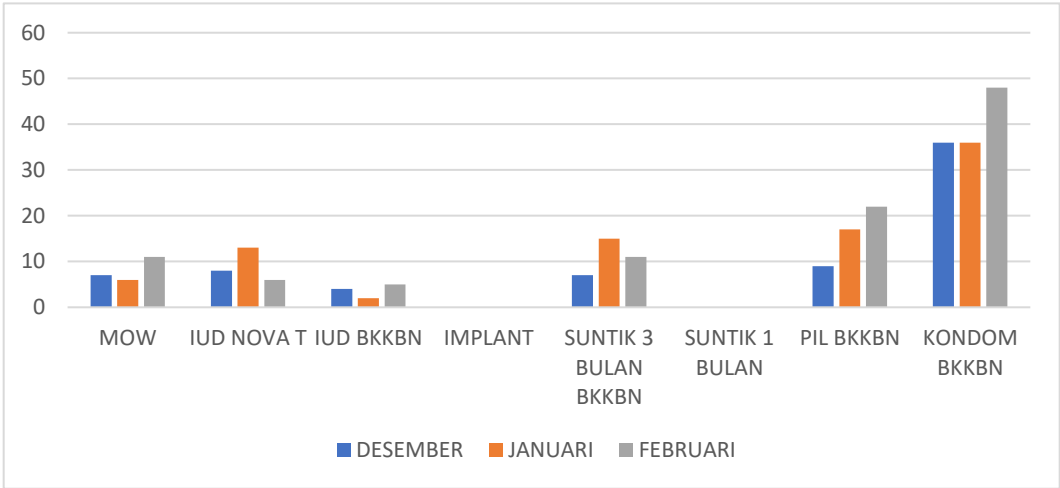
Rencana Tindak Lanjut :
Menghubungi petugas gizi untuk melakukan pemantauan berat badan , tinggi badan, dan pola makan pada balita stunting yang ditemukan tim stunting dan wasting RS Prima Husada Malang.

e. KBRS

1. Angka Capaian Pelayanan KB Per-Metode Kontrasepsi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH ALAT KONTRASEPSI		
		DESEMBER 2023	JANUARI 2024	FEBRUARI 2024
1	MOW	7	6	11
2	IUD NOVA T	8	13	6
3	IUD BKKBN	4	2	5
4	IMPLANT BKKBN	0	0	0
5	SUNTIK 3 BULAN BKKBN	7	15	11
6	SUNTIK 1 BULAN BKKBN	0	0	0
7	PIL BKKBN	9	17	22
8	KONDOM BKKBN	36	36	48

Angka Capaian Pelayanan KB Per-Metode Kontrasepsi



Evaluasi :

- 1. Peserta MOW pada bulan Desember (7), bulan Januari (6) meningkat pada bulan Februari (11)
- 2. Peserta IUD Nova T pada bulan Desember (8) meningkat pada Januari (13) dan pada bulan Februari (6) Peserta IUD BKKBN, pada bulan Desember (4) menurun Januari (2) dan meningkat pada bulan februari (5)
- 3. Peserta KB suntik 3 bulan, pada bulan Desember terdapat (7) Januari (15) Februari (11)
- 4. Peserta KB pil pada bulan Desember terdapat (9) dan meningkat pada Januari (17) Februari (22)

Analisis :

- 1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
- 2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
- 3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.

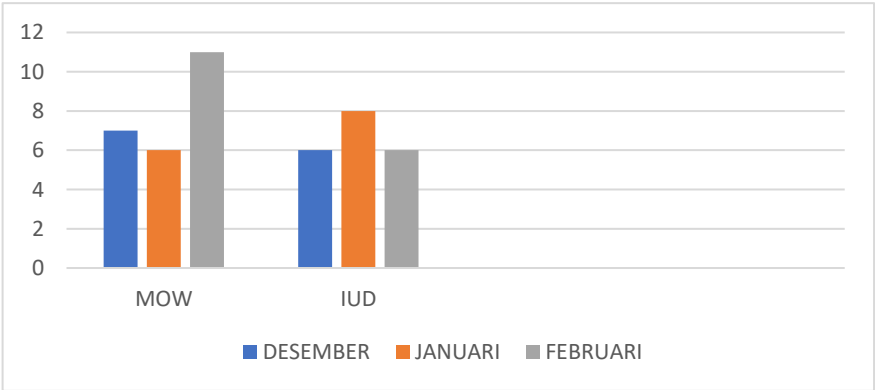
Rencana Tindak Lanjut :

Demi meningkatkan capaian KB maka rumah sakit akan melakukan pelatihan internal bagi para bidan dalam pemasangan IUD pasca plasenta,dan akan diadakan safari KB setiap 2 bulan sekali

2. Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan Dan Pasca Keguguran

NO	JENIS PELAYANAN PASCA PERSALINAN	JUMLAH PASIEN		
		DESEMBER 2023	JANUARI 2024	FEBRUARI 2024
1	MOW	7	6	11
2	IUD	6	8	6

Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan



NO	JENIS PELAYANAN PASCA KEGUGURAN	JUMLAH PASIEN		
		DESEMBER 2023	JANUARI 2024	FEBRUARI 2024
1	MOW	0	0	0
2	IUD	0	0	0



- Evaluasi :**
- 1. Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan pada bulan Januari-Februari meningkat
 - 2. Angka capaian pelayanan KB pasca keguguran pada bulan Januari-Februari menetap

- Analisis :**
- 1. Peningkatan jumlah sasaran pada triwulan pertama kemungkinan didapatkan karena sasaran KB sudah mengetahui pentingnya KB dari pengetahuan yang didapatkan saat sosialisasi yang dilakukan tim setiap bulannya.
 - 2. Capaian pelayanan KB pasca keguguran menetap dikarenakan peserta mempunyai alasan ingin segera hamil lagi

- Rencana Tindak Lanjut :**
- 1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
 - 2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
 - 3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.

BAB IV
DATA UTILITAS UNIT

A. Pelayanan Medis

a. Tabel Data Kamar Operasi

NO	JENIS OPERASI	UMUM	BPJS KES	BPJS TK	ASURANSI SWASTA	PERUSAHAAN	JASA RAHARJA	JUMLAH
1.	Kecil	0	48	0	0	0	0	48
2.	Sedang	0	7	0	0	0	0	7
3.	Besar	3	268	1	3	3	3	281
4.	Khusus	1	25	9	1	3	1	40
	Jumlah	4	348	10	4	6	4	376

1. 10 Tindakan Operatif

NO	DESKRIPSI	JUMLAH
1.	SC	73
2.	Phaco	41
3.	Debridement Necrotomy	36
4.	Orif	28
5.	Excisi	25
6.	Herniotomy	18
7.	Repair	12
8.	Appendectomy	10
9.	Remove Implant	9
10.	Debridement	9

2. 10 Besar Diagnostik Operatif

NO	DESKRIPSI	JUMLAH
1.	Katarac	41
2.	Close fraktu	34
3.	Necrotizing	24
4.	Hernia	18
5.	Tumor	14
6.	Appendicitis	12
7.	Crush Injury	11
8.	Union Fr	10
9.	Ganglion	8
10.	BPH	8

b. Tabel Data Instalasi Rawat Jalan

1. Kunjungan Rawat Jalan Bulan Desember 2023

NO	JENIS PELAYANAN	UMUM		BPJS KES		BPJS TK		JASA RAHARJA		ASURANSI SWASTA		PERUSAHAAN		TOTAL
		PX BARU	PX LAMA	PX BARU	PX LAMA	PX BARU	PX LAMA	PX BARU	PX LAMA	PX BARU	PX LAMA	PX BARU	PX LAMA	
1	Anak	56	216	22	842	0	0	0	0	2	61	0	5	1204
2	IGD	175	299	49	189	14	6	0	0	11	19	1	01	764
3	Bedah	4	28	37	1029	0	5	0	3	0	3	0	1	1110
4	Bedah Plastik	0	5	3	19	0	1	0	0	0	1	0	0	29
5	Fisioterapi	1	33	0	1045	0	18	0	0	0	0	0	0	1097
6	Gigi spesialis	0	3	0	0	0	0	0	0	3	19	0	0	25
7	Gizi	16												16
8	Klinik Ibu danBayi	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
9	Jantung	4	8	12	1207	0	0	0	0	0	6	0	0	1237
10	Jiwa	1	5	6	191	0	0	0	0	0	0	0	0	203
11	Kandungan	68	307	44	718	0	0	0	0	6	14	1	2	1160
12	Kulit dan kelamin	23	43	21	263	0	0	0	0	0	7	1	0	358
13	Mata	13	16	35	1064	0	0	0	0	1	6	0	0	1135
14	Orthopedi	1	14	17	438	1	49	0	0	1	2	0	4	527
15	Paru	0	19	8	447	0	0	0	0	0	5	0	0	479
16	Penyakit dalam	16	64	35	2649	0	0	0	0	2	25	0	0	2791
17	Saraf	11	28	29	1244	0	2	0	0	1	5	0	0	1320
18	THT	19	24	25	117	0	0	0	0	3	8	1	2	199
19	Urologi	11	17	27	367	0	0	0	0	0	2	0	7	431
20	Klinik Umum	52	16	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	107
JUMLAH		471	1179	370	11829	15	81	0	3	30	183	43	22	14226

2. Kunjungan Rawat Jalan Bulan Januari 2024

N O	JENIS PELAYANAN	UMUM		BPJS KES		BPJS TK		JASA RAHARJA		ASURANSI SWASTA		PERUSAHAAN		TOTAL
		PX BARU	PX LAMA	PX BARU	PX LAMA	PX BARU	PX LAMA	PX BARU	PX LAMA	PX BARU	PX LAMA	PX BARU	PX LAMA	
1	Anak	56	260	34	622	0	0	0	0	7	51	0	2	1032
2	IGD	121	122	93	282	9	13	0	0	10	26	0	2	678
3	Bedah	8	36	48	969	0	5	0	3	1	0	0	0	1070
4	Bedah Plastik	0	2	2	28	0	4	0	0	0	0	0	0	36
5	Fisioterapi	0	27	0	1115	0	18	0	0	0	1	0	0	1161
6	Gigi spesialis	1	6	0	0	0	0	0	0	3	8	0	0	18
7	Gizi	4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
8	Klinik Ibu danBayi	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
9	Jantung	3	19	17	1551	0	0	0	0	1	8	0	2	1601
10	Jiwa	0	8	7	226	0	0	0	0	0	1	0	0	242
11	Kandungan	79	322	52	825	0	0	0	0	1	23	0	2	1304
12	Kulit dan kelamin	13	27	29	366	0	0	0	0	1	9	0	2	447
13	Mata	13	11	56	1224	0	2	0	0	0	2	0	0	1308
14	Orthopedi	9	24	26	484	1	54	0	1	0	0	0	10	609
15	Paru	3	17	15	552	0	0	0	0	0	3	0	0	590
16	Penyakit dalam	18	68	41	2871	0	0	0	0	1	14	0	1	3014
17	Saraf	9	27	28	1225	0	1	0	0	1	2	0	0	1293
18	THT	25	34	42	167	0	0	0	2	1	4	1	7	283
19	Urologi	7	20	31	328	0	0	0	0	1	2	0	0	389
20	Klinik Umum	65	11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	83
JUMLAH		434	1074	521	12835	10	97	0	6	28	155	1	34	15195
TOTAL		1508		13356		107		6		183		35		

3. Kunjungan Rawat Jalan Bulan Februari 2024

NO	JENIS PELAYANAN	UMUM		BPJS KES		BPJS TK		JASA RAHARJA		ASURANSI SWASTA		PERUSAHAAN		TOTAL
		PX BARU	PX LAMA	PX BARU	PX LAMA	PX BARU	PX LAMA	PX BARU	PX LAMA	PX BARU	PX LAMA	PX BARU	PX LAMA	
1	Anak	30	170	22	787	0	0	0	0	0	46	0	11	1066
2	IGD	117	120	72	265	14	10	0	0	9	16	0	3	626
3	Bedah	13	34	45	767	0	2	0	2	0	7	0	0	870
4	Bedah Plastik	1	2	0	17	0	1	0	0	0	0	0	1	22
5	Fisioterapi	2	5	0	1024	0	17	2	0	0	1	0	0	1051
6	Gigi spesialis	6	4	0	1	0	0	0		0	6	0	1	18
7	Gigi spesialis periodonti	0	0	3	10	0	0	0	0	1	1	0	2	17
7	Gizi	8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
8	Klinik Ibu danBayi	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
9	Jantung	3	7	23	1611	0	0	0	0	1	6	0	0	1651
10	Jiwa	2	8	5	195	0	0	0	0	0	0	0	0	210
11	Kandungan	65	250	47	710	0	1	0	0	7	10	0	4	1094
12	Kulit dan kelamin	12	27	26	240	0	0	0	0	2	19	1	3	330
13	Mata	11	12	23	1051	0	0	0	0	2	7	0	0	1106
14	Orthopedi	8	14	13	451	0	49	0	3	0	4	0	4	546
15	Paru	7	14	0	460	0	0	0	0	0	3	0	0	484
16	Penyakit dalam	16	46	42	2740	0	0	0	0	1	16	0	5	2866
18	Penyakit dalam Sub EMD	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
17	Saraf	2	18	26	1322	0	1	0	0	0	2	0	0	1371
18	THT	13	26	30	126	0	0	0	1	0	12	0	0	208
19	Urologi	10	18	31	337	0	0	0	0	0	2	0	0	398
20	Klinik Umum	15	12	0	0	0	0	0	0	2	8	0	0	37
JUMLAH		341	826	408	12114	14	81	2	6	25	166	1	34	14018
TOTAL		1167		12522		95		8		191		35		

c. Tabel Data Instalasi Rawat Inap

1. Kunjungan Rawat Inap Bulan Desember Tahun 2023

NO	JENIS PELAYAN	UMUM	BPJS KES	BPJS TK	KEMENKES	JASARAHAARJA	ASURANSISWASTA	PERUSAHAAN	BPJS IKUTIBU	TOTAL
1	VVIP	1	3	0	0	0	3	0	0	7
2	VIP	6	13	0	0	0	4	1	0	24
3	Kelas I	4	154	0	0	0	3	3	0	164
4	Kelas II	12	277	17	0	0	1	0	0	307
5	Kelas III	30	343	2	0	2	0	1	0	378
6	ICU	1	22	0	0	0	0	0	0	23
7	Maternitas	1	34	0	0	0	0	0	0	35
8	Neonatalogi	1	11	0	0	0	0	0	97	109
9	NICU	1	6	0	0	0	0	0	0	7
10	Isolasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ICU T -	1	17	0	0	0	0	0	0	18
TOTAL		58	880	19	0	2	11	5	97	1072

2. Kunjungan Rawat Inap Bulan Januari Tahun 2024

NO	JENIS PELAYAN	UMUM	BPJS KES	BPJS TK	JASARAHAARJA	ASURANSISWASTA	PERUSAHAAN	BPJS IKUTIBU	TOTAL
1	VVIP	1	5	0	0	0	0	0	6
2	VIP	4	13	0	0	4	0	0	21
3	Kelas I	1	170	0	1	3	4	0	179
4	Kelas II	18	306	14	0	0	0	0	338
5	Kelas III	33	427	7	0	1	1	0	469
6	ICU	1	16	1	2	0	0	0	20
7	Maternitas	0	37	0	0	0	0	0	37
8	Neonatalogi	3	11	0	0	1	0	104	119
9	NICU	0	3	0	0	0	0	0	3
10	Isolasi	0	13	0	0	0	0	0	13
11	ICU T -	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		61	1001	22	3	9	5	104	1205

3. Kunjungan Rawat Inap Bulan Februari Tahun 2024

NO	JENIS PELAYAN	UMUM	BPJS KES	BPJS TK	KEMENKES	JASA RAHARJA	ASURANSI SWASTA	PERUSAHAAN	BPJS IKUT IBU	PEMERINTAH LAINYA (TASPEN)	TOTAL
1	VVIP	0	10	0	0	0	1	0	0	0	11
2	VIP	6	12	1	0	0	2	0	0	0	21
3	Kelas I	3	151	0	0	1	7	2	0	0	164
4	Kelas II	15	302	15	0	2	2	0	0	0	336
5	Kelas III	26	390	1	0	4	0	1	0	1	423
6	ICU	3	19	0	0	0	0	0	0	0	22
7	Maternitas	0	35	0	0	0	0	0	0	0	35
8	Neonatologi	3	11	0	0	0	2	0	101	0	117
9	NICU	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
10	Isolasi	3	14	0	0	0	0	0	0	0	17
11	ICU T -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		59	945	17	0	7	14	3	101	1	1147

d. Tabel Data Instalasi Gawat Darurat (IGD)
1. Bulan Desember 2023

NO.	STATUS PASIEN	JUMLAH PASIEN					TUJUAN RUJUKAN	ALASAN RUJUK
		UMUM	BPJS KES	BPJS TK	JASA RAHARJA	ASURANSI SWASTA		
1	Rawat Jalan	463	254	17	0	37	-	-
2	Rawat Inap	59	567	14	1	13	-	-
3	Rujuk	0	24	0	1	0	RSUD Lawang RSSA RS UMM RST Soepraoen RS Karsa Husada Batu	Pro penanganan lebih lanjut (Pro HD, Pro PCI, Pro Trepanasi)
4	Meninggal	10	5	0	0	0	-	-

2. Bulan Januari 2024

NO.	STATUS PASIEN	JUMLAH PASIEN					TUJUAN RUJUKAN	ALASAN RUJUK
		UMUM	BPJS KES	BPJS TK	JASA RAHARJA	ASURANSI SWASTA		
1	Rawat Jalan	232	414	17	1	35	-	-
2	Rawat Inap	45	682	7	0	6	-	-

3	Rujuk	4	19	1	1	0	RSUD Soetomo RSSA RSUD Lawang RST Soepraoen RS Lavalette RS Karsa Husada Batu RS Unisma RS PHS	Pro penanganan lebih lanjut (Pro HD, Pro PCI, Pro Trepanasi, Pro Stroke unit)
4	Meninggal	5	4	0	0	0	-	-

3. Bulan Februari 2024

NO.	STATUS PASIEN	JUMLAH PASIEN					TUJUAN RUJUKAN	ALASAN RUJUK
		UMUM	BPJS KES	BPJS TK	JASA RAHARJA	ASURANSI SWASTA		
1	Rawat Jalan	235	363	22	0	28	-	-
2	Rawat Inap	48	747	11	3	8	-	-
3	Rujuk	1	10	1	1	0	RSUD Soetomo RSSA RSUD Lawang RST Soepraoen RS Lavalette RS Karsa Husada Batu RS Unisma RS PHS	Pro penanganan lebih lanjut (Pro HD, Pro PCI, Pro Trepanasi, Pro Stroke unit)
4	Meninggal	5	4	1	1	0	-	-

B. Penunjang Medis

a. Tabel Data Laboratorium

1. Daftar Pemeriksaan Lab yang Dilakukan Di Dalam RS Prima Husada Malang

NO	JENIS PEMERIKSAAN	DES 2023	JAN 2024	FEB 2024
1	Patologi Klinik			
	Kimia darah	4486	4915	4931
	Hematologi	2062	2406	2377
	Serologi dan Molekuler	553	568	507
	Urine	292	371	372
	Liquor	-	-	-
	Transudat/Eksudat	-	-	-
	Feses	71	54	43
2	Patologi Anatomi			

	Pemeriksaan Sitologi	-	1	2
	Pemeriksaan Histopatologi	8	25	34
3	Bakteriologi/Mikrobiologi	8	11	14
4	Narkoba	50	67	22
5	Covid-19	76	69	73

2. Daftar Pemeriksaan Lab Yang Dilakukan Diuar RS Prima Husada Malang

NO	JENIS PEMERIKSAAN	DES 2023	JAN 2024	FEB 2024
1	Patologi Klinik			
	Kimia darah	24	1	0
	Hematologi	3	0	3
	Serologi dan Molekuler	14	24	3
	Urine	-	-	1
	Transudat/Eksudat	-	-	-
	Liquor	-	-	-
	Feses	1	-	-
2	Patologi Anatomi			
	Pemeriksaan Sitologi	5	7	6
	Pemeriksaan Histopatologi	69	66	40
3	Bakteriologi/Mikrobiologi	15	19	14
4	PCR	-	-	2
5	Tumor Marker	2	20	2

Analisis

Angka rujukan pemeriksaan patologi anatomi di Laboratorium luar masih mendominasi diantara pemeriksaan lainnya dalam 3 bulan terkahir, yaitu :

1. Patologi Anatomi : 46 sampel
2. Bakteriologi/Mikrobiologi : 14 sampel
3. Patologi Klinik : 7 sampel
4. Tumor Marker : 2 sampel
5. PCR : 2 sampel (kasus covid-19 sudah jarang ditemui)

Rencana Tindak Lanjut

Perencanaan Tahun 2024 laboratorium mengadakan pengembangan pelayanan dengan mendirikan Laboratorium PA di RS Prima Husada Malang, untuk mengurangi jumlah rujukan dan meningkatkan pendapatan.

b. Tabel Data Radiologi

JENIS PEMERIKSAAN	JENIS PEMBAYARAN	DES 2023	JAN 2024	FEB 2024
1. Radiodiagnostik	Umum	125	437	20
	BPJS Kesehatan	545	720	666
	BPJS TK	80	40	35
	Asuransi Swasta	15	80	65
	Jasaraharja	160	100	90
Total		925	1377	876
2. Foto Tanpa Bahan Kontras	Umum	125	437	20
	BPJS Kesehatan	545	720	666
	BPJS TK	80	40	35
	Asuransi Swasta	15	80	65
	Jasaraharja	160	100	90
Total		925	1377	876

3. Foto Dengan Rol Film	Umum	125	437	20
	BPJS Kesehatan	545	720	666
	BPJS TK	80	40	35
	Asuransi Swasta	15	80	65
	Jasaraharja	160	100	90
Total		925	1377	876
4. CT Scan tanpa kontras	Umum	8	-	29
	BPJS Kesehatan	80	11	201
	BPJS TK	4	-	-
	Asuransi Swasta	-	-	-
	Jasaraharja	10	-	-
Total		102	11	230
5. CT Scan dengan kontras	Umum	-	-	-
	BPJS Kesehatan	60	-	7
	BPJS TK	-	-	-
	Asuransi Swasta	-	-	-
	Jasaraharja	-	-	-
Total		60	0	7
6. USG tanpa kontras	Umum	52	44	35
	BPJS Kesehatan	110	150	198
	BPJS TK	-	-	-
	Asuransi Swasta	-	-	-
	Jasaraharja	-	-	-
Total		162	194	233

Analisis

- Pelayan pemeriksaan dalam 3 bulan terakhir meliputi USG, CT-Scan, dan Rontgen terbagi menjadi pasien Umum, BPJS, dan Asuransi.
 Pada 3 bulan terakhir pemeriksaan terbanyak yaitu:
 - Rontgen : 2628 pasien
 - CT Scan : 237 pasien
 - USG : 233 pasien
- Pada bulan Februari produktivitas radiologi pada pemeriksaan radiodiagnostik sejumlah 876 pasien. Terbagi menjadi pasien Umum, BPJS, dan Asuransi. Mengalami penurunan di bandingkan pada bulan Januari.
- Pada bulan Februari CT-Scan tanpa kontras mengalami peningkatan karena banyak menerima ct scan rujukan dari RS Prima Husada Sukorejo.
- Kunjungan radiologi USG dan CT-Scan meningkat dibandingkan bulan Januari.

Rencana Tindak Lanjut

- Koordinasi dengan Humas & Marketing untuk mengadakan promo/MOU dengan RS yang belum mempunyai Alat CT Scan jika sudah diperbaiki untuk menaikan pendapatan.
- Membuat SPO pelayanan pemeriksaan radiologi dari rujukan RS luar.

c. Tabel Data Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS)

UNIT DAN PENJAMIN	DES 2023		JAN 2024		FEB 2024	
	JENIS RESEP		JENIS RESEP		JENIS RESEP	
	RACIK	NON RACIK	RACIK	NON RACIK	RACIK	NON RACIK
1. Rawat Inap						
Umum	64	622	37	677	28	316
BPJS Kesehatan	195	5437	191	6610	259	7145

BPJS TK	0	0	0	0	0	10
Asuransi Swasta	0	2	0	70	0	41
Jasaraharja	0	2	0	70	0	41
Total	259	6063	228	7427	287	7553
2. Poliklinik						
Umum	285	712	221	450	172	619
BPJS Kesehatan	1752	7808	1913	8582	1735	8011
BPJS TK	0	0	0	0	0	0
Asuransi Swasta	0	3	0	5	0	4
Jasaraharja	0	3	0	5	0	4
Total	2037	8526	2134	9042	1907	8638
3. Kamar Operasi						
Umum	0	10	0	13	0	6
BPJS Kesehatan	0	322	0	398	0	384
BPJS TK	0	0	0	0	0	0
Asuransi Swasta	0	0	0	9	0	10
Jasaraharja	0	0	0	9	0	10
Total	0	332	0	429	0	410
4. IGD						
Umum	89	586	31	346	46	290
BPJS Kesehatan	65	1032	85	1337	81	1288
BPJS TK	0	0	0	0	0	1
Asuransi Swasta	0	1	0	16	0	11
Jasaraharja	0	1	0	16	0	11
Total	154	1620	116	1715	127	1601
Total Resep	2450	16541	2478	18613	2321	18202

Analisis

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah resep masuk di Bulan Februari mengalami penurunan yang tidak signifikan karena jumlah hari hanya 29 hari, tetapi tetap lebih tinggi dibandingkan Bulan Desember 2023.

Perbedaan jumlah resep dapat disebabkan dari berbagai hal seperti kunjungan pasien, jumlah dokter yang tidak praktek atau izin atau cuti, jumlah tanggal merah atau hari libur pada bulan tersebut.

Rencana Tindak Lanjut

1. Meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan kefarmasian sehingga dapat meningkatkan minat pasien untuk melakukan kunjungan ulang ke RS agar jumlah kunjungan dan jumlah resep meningkat setiap bulannya
2. Mempromosikan layanan pengantaran obat melalui media social, banner dan pengumuman melalui mic dengan harga terjangkau untuk menurunkan jumlah antrian pasien di Ruang Tunggu Farmasi.

d. Tabel Data Laundry

NO	UNIT	DES 2023	JAN 2024	FEB 2024
Linen				
1	VVIP	1kg	1kg	0kg
2	VIP	1kg	1kg	3kg
3	Kelas I	39kg	81kg	117 kg
4	Kelas 2	487kg	507kg	486 kg
5	Kelas 3	1677kg	1461kg	1451 kg
6	Maternitas kelas 1	32kg	33kg	30 kg
7	Maternitas kelas 2	287kg	245kg	312 kg
8	Maternitas kelas 3	498kg	669kg	654 kg
9	ICU	19kg	205kg	212 kg
10	Kamar Operasi	2001kg	2230kg	2021 kg
11	Poliklinik	9kg	27kg	34 kg
12	IGD	72kg	75kg	65 kg
13	Laborat	4kg	4kg	5 kg
14	Radioogi	1kg	3kg	3 kg
15	Dapur/Gizi	3kg	3kg	4 kg
16	CSSD	2kg	5kg	4 kg
Total Linen Tercuci		5.133kg	5550kg	5401kg
Bahan Habis Pakai				
1	Alkali	1	1	1
2	Emulsi	1	1	1
3	Oxy	1	1	1
4	Netral	1	1	1
5	Softener	17	26	23
6	Rapika	35	41	24
7	Detergen	6	16	-
8	Pemutih	5	19	17
9	LPG	11	18	20
10	Liquid matic	-	-	8
Total		78	124	96

Analisis

1. Dari tabel diatas diketahui bahwa linen kotor meningkat berbanding lurus dengan peningkatan jumlah kunjungan pasien.
2. Linen kotor paling banyak dari Unit IRNA dengan kelas perawatan kelas 3, dimana total ruangan kelas 3 adalah 49TT dari 140TT.

Rencana Tindak Lanjut

Melakukan pengajuan mesin cuci industry supaya kapasitas lebih besar dan efisiensi waktu

e. Tabel Data CSSD

No	Hal	DES 2023	JAN 2024	FEB 2024
1	Chemical Alcalide	1000ml	1500ML	1500ml
2	Chemical Alkazyme	20pcs	21pcs	37pcs
3	Kassa Masuk	34roll	54roll	54roll
4	Kassa Keluar	1691pouches	1899pouches	2130pouches
5	BHP Pouces	6roll	5.5roll	5roll
6	Indikator Adhesive	3roll	1roll	1roll
7	Indikator Strip Steam	3box	2box	2roll

Alat yang disetor				
8	Unit IKO	360set	391set	376set
9	IRJA	132set	101set	87set
10	IRNA 5C	3set	7set	4set
11	IRNA 3A dan 4A	4set	5 set	4set
12	IRNA 3C ANAK	1set	2 set	0set
13	IRNA 6A, 7A dan 8A	9set	8 set	4set
14	IRNA 2C VIP	1set	4set	3set
15	IRNA ICU	3set	10set	11set
16	IGD	141set	126set	149set
17	MATERNITAS	200set	203set	179set
18	PERINA	88set	108set	112set
Jumlah		942set	965set	929set

Analisis

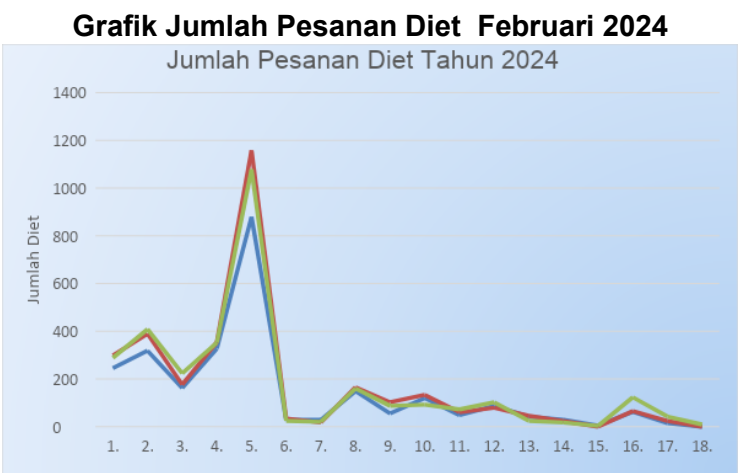
Jumlah alat yang disterilisasi paling banyak dari Unit IKO dengan jumlah setor alat dalam 3 bulan terkahir yaitu sebanyak 1.127 set, diikuti dari Unit Maternitas 582 set dan IGD 416 set. Dimana dari ketiga unit tersebut paling sering melakukan tindakan.

Rencana Tindak Lanjut

- Memperbaiki pencatatan keluar masuk alat bersih dan kotor.
- Pendistribusian kasa steril dalam bentuk pouches terpusat di Gudang Farmasi, dengan jadwal permintaan BMHP seminggu 2x.

f. Tabel Data Instalasi Gizi

NO	NAMA DIIT	JUMLAH PESANAN DIET			PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA (%)
		DES 2023	JAN 2024	FEB 2024	
1	Diabetes Melitus	245	298	288	97
2	Rendah Garam	318	389	408	105
3	Jantung	162	176	223	127
4	Rendah serat	327	354	352	99
5	TKTP	879	1158	1079	93
6	Makanan biasa	29	34	24	71
7	Makanan Lunak	28	17	20	118
8	Rendah Lemak	149	165	160	97
9	Rendah Protein	55	102	87	85
10	Bubur Halus	120	133	92	69
11	Cair	48	60	72	120
12	Rendah Purin	87	79	102	29
13	Tinggi Protein	42	45	24	53
14	Blender	29	23	17	74
15	Tinggi serat	4	0	3	0
16	Tinggi Kalsium	62	65	123	189
17	Rendah Kalsium	15	24	42	175
18	Rendah Sisa	0	0	9	0
Total		2599	3122	3125	100



Analisis

Jumlah pasien yang rawat inap meningkat sehingga mempengaruhi jumlah pemberian diet pasien di rawat inap.
Dari hasil survey kepuasan pasien terhadap menu makanan tidak ditemukan penurunan kepuasan terhadap variasi makanan.

Rencana Tindak Lanjut

Koordinasi dengan humas dan marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien rawat inap. Evaluasi kembali terkait kepuasan pasien terhadap variasi menu makanan.

g. Instalasi Rekam Medis

Tabel Daftar 10 besar penyakit di Rawat Jalan Pada Bulan Februari 2024

NO	Code ICD 10	DIAGNOSIS	JUMLAH
1	E11	DM Type 2 / Noninsulin-dependent diabetes mellitus	898
2	I11.9	HHD / Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure	567
3	M17	Gonarthrosis [arthrosis of knee]	357
4	I25	Chronic ischemic heart disease	347
5	M54.5	LBP (Low Back Pain)	339
6	R50.9	Febris / Fever, unspecified (Observasi Febris)	317
7	J03	Acute tonsillitis (1003)	287
8	T14	Injury of unspecified body region	269
9	I50.0	CHF / Congestive heart failure	247
10	J44.9	COPD / Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified	235

Analisis

Dari data di atas terbanyak adalah penyakit diabetes melitus dengan jumlah bulan Februari 2024 898 pasien dari data di atas penderita DM mengalami penurunan, pasien di bulan Januari 2024 pasien penderita DM mencapai di angka 900 an.

Rencana Tindak Lanjut

- Menyediakan data pasien dan nomor telepon untuk tindak lanjut ke bagian manajemen, data tersebut bisa dilakukan untuk tindak lanjut ke bagian manajemen seperti melakukan :
 - Diadakan program senam kaki untuk penderita DM
 - Membagikan leaflet tentang senam kaki DM
- Berikut link data pasien yang sakit Diabetes Melitus
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iR8zsxrFcoSHnqD25HwDmUUMbPyDbbe6/edit#gid=827051296>
- Hasil dari follow up humas dan marketing :
 - Senam diabetes melitus nanti bisa di agendakan di acara senam geriatic
 - Program pemeriksaan gula darah juga sudah dilakukan
 - Leaflet mengenai DM sudah tersebar di seluruh unit rawat inap

Tabel Daftar 10 Besar Penyakit di Rawat Inap Februari 2024

DAFTAR 10 BESAR PENYAKIT			
NO	KODE	DIAGNOSA	JUMLAH
1	E86	Volume Depletion	72
2	P24.9	Neonatus Aterm	52
3	K21.9	GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE	39
4	A90	Dengue hemorrhagic fever	27
5	J18.9	PNEUMONIA	21
6	063.0	GRAVIDA + KALA I FASE AKTIF	19
7	E14.9	DIABETES MELLITUS	13
8	I63.9	CEREBRO VASKULER ACCIDENT INFARK	11
9	J18.0	BRONCHOPNEUMONIA	11
10	034.2	GRAVIDA + BEKAS SECTION CAESARIA	10

Analisis :
Dari data di atas menunjukkan 72 Volume depletion

Rencana Tindak Lanjut
Dipertahankan peningkatan pasien

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

RS Prima Husada Malang yang selalu berbenah untuk meningkatkan pelayanan baik dari sisi Sumber Daya Manusia ataupun dari sisi sarana dan prasarannya. Dimana masih terdapat beberapa Sumber Daya manusia yang masih belum tertib baik dari kelompok tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang masih belum tertib secara administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimulai dengan penataan SDM yang disesuaikan dengan alur dan tata letak Gedung yang baru, maka dilakukan juga penambahan tenaga khususnya perawat untuk memenuhi kebutuhan setelah dilakukan evaluasi dan analisa beban kerja. Proporsi antara karyawan kontrak/tidak tetap dengan karyawan tetap, dimana masih banyak karyawan kontrak/tidak tetap di RS Prima Husada Malang diperkirakan bisa mempengaruhi kualitas pelayanan di Rumah sakit

Dalam struktur organisasi RS Prima Husada Jabatan Struktural di Tingkat direksi sudah terpenuhi, seperti jabatan Kepala Bidang Pelayanan Medis, Kepala Bidang Penunjang Medis, Kepala Bidang Keperawatan dan Kepala Bagian Umum dan Keuangan. Kebutuhan staf di Unit Humas dan Marketing juga sudah terpenuhi, di harapkan dengan adanya staf tersebut dapat menjalankan program-program rumah sakit yang sudah di jadwalkan dan dapat mencapai target yang di tentukan. Untuk jabatan di beberapa komite sudah terisi seperti di komite Etik RS dan Komite Tenaga Kesehatan Lain yang sudah terisi sehingga permasalahan-permasalahan seputar etik dan tenaga kesehatan lain mulai mendapat perhatian dari manajemen.

Kepatuhan DPJP dalam memvisite pasien dan melengkapi dokumen Rekam medis yang masih jauh dari standar juga mempengaruhi kualitas pelayanan di RS Prima Husada Malang dan menghambat proses klaim. Kinerja RS dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal Rumah Sakit. Jumlah kunjungan di RS Prima Husada Malang masih didominasi oleh kunjungan pasien lama dari BPJS Kesehatan. Pelayanan di beberapa unit yang belum optimal dikarenakan salah satu dampak kekurangan tenaga kerja karena beberapa karyawan yang dirumahkan membawa akibat pada pelayanan.

B. SARAN

1. Meningkatkan ketertiban administrasi di Unit SDM terutama ketertiban absensi dengan memanfaatkan SIM SDM yang baru
2. Membentuk dan mengoptimalkan kinerja dari komite – komite yang ada di RS Prima Husada Malang
3. Meningkatkan kepatuhan visite DPJP dengan mencatat dan melaporkan waktu visite DPJP serta menterbitkan DPJP dalm pengisian Dokumen Rekam Medis
4. Memperbaiki proses rekrutmen staf sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan
5. Meningkatkan skill dan pengetahuan SDM dengan giat mengaktifkan diklat dan pelatihan internal serta mengikuti pelatihan secara eksternal
6. Meningkatkan marketing dan promosi untuk meningkatkan kunjungan ke RS Prima Husada Malang
7. Menjalin lebih banyak kerjasama dengan stakeholder dari luar RS Prima Husada Malang

BAB VI
PENUTUP

Demikian laporan bulan Februari 2024 ini kami buat sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Rumah Sakit Prima Husada Malang pada bulan Februari 2024, masih ada beberapa target yang belum tercapai sesuai standard namun upaya selalu kami lakukan secara terus menerus. Perbaikan dan pengembangan pelayanan akan terus kami lakukan seoptimal mungkin.

Malang, 06 Maret 2024
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang



dr. Nur Mazidah